

6단원

산욕기 여성

- I 정상산욕 간호
- II 모유수유
- III 고위험 산욕 간호
- IV 출생 직후 신생아 간호

I 정상산욕 간호

- 1장 출산후 생리적 변화와 적응
- 2장 산모 간호
- 3장 출산후 부모의 사회심리적 적응

1장 출산후 생리적 변화와 적응

● 학습목표

- 산모 생식기계의 적응과정을 설명한다.
- 오로의 양상에 대해 설명한다.
- 산후통을 설명한다.
- 산모의 신체기관별 생리적 적응을 설명한다.
- 수유모와 비수유모의 내분비계 적응과정을 설명한다.

● 주요 목차

- 1. 생식기계
 - 자궁
 - 자궁경부
 - 질과 회음부
 - 난관과 인대
- 2. 심혈관계
- 3. 조혈계
- 4. 호흡기계
- 5. 비뇨기계
- 6. 소화기계
- 7. 근골격계
- 8. 신경계
- 9. 피부계
- 10. 내분비계

● 주요 용어

갈색오로	lochia serosa
만기 울유	late engorgement
백색오로	lochia alba
산욕기	postpartum/puerperium
산후통	afterpains
울유	breast engorgement
자궁저부 높이	height of fundus
적색오로	lochia rubra
퇴축	involution
1차적 울유	primary engorgement
2차적 울유	secondary engorgement

산욕기(puerperium, postpartum)란 분만 직후부터 6주간을 말하며 이 시기의 여성을 산모라고 부른다. 이 기간은 모든 신체기관이 임신 이전 상태로 되돌아가는 시기로 생식기관의 퇴축과 수유를 위한 유방의 변화가 함께 일어난다. 퇴축은 정상적인 신체적응과정으로, 이때의 간호는 산후의 회복 및 중년 이후의 건강을 위해 매우 중요하다.

임부는 9개월, 40주 또는 280여 일이라는 긴 여정이었던 임신 기간 동안 신체·심리·사회적으로 대단히 많은 변화를 경험한다. 이에 비해 산욕기 때 임신 이전으로 되돌아가는 변화는 출산 직후 바로 시작되어 6주라는 짧은 시간에 이루어진다. 이 시기는 산모의 건강에 매우 중요한 기회이자 더욱 많은 지지와 교육이 요구되는 때이다.

축(involution)에 의해 빠르게 줄어든다. 이것은 자궁의 수축과 각각의 자궁 근육세포의 크기 감소, 그리고 자궁의 단백질 성분이 흡수되기 쉬운 성분으로 분해되는 자가분해과정을 통해 이루어진다. 이때 근육세포의 크기만 감소하고 자궁근육의 총 세포 수에는 변화가 없다.

(1) 자궁의 퇴축

자궁은 분만 직후에 줄어들지 않고 늘어서 있으며 무게는 약 1,000g 정도이다(그림 6-1-1). 자궁내막의 점막층은 탈락막(decidua)이 떨어지게 되는데, 특히 태반이 부착되었던 부위는 표면에 혈전들을 동반한 정맥들이 노출된 상태로 되어 있어 완전 회복에는 6주가 소요되며 회복에 장애가 오면 후기 산후출혈이 나타날 수 있다. 태반부착 부위는 산욕기 동안에 현저한 퇴행성 변화를 보인다. 산욕기 동안 자궁의 크기는 현저히 줄

1. 생식기계

1) 자궁

자궁(uterus)은 태반만출 직후부터 거의 단단한 조직으로 변하고 앞뒤의 두꺼운 자궁벽은 내부 공간이 평평해지면서 서로 가깝게 위치하게 된다. 분만 후 2일까지는 자궁의 크기에 별다른 변화가 없지만 그 후에는 퇴



그림 6-1-1. 분만에 따른 자궁의 크기와 모양의 변화

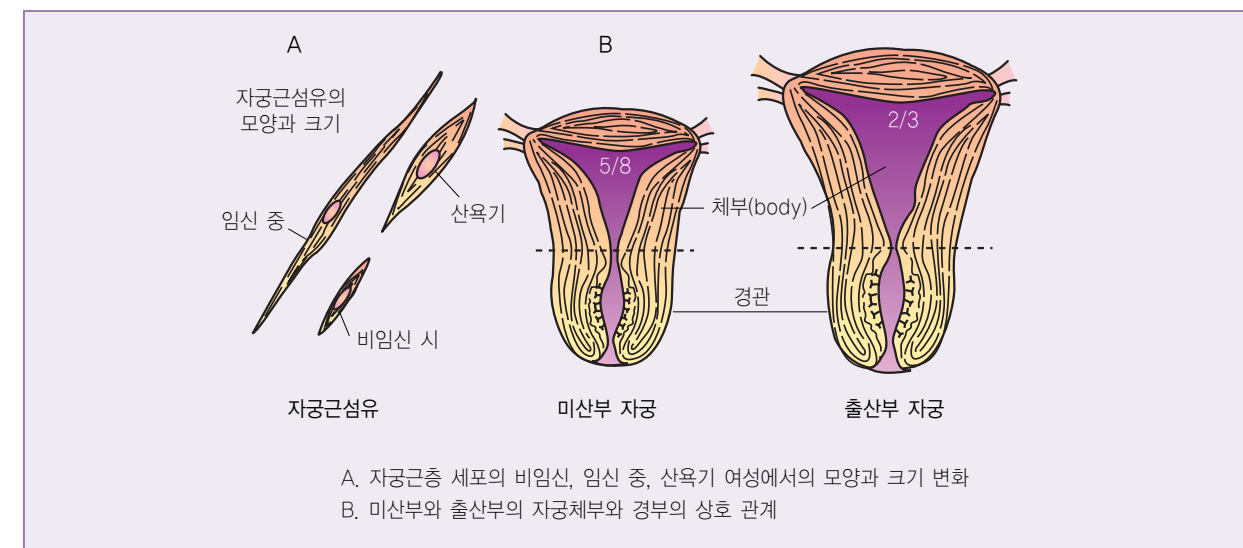


그림 6-1-2. 임신에 따른 자궁근육의 변화

어들며, 무게는 약 60g 정도 된다. 자궁내막 표면은 상피화가 일어나서 정상 생식기 기능을 시작할 수 있도록 준비된다. 자궁의 퇴축성 변화들은 다음의 3가지 중요한 과정에 의하여 이루어진다.

- 자궁근섬유의 수축과 견축
- 자궁벽세포의 단백질질들의 자가분해(autolysis)와 용해
- 자궁내막의 재생(regeneration of endometrium)

① 자궁근섬유의 수축과 견축

임신과정에서 태아의 성장으로 인해 늘어나고 얇아져 있던 자궁근섬유는 태반만출 후 자궁근육은 즉시 수축되고, 자궁벽은 두꺼워지며, 전벽과 후벽이 서로 밀착

된다(그림 6-1-2). 자궁저부와 체부는 수축되어 치골 결합과 배꼽 사이에서 쉽게 촉진할 수 있다. 자궁수축은 자궁 내 잔여물질을 밖으로 배출하고, 산후 출혈을 예방할 수 있는 근원이 된다. 즉, 자궁의 수축으로 태반이 부착되었던 부위의 혈관이 수축되어 출혈을 막을 수 있다. 따라서 자궁이 잘 수축되면 분만 후 과다한 자궁출혈의 위험이 적어진다. 퇴축과정은 급속히 진행되어 분만 직후 자궁의 무게는 약 1kg, 1주일 후에는 약 500g, 퇴축이 거의 다 끝나갈 6주 후에는 40~60g으로 줄어드나(표 6-1-1) 미산부보다 작아지지는 않는다. 자궁의 크기가 줄어드는 속도는 자궁저부의 높이와 배꼽과의 상호관계로 예측할 수 있다. 분만 직후 자궁저부는 대개 배꼽 아래에 있으나, 분만 12시간 후에는 상

표 6-1-1. 자궁 크기의 복구와 자궁내막 치유과정

산욕기간	자궁의 무게	태반 부위의 상처	자궁경부
분만 직후	1,000g	7~8cm	유연하고 축 늘어짐
1주후	500g	6~7cm	내자궁구 2cm
2주후	350g	3~4cm	내자궁구 1cm
6주후	60g	1~2cm	길쭉한 입구 모양

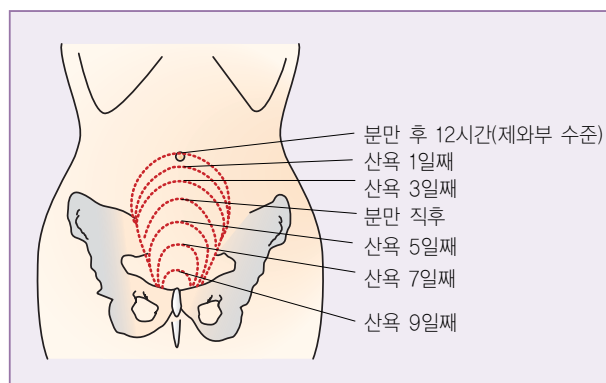


그림 6-1-3. 분만 후 자궁저부 높이 상태

승되어 배꼽 위에서 만져진다. 이때 자궁저부가 상승되는 이유는 분만으로 압박되었던 골반저부의 근육이나 방광 근육의 긴장도가 산후에 정상으로 돌아오기 때문이다. 그 후 자궁은 서서히 줄어들어 골반강 내로 하강하게 된다. 산후 자궁저부의 높이(height of fundus)는 매일 손가락 하나 폭(약 1cm)만큼씩 낮아진다. 그러므로 분만 후 첫날은 배꼽 1cm 아래에서 자궁저부가 만져지고, 2일에는 2cm 아래에서, 분만 후 10~12일이 되면 복벽에서 만질 수 없게 된다(그림 6-1-3).

자궁의 퇴축은 초산모(primipara)와 수유모에서 빨리 일어난다. 초산모에서 자궁 퇴축이 빠른 것은 자궁 근섬유들이 탄력성이 높아 자궁근육의 수축성이 좋기 때문이다. 또한 수유모는 모유를 먹이는 동안 뇌하수체 후엽에서 옥시토신이 분비되어 자궁수축을 초래하기 때문이다.

② 자궁벽세포의 단백질질 자가분해

자궁벽세포의 자가분해(autolysis)는 자궁의 크기가 줄어들고 잔여물이 배출되는 중요한 기전으로 자궁근섬유들의 축소가 일어난다. 자가분해 과정은 자궁세포들의 단백질질 내에서 일어나며, 단순요소들은 환원되어 혈중으로 흡수되고, 잔여물은 소변으로 배출된다. 분만 후 며칠 동안 요중 질소 함량이 증가되는 것은 단

백분해효소들의 배출 때문이다. 자가분해되는 자궁근섬유세포들은 극히 적은 부분이므로 전체 근섬유세포의 감축은 크게 일어나지 않는다.

③ 자궁내막의 재생

자궁내막의 변화는 태반부착 부위와 그 이외의 부위가 다르게 나타난다. 분만 시 탈락막의 스펀지층에서 태반과 난막이 박리되고 자궁내막에는 탈락막의 기저부분이 남게 된다. 태반부착 부위는 자궁내막의 다른 부위보다 개방된 상처가 깊고 크며, 출혈성 상처 표면에서는 혈액이 스며나와 세균 감염의 소인이 된다. 분만 후 2~3일에 자궁내막의 두 층은 차이를 나타내는데, 표면층은 백혈구의 침투와 육아조직을 형성하여 괴사되어 떨어져, 자궁 근육층에 인접한 내층만 남게 된다. 남아 있는 내층의 기저층에는 결체조직과 자궁내막선이 근간을 이루며, 여기에서 새로운 자궁내막이 재생된다. 자궁내막의 재생은 태반부착 부위를 제외한 부분은 급속히 진행되어 3주면 완치되지만 태반부착 부위의 치유과정은 7주가 되면 완전히 이루어진다.

(2) 오로

오로(lochia)란 자궁내막의 재생이 이루어지는 회복 과정에 따라 나오는 분비물이다. 초기 분비물은 주로 혈액성분으로 태반부착 부위로부터 탈락된 세포조각, 탈락막의 조각, 양수, 솜털, 태지, 소량의 점액을 포함한 것으로 혈액이 주된 성분이다. 이 분비물은 3일 정도 나오는데 이것을 적색오로(lochia rubra)라고 한다. 자궁내막 표면으로부터 혈액성분이 줄어들게 되면 분비물은 장액성으로 묽게 변하고 색깔이 점점 분홍빛에서 갈색으로 변한다. 즉, 혈액성분이 적고 혈장성분이 대부분이며, 백혈구와 유기체가 섞여 있다. 이 분비물은 분만 후 4~10일 사이에 분비되며 이것을 갈색오로(lochia serosa) 또는 장액성 오로라고 한다. 분만 후

10일 정도 지나면 오로는 점점 색이 흐려지고 그 양도 많이 줄어들어 크림색을 띠며 성분은 주로 백혈구, 유기체, 자궁경부 점액들로 이것은 10~20일 사이에 분비되며 백색오로(lochia alba)라고 한다. 질 분비물은 3주 정도 지나면 거의 사라진다. 오로는 알칼리성으로 독특한 냄새가 난다.

(3) 산후통

산후통(afterpains)이란 분만 후 자궁에 간헐적 수축이 일어나는 것을 말한다. 산후통은 자궁 내부로부터 응고된 혈액을 배출시키기 위해 능동적으로 자궁이 수축할 때 느끼는 통증이다. 산후통은 처음에는 15~30분 간격으로 시작되었다가 차츰 간격이 느려지면서 대개 분만 48시간 이후에는 사라진다. 산후통은 경산모에게서 흔한데, 그 이유는 과거 출산으로 인해 자궁근의 강도가 약해져서 자궁이 수축상태를 유지하지 못하기 때문이다. 초산모의 경우에는 자궁근의 강도가 강하여 자궁근이 수축된 상태를 유지하므로 거의 산후통을 호소하지 않는다. 그러나 여러 번 임신했다거나 쌍태아 분만 또는 양수과다증과 같이 자궁이 과다하게 신전되었을 때는 간헐적인 수축이 일어나 산후통을 유발한다. 산후통은 모유수유 시 신생아가 유두를 빠는 작용을 통해 뇌하수체 후엽에서 옥시토신이 분비될 때도 발생한다. 옥시토신은 유방에서 초유와 유즙을 짜내는 유관을 수축시키고 더불어 자궁근을 수축시키는 작용을 한다.

2) 자궁경부

분만 직후의 자궁경부(cervix)는 늘어져 있고 그 강도가 약해져 유연하고 약간 부은 듯하며 작은 열상이 많아 감염되기 쉽다. 이때 자궁경부는 손가락 두 개가 들어갈 정도로 개대되어 있으며 두께는 1cm 정도이나 산후 24시간 정도면 빠르게 짧아지고 단단하고 두꺼워진다. 자궁경부의 입구(cervical os)는 수일 내에 2~3cm

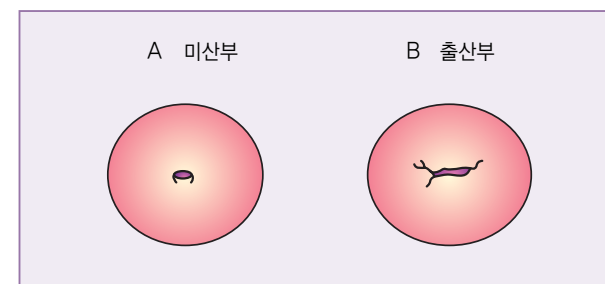


그림 6-1-4. 미산부와 출산부의 자궁경부

정도로 좁아지며 1주 이내에 1cm 정도로 줄어든다. 분만 직후 조직학적 검사를 해보면 전반적으로 자궁경부는 부종과 출혈이 있음을 알 수 있다. 빠르면 분만 후 4일경부터 선의 비대와 비후(glandular hypertrophy & hyperplasia)가 퇴화되고 세포간질 내의 출혈이 흡수되기 시작한다. 자궁경부의 퇴축은 6주 이상 소요되며 자궁경부의 부종과 주위 세포의 침윤은 3~4개월까지 남아 있기도 한다.

질 확대경(colposcope)으로 자궁경부를 보면 분만 후 수일간 괴사, 파열, 좌상(bruising), 그리고 황색 부위 등을 관찰할 수 있다. 이런 부위들은 4mm 이하로 작고 초산모에게서 흔히 볼 수 있다. 6~12주 사이에 재검진하면 거의 완전히 회복된 것을 볼 수 있는데 이는 상처조직의 재생피화가 빠르게 이루어지기 때문이다. 자궁경부의 열상은 섬유아세포의 증식으로 회복된다. 산욕 초기에 원주상피세포층이 뒤집혀진 외번증(ectropion)을 볼 수 있다. 자궁경부가 회복되는 과정에 외번증이나 열상이 있었다면 입구가 옆으로 길쭉한 모양으로 남아 마치 물고기 입 모양같이 보인다(그림 6-1-4).

3) 질과 회음부

질은 분만으로 부드러워지고 약간 종창되고 강도가 약해진다. 임신과 출산으로 인해 생겼던 혈관 생성, 부종, 비대는 3주 후 현저히 떨어진다. 현미경을 통해 질세포를 보면 산후 3~4주에 상피세포가 위축된 상태이

나 6~10주가 되면 에스트로겐 수치가 회복된다. 에스트로겐의 결핍은 질 분비물을 감소시키고 정맥충혈을 저하시켜 산후 몇 주 동안 산모의 성적 반응이 떨어진다. 출산 후에 질 하부에서 열상을 많이 보게 되는데, 초산모의 경우 근육층과 근섬유조직까지 손상을 입을 수 있으나 대부분 산후 6주에 회복이 된다.

질 추벽(rugae)은 분만 후 4주 정도에 회복되나 평평한 상태를 유지할 수 있어 임신 전처럼 뚜렷하지 않다. 난소기능이 회복되면 질 점액은 다시 증가하는데 수유 또는 다음 생리할 때까지 저하되는 것을 볼 수 있다. 분만 직후 질구는 붓고 충혈된 상태인데 열상을 입었거나 회음 절개 시에는 더 심할 수 있다. 감염이나 혈종이 없으면 회음이나 질구는 빨리 회복된다. 대부분의 여성들은 1개월이 지나면 회음부 통증이 사라지나 회음부의 불편함은 6개월까지 지속될 수 있다. 성생활은 산모의 반 이상이 2개월쯤이면 할 수 있지만 불편함이 없으면 3개월은 되어야 한다. 회음부와 질구의 회복은 질 열상, 감자분만, 산후 4일 이상 지속되는 부종, 질 감염이 있을 때는 늦어진다.

4) 난관과 인대

난관(fallopian tube)의 조직학적 변화는 분비세포의 크기 축소, 섬모세포의 크기 및 수의 감소, 난관 상피세포의 위축을 볼 수 있게 한다. 6~8주가 지나면 상피세포는 생리주기의 난포기 상태에 이르게 된다. 산후 4일 경에 비세균성 염증이 난관 내에 나타날 수 있다. 자궁과 난소 및 난관을 지지하는 인대(ligament)들은 임신 중에는 심하게 당겨지고 신전되었으나 분만 후에는 이완된다. 이 인대들이 원상복귀하려면 2~3개월 정도의 시간이 걸린다.

2. 심혈관계

심혈관계 변화는 임신으로 인해 초래되었으나 산후 2주 정도면 사라진다. 분만 후 며칠 내에 혈압, 심박동, 산소 소모, 그리고 총 체액은 임신 전 상태로 회복된다. 그 외에 다른 변화들이 회복되려면 몇 주가 더 소요되기도 한다.

1) 혈액량

혈액량은 임신 중에 40%, 약 1,000ml가량 증가하여 전체 혈액량이 5~6ℓ 정도가 된다. 분만 후 혈액량의 변화는 분만 시의 실혈과 분만 후 이뇨현상 때문에 초래된다. 정상분만의 경우 평균 실혈량은 400~500ml 정도이다. 제왕절개를 통한 분만일 경우에는 1,000ml, 제왕절개술과 자궁절제술을 겸한 경우 1,500ml까지도 출혈이 될 수 있다. 분만 후 신체 변화는 실혈을 보상하고 보호적 효과를 위해 나타난다. 태반의 내분비기능 감소는 혈관 확장을 저하시킨다. 분만으로 인해 자궁과 태반 순환이 끝남으로써 모체 측 혈관이 10~15% 정도 감소하며 혈관 외액은 신장으로 배설되기 위해 이동한다. 따라서 혈액량은 분만 후 급속하게 변화가 일어나 순환되는 혈액량이 12~48시간 사이에 일시적으로 15~30%까지 증가된다. 이런 현상은 혈관 외액의 집합과 이뇨작용의 결과이며 이로 인해 혈액확장효과를 나타내어 적혈구 용적률(hematocrit)이 떨어지고 심박출량은 증가된다. 분만 후 3일경에는 임신으로 인해 증가했던 혈액량이 16% 정도 감소하며 2~4주에 걸쳐 점차 줄어들어 4주경이면 전체 혈액량은 임신 전 상태인 4ℓ 정도로 회복된다.

2) 심박출량

심박출량(cardiac output)은 분만 시에 증가하는데, 특히 태반이 박리된 직후에 가장 많은 양이 박출된다.

이것은 자궁수축으로 순환혈액 내에 다량의 혈액이 유입되기 때문이다. 임신으로 인해 증가된 1회 박출량은 분만 후 48시간 동안 증가된 상태를 유지하는데, 이것은 태반순환의 상실로 인한 정맥귀환 증가와 자궁 순환량의 감소에 의한 것이다. 여기에 분만 후 이뇨효과로 인한 일시적인 순환혈량의 증가현상이 겹쳐져 산욕 초기에 35% 정도의 심박출량이 증가하게 된다. 심박출량은 분만 후 2주 이내에 30%가량 감소하고 3주경에는 임신 전 수준으로 회복된다.

3) 혈압과 맥박

혈압은 정상상태에서는 거의 변하지 않지만 산후 48시간에 내장의 울혈(splanchnic engorgement)로 기립성 저혈압이 나타난다. 맥박은 산후 24~48시간 동안 일시적으로 생리적 서맥(40~50회/분)이 나타난다. 이 현상은 혈액 역동성 변화에 의한 것으로, 1회 박출량과 심박출량이 함께 증가된다. 이는 분만 동안 증가된 교감신경계의 활동에 대한 미주신경의 반사작용에 의한 것이다. 경한 서맥(50~70회/분 정도)은 대개 1주일간 지속된다. 심박동수는 대개 산후 3개월쯤에 임신 전의 상태로 회복된다.

3. 조혈계

산욕 초기에 적혈구, 헤마토크리트, 혈색소의 변화로 간질액이 모여 혈액희석이 발생한다. 그러다 이뇨작용으로 혈장이 배설됨에 따라 혈액농축과 더불어 적혈구 용적률(hematocrit)이 분만 후 3~7일 이내에 상승하게 된다(혈장 소실량이 혈구 소실량보다 더 많기 때문). 임신 중의 적혈구의 증가는 적혈구 용적률을 상승시키는 요인 중 하나이다. 적혈구는 산욕기 동안 파괴되지 않으나 임신 중에 증가되었던 적혈구가 수명이 다해가

면서 점차 정상 수준을 되찾게 된다. 적혈구 용적률은 산욕기 4~5주 정도에 임신 전의 상태로 회복된다. 백혈구(WBC) 수치는 정상임신에서 12,000/mm³까지 증가한다. 산후 10~12일에는 백혈구증다증(leukocytosis, 20,000~30,000/mm³)을 볼 수 있는데 이때 특징적인 것은 중성구와 호산구는 증가하고 림프구는 감소하는 것이다. 산후에는 백혈구의 증가와 더불어 적혈구 침강률(erythrocyte sedimentation rate)의 증가까지 나타나기 때문에 산후감염과 구별하기가 쉽지 않다.

임신 중 증가된 응고요인은 산욕기까지 계속된다. 산후에도 응고요인 I, II, VIII, IX, X 등이 광범위하게 활성화되나 이들은 수일 내에 저하되며, 섬유소원(fibrinogen)과 트롬보플라스틴(thromboplastin)은 산후 3주까지 증가되어 있다. 이 상황에서 산모가 활동을 하지 않고(immobility), 외상이 생기면 이것은 산후 혈전성 색전증의 전구요인이 될 수 있다. 임신 중에 상승된 에스트로겐은 단백질과 지방합성을 증가시키고 그로 인해 지방산(fatty acid), 콜레스테롤, 중성지방(triglycerides), 지방단백(lipoproteins)과 응고요인이 증가된다. 이런 성분들은 산후 2~3주 정도에 임신 전 상태로 회복된다. 배뇨증진 동안 세포외액의 급격한 분비로 혈청 전해질 균형이 변하게 된다.

4. 호흡기계

호흡기계는 임신 동안과 산후에 변화가 생기는데 임신 후반기에는 이산화탄소 분압 저하와 한 번에 폐에 들어가는 공기량인 1회 호흡용적의 감소로 인해 호흡곤란이 생긴다. 반면에 산후에는 복압의 변화와 자궁 크기의 감소로 복강 내의 장기가 임신 이전의 위치로 돌아가 흉곽 용적이 증가하게 된다. 복압과 흉곽 공간의

변화는 호흡기계 기능의 변화를 초래한다.

최대로 공기를 배출하였음에도 불구하고 폐포 속에 공기가 남아 있는 공기용적인 잔기용적(residual volume)과 호기성 예비용량과 잔기량을 합한 기능적 잔기용량(functional residual capacity)은 급속하게 정상화되나, 안정 호기 후에 최대로 내뿜을 수 있는 공기용적인 호기성 예비용적(expiratory reserve volume)과 흡기용량(inspiratory capacity), 폐활량(vital capacity)은 서서히 정상화된다. 잔기용적, 안정 호흡, 산소소모 등은 증가하고 흡기용량, 폐활량, 그리고 최대 호흡용량(maximum breathing capacity) 등은 감소한다. 호흡기능은 산후 6개월경 임신 전 상태로 회복된다. 그러므로 이 기간 동안에는 산모가 운동에 대해 반응하는 능력이 떨어진다. 분만과 산욕기 초기에는 산-염기 균형도 변한다. 프로게스테론은 임신 중 폐포에서 과호흡이 일어나도록 하므로 호흡수에 관계없이 산소포화도가 증가하게 된다. 폐포에 이산화탄소 포화도가 낮아져서 생긴 호흡성 알칼리증과 그에 대한 보상기전인 대사성 산증은 임신 시 특징적으로 나타난다. 분만 제1기가 끝날 때에 이러한 변화들은 혈중 젖산의 상승, pH의 저하, 탄산부족증(hypocapnia, <30mmHg) 등으로 인해 완화된다. 이러한 상태는 산욕 초기까지 지속되지만 수일 내에 정상범위(PCO₂, 35~40mmHg)를 유지한다. 프로게스테론의 저하는 산욕기 탄산과다증(hypercapnia)을 초래하고, 염기과다와 혈장 중탄산염을 동반한다. 점차적으로 pH와 염기과다는 정상범위까지 상승하여, 산후 3주경에 회복된다. 기초대사율은 산후에도 1~2주 동안은 계속 상승된 상태를 유지한다.

산소포화도와 PO₂는 임신 동안 더 높다. 분만 중에 산부가 특히 양와위를 취하면 심박출량이 적어져 산부는 산소포화도가 떨어지는 것을 경험하게 된다. 산소포화도는 분만 후 급속히 회복되어 산후 첫날에 95%까지

회복이 가능하다. 분만 후에 산소부재가 분만 2기의 소요시간과 난산 여부와 관계되어 발생할 수 있다. 이 시기 동안에는 안정 시 산소 소모가 증가되는데 그것은 수유, 빈혈, 정서적, 심리적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있다.

5. 비뇨기계

임신 중에는 스테로이드 호르몬의 분비가 많아져 신장기능이 증가하였으나 분만 후에는 스테로이드 호르몬 분비의 감소로 일부 신장기능이 떨어진다. 비뇨기계 구조의 저긴장성과 확장은 3개월 동안 유지된다. 분만 후에 수뇨관과 신우는 확장된 상태로 있다가 3~6주 후(때로 8~12주) 정상으로 회복된다. 산후 6주가 되면 신장의 혈액량, 사구체 여과율, 혈장 크레아티닌, 질소는 임신 전의 상태로 회복된다.

1) 요도와 방광

방광과 요도는 태아가 산도를 통과하는 과정에 외상을 받을 수 있다. 분만 후에 방광점막은 부종과 충혈의 정도가 다른 물론 방광근의 강도(tone)도 떨어진다. 이런 결과로 방광의 압박에 대한 감각력이 떨어지고 방광 용적은 늘어나게 된다. 조직의 부종과 충혈, 더불어 진통제의 영향으로 요의를 잘 느끼지 못한다. 또한 골반부의 아픔도 추가적으로 배뇨반사를 떨어뜨린다. 산후 이뇨현상은 방광을 급속히 채우게 되므로 방광이 과도 팽창되어 요실금이 되기도 하고 또 배뇨를 충분히 못하여 잔뇨증을 초래하기도 한다. 잔뇨는 방광의 감염 기회를 더 높이며 정상적인 배뇨도 방해한다. 따라서 산모 간호에서 유의하여야 할 사항은 감염뿐만 아니라 방광팽만, 소변정체가 초래되기 쉽기 때문에 방광 상태를 주의깊게 관찰해야 한다. 방광근의 강도는 산후 5~

7일 경에 회복되어 배뇨가 원활해진다.

2) 이뇨작용

임신 동안의 수분대사가 역전되는 것은 스테로이드 호르몬의 저하와 산욕기의 퇴축과정에 의해 이루어진다. 동화과정은 혈중 요질산의 증가, 단백뇨, 그리고 때때로 아세톤뇨에 의해 이루어진다. 혈액량과 호르몬양의 변화는 산욕기의 이뇨작용, 신사구체 여과율(glomerular filtration rate, GFR), 혈청 전해질에 영향을 미친다. 이뇨작용은 산욕기 첫 2~3일에 발생하는 것이다. 신장의 혈장흐름과 신사구체 여과율은 산후 첫 1주 동안 증가되고 더불어 혈량도 증가됨에 따라 배뇨량은 산후 12시간이 지나면서 증가하여 1일 3,000cc 정도가 된다. 이 시기에 발한(perspiration) 역시 증가한다.

체액균형의 변화로 산모는 산욕기 동안 10ℓ 이상의 체액이 소실된다. 산후 첫 주에 2ℓ, 나머지 5주 동안 체액이 1주일 1.5ℓ 씩 소실되게 된다. 이러한 수분 손실로 인해 산욕기 동안 4kg 정도의 체중 감소가 있다. 산욕 초기에 산모의 약 20%에서 당뇨가 나오나 이내 사라진다. 정상인 수유모에서 유당이 소변(lactosuria)에 나올 수 있다. 경증의 단백뇨(1+) 또한 1~2일간 약 50%의 산모에서 볼 수 있다. 아세톤(acetonuria)도 요중에서 볼 수 있는데 이는 지방대사 변화와 탈수로 인해 초래될 수 있다.

6. 소화기계

위장계의 운동성과 근육의 긴장도는 산후 2주 이내에 정상상태를 회복한다. 대부분의 여성이 2~3일 내에 심한 갈증을 호소하는데, 이것은 분만 시의 수분 손실 및 이노와 관계된 순환, 간질공간(interstitial space) 사이

에서의 수분 이동 때문이라 여겨진다. 대부분의 여성들이 분만 후 배고픔을 느끼는데 이때 가벼운 식사나 수분을 섭취할 수 있다. 분만으로 인한 피로와 진통제, 마취제의 효과에서 회복된 후에는 대부분의 산모들은 식욕이 좋아져 많은 양의 식사를 하게 된다.

1) 장 배설

산욕기 초기에는 변비가 흔히 생기게 되는데 이는 임신으로 인해 장이 이완되고, 복근이 팽창되어 배설을 돕지 못하기 때문이다. 이런 생리적 이유 이외에도 분만 과정 중의 금식과 분만 전 관장, 분만 시 투여된 약물 등이 상태를 더 악화시키기도 한다. 분만 후 2~3일간은 자연적인 장 배설이 지연될 수 있다. 치질, 회음절개술, 회음부 열상으로 인한 통증 때문에 변비는 더욱 심해지게 된다. 대부분의 산욕기 여성들이 변 완화제를 복용하여 배변을 돕기도 한다. 장의 탄력성이 회복된 후에 산모는 규칙적인 배변습관을 가질 수 있다.

2) 체중 감소

체중은 분만 직후 5kg 정도 감소하는데 태아, 태반, 양수, 실혈 등의 무게를 포함한다. 또 다른 4kg 정도의 체중 감소는 분만 후 1주 동안의 자궁퇴축, 오로, 발한, 이뇨작용 등으로 일어나게 된다. 분만과 산욕기를 통해 감소되는 산모의 체중은 약 10kg 정도이다(표 6-1-2).

표 6-1-2. 산욕기 동안의 체중 감소 분포

체중 감소 원인	감소 체중(kg)
분만된 태아, 태반, 양수, 실혈	5.5~6
산욕기 첫주의 발한 및 이뇨작용	2.5~4
자궁퇴축 및 오로	1.0
총 체중 감소	9~10

7. 근골격계

1) 골반근육

자궁과 질을 지지하고 있는 근육과 근육층 지지구조들은 출산 시에 손상을 받아 자궁, 질벽, 직장, 요관, 그리고 방광을 지지하는 구조들이 늘어나고 약화되며 이완을 초래한다. 골반구조의 이완은 출산이나 성관계를 경험하지 않은 여성에게서도 볼 수 있으나 대부분 출산 과정 중의 손상으로 나타난다. 골반이완에는 직장류(rectocele), 탈장(enterocele), 자궁탈수(uterine prolapse), 요도류(urethrocele), 방광류(cystocele)가 포함된다. 골반이완은 근다발(muscle bundles)의 팽창과 분리, 근육층 파열, 그리고 지지구조의 확장과 손상으로 초래되며 시간이 지날수록 악화되는 경향이 있다. 골반근의 탄력은 재채기나 기침과 같은 갑작스런 복압 상승 시 올 수 있는 요실금을 방지하는 데 효과적이다. 요도의 평활근과 골반근육들은 수의적인 조절이 가능하며 이들 근육이 강화되면 배변조절이 원활하게 된다. 임신이 반복되면 골반근육은 이완될 가능성이 높아진다. 분만 전 골반근육의 강도가 높을수록 질분만 시에 강한 힘을 줄 수 있다. 분만 후 골반저근훈련(pelvic floor muscle exercise, PFME)을 한 경우에는 골반근육의 회복이 더 빠르다.

2) 복벽

복벽은 분만 후 한동안 부드럽고 축 처진 상태로 남아 있게 된다. 복벽의 탄력성은 회복이 되지만 탄력섬유의 파열로 인해 생긴 임신선은 영구히 남게 된다. 이 임신선은 후에 흰색으로 바뀌어 눈에 잘 띄지 않게 된다. 복강내 구조들의 퇴축과정은 적어도 약 6주 정도가 소요된다. 복벽의 근강도(muscle tone)와 원래 상태로의 점진적인 회복은 임신 시 복근의 강도, 운동, 지방조직의 양에 따라 좌우된다. 그러나 복근이 과도팽창되었거나

복근의 강도가 떨어진 경우에는 복근이 심하게 분리되거나 복직근이개(diastasis of the recti muscles)를 초래하여 복강 내 장기들을 제대로 지지하지 못할 수 있다. 휴식, 식이, 적절한 산후운동 및 좋은 신체기전과 올바른 자세는 복벽근의 회복을 도와준다.

8. 신경계

신경계는 분만 후 가역적인 변화를 보이게 된다. 팽창된 자궁과 양수로 인한 기계적 압력으로 신경에 압박을 가했으나 분만 후에는 회복된다. 임신 동안 서혜부의 인대나 골반벽에 위치한 신경이 압박을 받아 생겼던 대퇴의 저림감이 사라진다. 부종이 감소하고 근막, 건, 결합조직의 물리적 변화로 정중신경 압박이 줄어들어 수근관증후군(carpal tunnel syndrome)도 호전된다. 또 같은 이유로 다리 경련도 사라진다. 임신 동안에 섬유 연골에 영향을 끼치던 내분비계도 산욕기 동안 회복된다.

골반 관절은 비교적 이완되고, 운동성도 증진되지만 분만 후 6~8주경이면 임신 전 상태로 회복된다. 임신 동안에 있던 요통도 사라지지만 산후 신생아를 안아야 하기 때문에 다시 근육이 당겨져 증상은 잘 사라지지 않는다. 커진 자궁으로 생겼던 자세의 변동이 회복되어 허리의 척추전만증(lumbar lordosis)과 척추후만증(kyphosis)이 호전된다. 그러나 수유로 인해 팽창된 유방과 약해진 복벽근육으로 분만 후에 자세가 바르지 못할 수 있다.

9. 피부계

피부의 색소침착을 초래하는 멜라닌 색소가 임신 중에 활성화되어 생긴 유두와 유륜(젖무리, areola), 임신

표 6-1-3. 산후 생리적 변화

기관	변화와 경과기간
자궁	하루에 손가락 하나 넓이만큼씩 퇴축한다. 9~10일 안에 복벽에서 만져지지 않고 골반 내로 들어간다.
경부	1주에 1cm씩 단한다. 내경관샘(endocervical gland)은 산후 4일 이내 퇴축한다. 부종은 3~4개월까지 남아 있다.
질과 질구	추벽(rugae)은 3주 후에 다시 나타난다. 정상 에스트로겐 수준과 윤활작용(lubrication)은 6~10주 후에 돌아온다.
배란과 월경	개인에 따라 다르나 모유수유 여부에 따라 영향을 받는다. 수유하지 않는 산모는 보통 10~12주 후에 첫 배란이 되고, 수유하는 산모는 보통 12~36주 후에 배란된다.
유방	초유를 분비한다. 산후 3~4일에 유즙분비가 되고 일시적으로 울유가 온다.
심장	분만 후 일시적으로 혈액량이 증가되었다가 3일 후에 떨어진다. 4주 후에 비임신상태의 수준이 된다. 분만 후 심박출량(cardiac output)과 일회 박출량(stroke volume)이 증가되었다가 48시간이 지나면 50% 수준으로 떨어졌다가 3주 후에 정상으로 돌아온다.
혈액	혈액 농도가 낮아졌다가 3~7일 후에 헤마토크리트가 증가되고 4~5주 후에 정상이 된다. 10~12일 후에 백혈구가 증가되었다가 2주 후에 정상이 된다. 분만 시 섬유소원(fibrinogen)과 응고요인(clotting factor)이 증가되었다가 3주 후에 정상이 된다. 단백질, 지방, 전해질이 분만 시는 증가되었다가 2주 후에 정상이 된다.
호흡기	잔기용적(residual volume), 안정호흡과 산소소모는 증가하고, 흡기용량(inspiratory capacity), 폐활량, 최대 호흡량은 감소한다. 6개월 후에는 이 모든 호흡기능이 비임신상태로 돌아온다.
비뇨기계	분만 후 12시간 안에 이뇨작용이 있으며, 4~5일 동안에는 1일 3,000ml의 소변이 나온다. 6주 후에 비임신상태로 돌아온다. 방광의 탄력성은 1주일 후 정상을 회복한다.
위장	변비가 2~3일 동안 있다가 1주 안으로 회복된다.
신경근육	대퇴, 손가락 또는 손의 무감각상태가 며칠 내로 없어진다. 요통은 6~8주 안으로 호전된다.

선의 과도착색(hyperpigmentation)은 분만 후 열어진 다. 그러나 임신 이전의 상태로 완전히 되돌아가지 않아 일부 여성들은 착색된 상태를 유지하기도 한다. 기미(chloasma)는 완전히 없어지지는 않으나 분만 후 많이 호전된다. 분만 후 에스트로겐 수치가 저하되면서, 확장된 혈관으로 생겼던 섬망상 혈관종(spider angioma), 검은 모반(darker nevi), 장측 자반증(palmar erythema), 치육종(epulis)도 호전된다. 섬망상 혈관종은 여성의 10~15%에서 나타나는데 산후에도 줄어들기는 하지만 완전히 없어지지는 않는다. 임신 중에 생긴 가는 털은 사

라지나 거칠고 역센 모발은 그대로 남는다. 에스트로겐 과다로 인해 나타났던 소양증도 호전된다.

1) 발한

발한은 피부를 통한 노폐물의 배설로 산욕 초기에 가속화되어 산모들이 땀을 많이 흘리게 된다. 이러한 과다한 발한은 주로 밤에 많이 나타나나 점차 호전된다. 따라서 산모가 오한이 나지 않도록 보호해주고 피부청결을 위한 배려를 해야 하지만 특별한 치료는 하지 않아도 된다. 이러한 발한현상은 임신 중 과다하게 축적

된 수액이 배설되는 수분대사과정이다.

2) 체온

분만 후 체온이 약간 상승하는 것은 있을 수 있지만 산욕기의 체온은 보통 정상 범위를 유지하여, 구강측정의 경우 38°C(100.4°F) 이하를 유지한다. 분만 후 첫 24시간을 제외하고 산욕기 중에 24시간 동안 정상 범위 이상의 열이 두 번 이상 계속될 경우에는 이상증상으로 보아야 한다. 유방의 혈관 및 림프관의 증식으로 열이 지속될 수도 있으나 이것은 12시간을 넘기지 않는다. 체온상승의 이상 여부를 관찰할 때 맥박이 중요한 기준이 된다. 따라서 약간의 열이 있더라도 맥박수가 정상 범위이면 합병증을 의미하지는 않는다. 그러나 분만 후 일련의 체온 상승은 자궁내막염을 의미하기도 한다.

10. 내분비계

내분비계의 변화는 임신 중에 태반에서 분비되던 호르몬들의 혈장수준이 분만 후 급격히 하강하기 때문에 초래된다(표 6- I -4).

1) 배란과 월경

배란과 월경에 영향을 미치는 에스트로겐과 프로게스테론은 태반이 만출됨으로 인해 양이 급속도로 저하되며 기타 여러 호르몬의 변화도 산후에 나타난다(표 6- I -4).

산후 성선자극호르몬은 첫 배란을 위해 시상하부-뇌하수체-난소 주기가 재개될 때까지 낮은 수준을 유지한다. FSH와 LH는 산후 10~12일경에 낮은 수준을 나타내며 난포자극호르몬(follicle stimulating hormone, FSH)은 3주경에 난포기 수준으로 증가한다. 첫 배란 후에 황체화호르몬(lutenizing hormone, LH)이 증가

표 6- I -4. 산후 호르몬 변화

호르몬	분만 후 시간에 따른 변화
태반락토겐(hPL)	24시간 이내에 급속히 감소하여 나타나지 않음
융모생식샘자극호르몬(hCG)	분만 후 급속히 감소하여 배란 때까지 낮은 수치 보임
에스트로겐	3시간 내에 90% 감소하여 산후 7일 이내에 가장 낮은 수치를 보이고 3주 이내에 난포기 수준으로 회복
프로게스테론	3일 이내에 황체기 수준 이하로 감소되고 7일경에는 나타나지 않다가 배란 후 증가
난포자극호르몬(FSH)	10~12일 동안 낮은 수치를 보이고 3주 이내에 난포기 수준에 도달함
황체화호르몬(LH)	10~12일 동안 낮은 수치를 보이고 배란 후 증가
프로락틴	비수유모 : 2주 이내에 비임신 수준으로 감소 수유모 : 수유 시작과 함께 증가하고, 6~12개월간은 높은 수치를 유지하는데, 이는 수유의 빈도에 따라 달라짐
성장호르몬	며칠 동안은 낮은 수준에 있음
갑상샘호르몬	변화가 없음
코티코스테로이드	일주일까지 비임신 수준으로 떨어짐
레닌, 안지오텐신 II	2시간까지 비임신 수준으로 떨어짐

한다.

비수유모의 에스트로겐 수치는 산후 3주경이면 난포기 수준으로 증가한다. 그러나 수유모의 경우에는 시간이 더 오래 걸린다. 출산 후 배란과 월경은 산모의 모유수유 여부에 따라 영향을 받는다. 분만 후 첫 월경은 무배란인 경우가 많다. 분만 후 첫 월경이 재개되는 기간이 길수록 배란성 월경일 가능성이 높다. 3개월 정도 수유한 산모의 경우 첫 월경은 보통 17주 만에 나타난다. 대개 수유기간이 길수록 배란이 늦어진다. 6개월 정도 수유한 여성은 산후 28주에 배란성 첫 월경을 했다. 비수유모의 경우에는 빠르면 분만 후 27일에도 배란이 될 수 있다. 비수유모는 평균적으로 7~9주경에 첫 월경이 있고, 70% 정도는 12주까지, 90% 정도는 24주까지 첫 월경을 경험한다. 수유모의 경우에는 좀 더 많은 기간이 필요하다(표 6- I -5). 1개월 미만으로 수유한 산모의 경우는 배란과 월경재개가 비수유모와 비슷했다. 그러나 수유모이든 비수유모이든 분만 후 첫 배란시기는 매우 다양하게 나타났다. 따라서 분만 후 피임시기를 잘 선택하는 것이 무엇보다 중요하다.

보통 산모들은 분만 후 무월경에 대해 잘 이해하지 못

표 6- I -5. 산후 기간별 월경 회복률(%)

월경회복	비수유모	수유모
산후 6주까지	40~45	15
산후 12주까지	65~70	30~45
산후 24주까지	90	-
산후 36주까지	-	5~75

하고 있다. 분만 후에는 수유와 관련된 호르몬인 프로락틴(prolactin)의 양이 최고로 되었다가 비수유모의 경우 2주 후면 저하된다.

황체화호르몬과 융모생식샘자극호르몬(human chorionic gonadotropin, hCG)은 분만 후 그 양이 저하되어 약 2주경에는 난포기와 같이 낮은 수준을 유지한다. 이 낮은 상태는 다시 배란이 일어날 때까지 변화하지 않는다. FSH는 3주 후 정상수준을 회복할 때까지 낮은 상태를 유지한다. 이러한 성호르몬의 정상수준 회복은 수유모의 경우 그 기간이 지연될 뿐 수유모와 비수유모 모두에게 나타난다. 이러한 현상은 수유가 난소에 일시적인 불응기(refractory phase)를 만들어 뇌하수체의 성호르몬 생산을 저해하기 때문에 일어난다.

핵심 문제

1. 출산 후 자궁의 퇴축성 변화가 이루어지는 3가지 중요한 과정을 기술하시오.
2. 오로(lochia)를 정의하고, 산후 변화과정을 기술하시오.

2장 산모 간호

● 학습목표

- 질분만 산모의 신체기관별 생리적 적응을 돕는 간호중재를 설명한다.
- 제왕절개분만 산모의 신체기관별 생리적 적응을 돕는 간호중재를 설명한다.
- 퇴원 후 산모 방문 시의 간호중재법을 설명한다.
- 가정에서 산모의 건강을 유지·증진하기 위한 간호를 설명한다.
- 전통적인 산후조리의 원리를 이해하고, 현대인에게 적합한 방법을 적용한다.
- 산후조리의 문화적 차이를 이해한다.
- 모유분비를 촉진시켜주는 음식을 이해한다.
- 산모가 시행할 수 있는 보완·대체요법을 설명한다.

● 주요 목차

- 1. 질분만 후 간호
 - 신체적 간호
 - 심리적 간호
 - 산후 자가간호 교육
- 2. 퇴원 후 방문 간호교육
- 3. 산후관리

● 주요 용어

귀 자극요법	ear reflex zone therapy
발 반사 마사지요법	foot reflex zone massage therapy
보완·대체요법	complementary and alternative therapy
산후조리	postpartal care
산후통	afterpains
수지요법	hand acupuncture
울유	engorgement
유즙 분비 억제	lactation suppression
자궁퇴축	uterine involution
향요법	aroma therapy
회음부 간호	perineal care

산욕기는 산모의 신체적 회복, 모성으로서의 역할 변화 등 신체 심리, 재통합이 이루어지는 중요한 시기이다. 그러나 출산 후 6개월까지도 임신 전 상태로의 완전한 회복이 어려우므로 산욕기 산모에게는 신체적 건강 회복, 정서심리적 재적응과 모성 역할을 지지하는 간호를 제공해야 한다.

산욕기간(puerperium) 동안 산모의 간호 목표는 산모의 신체적 회복과 심리적 안녕, 산모의 자간호능력 획득과 신생아 간호능력의 획득, 그리고 산모와 가족이 아기 출생 후 역할 변화에 성공적으로 적응하도록 산모와 가족을 지지하는 것과 부모 역할을 획득하도록 돕는 것이다.

1. 질분만 후 간호

산모 간호에는 직접 간호, 교육, 산모 지지, 건강 증진에 필요한 환경 조성, 협동적인 간호, 가족 적응 능력, 다른 의료기관이나 사회단체의 조언 등이 포함된다. 산모 간호의 목표는 효과적인 회복과 분만 후 신체적 적

응을 증진하고 가족 내에서 새로운 구성원으로 인한 가족의 전이가 유용하도록 하는 것이다. 조기 퇴원의 경향으로 병원 안에서의 산후 간호 기간이 짧아지고 있으므로 간호사는 주의해서 간호 중재의 우선 순위를 설정해야 할 것이다.

직접적인 신체적 간호는 줄어들고 있는 반면, 산모 자신과 신생아의 간호를 위한 교육의 중요성이 점차 증대되고 있다. 분만 후 첫 몇 시간 동안의 간호는 휴식과 회복을 강조한다. 산모는 다른 기본적인 행위(배설, 영양, 조기 이상, 신생아 간호) 등에 도움을 받으므로 신체적 회복은 극대화될 수 있다. 산욕기간 중 산모의 교육은 매우 중요한 간호중재로서 자간호, 신생아 간호, 산후조리 과정, 가족 적응, 그리고 건강 유지에 관련된 지식과 기술 등을 포함한다(표 6- I -6).

표 6- I -6. 산모 교육 : 산욕기의 간호

신체적 간호		
• 퇴축	• 목욕과 샤워	• 회음부 간호
• 영양과 수분공급	• 유방 간호	• 운동
• 휴식과 수면	• 배변, 배뇨의 정상화	
• 이상 여부의 조기판단, 위험증상을 즉시 보고		
사회심리적 자간호		
• 정서적 적응	• 신생아에 대한 가족의 적응	• 생활양식 변화와 역할 변화
• 성생활 및 피임	• 역할 수행 능력에 대한 기대	• 방문객과 친구들에 대한 태도
• 지역사회자원		
신생아 간호		
• 수유	• 신생아 다루는 법, 신생아 체위 유지	• 목욕 및 위생
• 체대와 포경 관리	• 기저귀 갈아 채우기와 옷 입히기	• 신생아의 행동 양상
• 신생아 발달	• 체온측정	• 흡인
• 질병 징후 시 의사에게 보임	• 안위(유모차, 불가연성 린넨 사용, 의복, 절대 신생아를 혼자 두지 않는다)	

표 6- I -7. 자궁저부 검진 및 저부 마사지 절차

간호사정 및 중재	이론적 근거
• 검사절차 및 이론적 근거를 설명한다.	• 불안을 줄이고, 검사에 협조하게 하기 위함이다.
• 산모의 방광을 비운다.	• 방광이 차 있으면 자궁의 높이에 영향을 준다.
• 등을 대고 누워 발을 모으고 무릎을 세운다.	• 복근 이완을 위해서이다.
• 장갑을 낀다.	• 감염을 방지하기 위해서이다.
• 회음부의 생리대를 제거한다. 생리대를 교환한 시간을 기록하고 생리대의 분비물 양도 관찰한다.	• 실혈량을 추정하기 위해서이다.
• 한 손으로는 자궁저부의 하단, 즉 치골결합 바로 윗부분을 지지하고, 다른 한 손으로 둥글게 자궁저부를 확인한다. 제와의 위 치관계를 유의하여 관찰한다.	• 자궁저부의 위치를 확인하고 높이를 측정하기 위해서이다.
• 저부가 부드럽게 촉지되면 둥글게 저부를 마사지한다 : 지지하고 있는 한쪽 손을 향해 마사지한 후 아래 방향으로 압력을 주어 혈괴를 배출토록 한다.	• 자궁이 수축하도록 자극을 주기 위해서이다.
• 음부(vulva)에서 출혈의 양, 배출된 굳은 혈액 덩어리, 회음부 절개 및 찰상 부위를 관찰한다.	• 실혈량 측정 혈종, 출혈, 분리, 부종 등을 감지한다.
• 더럽혀진 생리대를 제거하고 회음부를 깨끗하게 한 후 새로운 생리대를 대어준다.	• 안위와 위생을 증진시키고 감염의 위험을 줄이기 위해서이다.
• 자궁저부를 과다하게 마사지하지 않는다.	• 근육이 피로하면 자궁이완이 증가한다.
• 사용한 생리대와 장갑을 적절하게 폐기한다.	• 감염을 막기 위해서이다.
• 자궁저부와 출혈, 회음부에서 관찰된 사실을 기록한다.	• 다른 의료진과의 의사소통을 위해서이다.
• 자궁저부가 단단하지 않거나 출혈 시 의사에게 알린다.	• 출혈을 예방하는 옥시토신 같은 약물을 처방하기 위해서이다.

1) 신체적 간호

(1) 자궁 퇴축 간호

분만 후 24시간 동안 자궁저부검진을 통해 자궁이 이완되어 있는지 파악하고, 자궁이완 시에는 자궁이 견고하고 본래의 강도를 유지하게 될 때까지 간헐적으로 자궁 마사지(uterine massage)를 시행한다(그림 6- I -5, 표 6- I -7). 이때 간호사는 출혈의 양을 기록하고 단시간 내에 자궁이 알맞게 수축되지 않거나 단단하게 수축된 후에도 출혈이 계속되면 즉시 의사에게 보고한다. 출혈 시 자궁수축을 자극하는 옥시토신계의 약물이 처방된다. 정상적으로 자궁이 퇴축되고 있는지 혹은 자궁 저부 높이의 무변화, 자궁 저부 무기력, 자궁 통증,

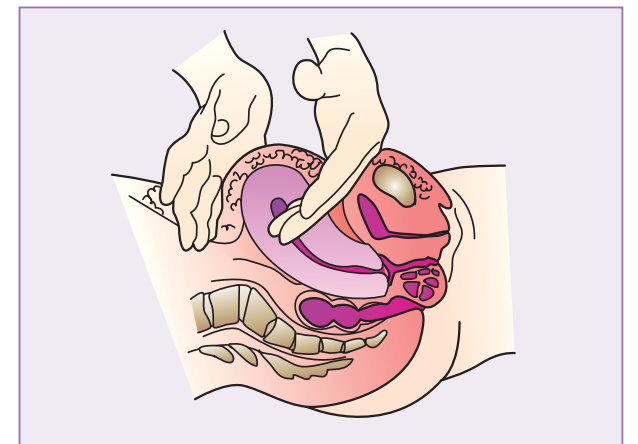


그림 6- I -5. 자궁저부 마사지

손을 정확한 위치에 대고 부드럽게 자궁저부를 마사지하는 것은 자궁근육 수축을 자극하여 회복을 돕고 출혈을 조절하는 등의 도움을 준다.

계속적인 선홍색의 출혈 유무, 악취 나는 오로 상태 등과 같은 이상 소견을 보이는지에 대해 충분한 사정과 관찰이 이루어져야 한다.

(2) 산후통 관리

산후통(afterpain)은 생리통과 유사하고 산후 2일경까지 나타나는데, 경산모와 자궁이 지나치게 이완된 산모에게 흔하다. 초산모는 자궁이 강직성 수축을 하기 때문에 산후통이 없고, 경산모는 간격을 두고 수축하기 때문에 산후통이 초래된다. 산모는 모유수유 시 산후통을 더 심하게 호소할 수 있는데, 이는 신생아가 젖을 빨 때 옥시토신 분비가 자극되어 자궁수축을 야기하기 때문이다. 이 시기에 산모교육을 할 때는 산후통의 원인을 이해시

키고, 통증이 산후 3일이 되면 완화된다는 설명을 한다.

산후통을 감소시키기 위한 방법으로 방광 비우기, 자궁저부 마사지, 고온팩 적용, 배 깔고 눕기, 다리 들어 올리는 운동 등을 교육한다. 이는 순환과 자궁 근력에 도움을 주고 불편감을 감소시킨다. 산후통이 심할 경우 진통제가 처방될 수 있는데, 불편감 완화를 위해 주기적으로 진통제가 처방되는 경우에는 모유수유 30분 전에 투여되도록 계획하여 모유수유 시 불편감 완화를 도모할 수 있다.

(3) 배뇨 및 배변 간호

간호사는 섭취량과 배설량을 조사하여 수액 불균형의 문제를 확인한다. 산모에 따라서는 분만 후 배뇨곤란이

올 수 있는데, 이때 배뇨하지 않고 방치하면 방광 팽만을 초래하며, 나아가 감염의 위험도 있다. 자발적인 배뇨를 유도하기 위해 간호사는 방광의 팽창 정도를 자주 관찰하고, 산모가 화장실에 가도록 도와주고, 필요시 침대 위에 변기를 제공해준다. 배뇨를 자극하는 방법으로 흐르는 물소리를 들려주거나 물에 손가락을 담그는 것, 회음부에 더운물을 흘려주는 것이 있는데, 회음부로 흘려준 물의 양을 제외한 배뇨량을 기록한다. 심한 회음부 통증이나 산후통을 호소하면 배뇨하기 15~30분 전에 진통제를 제공한다. 이는 산모에게 배뇨를 자극하고 편안함을 제공해줄 것이다. 분만 후 4~6시간까지는 배뇨하도록 하고 여러 번 배뇨가 어려워지면 간헐적 도뇨 또는 정체도뇨가 필요하다(표 6-I-8). 자연배뇨가 안 될 때 유치도뇨관은 회음과 요도부종, 종창 감소 위한 시간을 포함하여 24시간 동안 유치시킨다. 방광감염 여부를 확인하여 감염이 있을 경우에는 항생제를 7~10일 정도 투여한다. 변비를 예방하기 위해 분만 후 처음 며칠간은 배변완화제나 하제 등을 사용하며 수분과 섬유질 섭취도 권장한다. 간호사는 장음이 들린 시간과 첫 배변을 기록한다. 분만 후 2~3일째에도 배변하지 않으면 청정관장(cleansing enema)이나 좌약을 사용하며, 이런 방법 후에도 배변이 어려우면 보유관장(retention enema)을 실시한다. 모유수유 산모는 모유로 배출되지 않는 하제를 사용한다. 변비를 막기 위해 환자를 교육할 때는 정기적 배변 습관, 적절한 수분 공급, 섬유질이 풍부한 식이섭취 등을 교육한다. 치질은 산욕기 산모에게 흔한 문제 중 하나이다. 산후 2~3일에 가장 통증이 심하고 이후에는 점차 크기와 통증의 정도가 감소한다. 통증이 심한 치질에는 좌욕, 마취 스프레이, 연고, 냉습포 수렴제 등을 적용한다. 회음 패드를 느슨하게 착용하고 체위는 심스체위를 취하면 안위에 도움이 된다. 변비를 예방하는 것이 치질의 악화를 예방하는 주된 방법이다.

(4) 회음부 간호

회음부 간호(perineal care)는 안위감을 제공하고 감염의 위험을 감소하기 위해 시행된다. 분만 직후에는 회음부가 크게 손상되고, 회음절개술(episiotomy)까지 시행되었으므로 냉요법 적용이 효과적이다. 외상이 있은 후 즉시 냉기를 적용하여 통증을 경감시키고 혈관수축을 증대시켜서 출혈과 부종을 감소시킨다. 또한 외상이 더욱 심해지는 것을 막는다. 그 이외에도 온열요법과 건열요법이 있는데, 냉요법 이후에 온열요법은 위생상태를 증진시키고 회음부의 불편감과 부종을 감소시키기 위해 적용된다. 흔히 쓰이는 방법은 배뇨나 배변 후에 항균 용액이 첨가된 온수를 회음부에 흘려서 세척하는 것이다.

① 냉요법

얼음주머니는 30~60분 정도의 간격을 두고 30분 정도 적용할 때에 가장 효과가 좋다. 냉요법은 24~48시간까지 적용 가능한데, 그 이상 적용하면 상처의 회복을 저해할 수 있다.

② 습열요법

습열요법 중 가장 흔한 적용은 좌욕으로, 한 번에 20분씩 하루 두세 번 좌욕하고 물의 온도는 38~41°C (100~105°F)가 적당하다. 산모에게 좌욕하는 방법을 교육하여 가정에서도 계속 습열요법을 실시할 수 있도록 한다.

③ 건열요법

15~20분 동안 전등을 회음부에 조사시키는 열전등 조사방법이 이용되며, 이 방법을 사용할 때에는 산모의 프라이버시를 존중해주고 보온해준다. 열전등은 하루 세 번 정도 좌욕 후 약 20분 동안 적용한다. 집에서도 탁상용 전등(40W)을 조사할 수 있는데, 이때에 화상을

표 6-I-8. 간호지침 : 산후도뇨

간호중재	이론적 근거
• 도뇨방법과 이론적 근거를 친절하게 설명한다. • 알맞은 체위를 취하게 한다. 그리고 물품을 준비해 놓고, 소독하고 장갑을 착용한다. • 순서를 설명하고 깊이 심호흡하게 한다. • 회음부 간호를 실시한다.	• 협조하도록 하고 불안을 감소시킨다. • 시술을 돕고, 감염의 위험을 제거한다.
• 부드럽게 음순을 벌리고 전정을 깨끗이 한다. • 무균솜을 질 입구에 놓는다. • 요도구를 노출시키고 부드러운 도뇨관을 소변이 배출될 때까지 삽입한다. • 방광이 과다하게 팽만되었을 경우 300ml 배설 후 도뇨관을 잠그고 10~15초 정도 지난 후 다시 배뇨시킨다. • 정체도뇨일 경우는 풍선을 팽창시키고 간헐적 도뇨일 경우는 도뇨관을 제거한다. • 생리대를 제거하고, 환자의 체위를 변경한다. • 소변량, 색깔, 특성 등을 기록하고, 필요하면 검사실로 보낸다. • 처리방법에 따라 장갑 및 혈액이 묻은 기구들을 처리한다.	• 불수의적 긴장을 막고 이완시킨다. • 회음부를 청결하게 함으로써 안위를 제공하고 감염의 위험을 제거한다. • 봉합선의 긴장을 피하고 감염을 막는다. • 시술 도중 오로가 배출되는 것을 막는다. • 요도의 위치를 사정하여 외상을 줄인다. • 방광이 천천히 축소되도록 하여 근력을 회복시킨다. • 정체도뇨관 삽입은 방광 팽만이 심각할 때 적용한다. • 위생과 안위를 증진시킨다. • 방광이 비워졌는지 여부를 확인하고 감염 여부를 사정하기 위함이다. • 감염 방지를 위함이다.

표 6-1-9. 환자 교육 : 회음부 자가간호

간호중재	이론적 근거
• 손을 씻는다. • 생리대를 앞에서 뒤로 제거한다. • 음순을 벌리지 않고 용액을 그대로 회음부에 붓는다. • 건조한 휴지로 앞에서 뒤를 향해 두드리듯 닦아낸다. • 스프레이를 뿌리거나 연고를 바른다. • 새로운 생리대를 앞에서 뒤로 착용하며, 생리대의 표면을 만지지 않도록 한다. • 손을 씻는다.	• 미생물을 제거하여 감염의 위험을 막는다. • 항문에서 질 방향으로 미생물이 전파되는 것을 막는다. • 오로를 세척하고, 음부를 깨끗이 한다. 음부의 세균이 질로 옮겨가는 것을 막는다. • 마찰을 줄이고, 직장의 세균이 질로 전파되지 않는다. • 안위증진을 돕는다. • 안위를 제공하고, 세균의 전파를 막으며, 생리대의 이탈을 방지한다. • 미생물을 제거하여 감염의 위험을 줄인다.

입지 않도록 주의하며 50~70cm의 적절한 거리를 유지하도록 한다.

기타 회음부 통증이 심할 때는 처방된 진통제나 마취 스프레이, 연고 등을 회음부에 직접 적용한다. 이러한 약품들은 고통을 경감시키고 안위를 증진시킨다. 광범위한 회음부 이상이 있는 산모에게는 산욕기 1~2일까지 4시간마다 약을 처방해야 한다. 회음부 봉합 주위의 불편감 때문에 산욕기 초기에 산모들은 앉을 때 큰 불편을 느낀다. 이때에는 체중을 엉덩이 쪽에 실어서 경직된 자세로 앉게 되므로 회음부뿐만 아니라 등 쪽에도 불편함을 느끼게 된다. 간호사는 산모에게 몸을 바르게 하면서도 편안히 앉을 수 있는 방법을 가르쳐주어야 한다. 중심 회음절개술을 실시한 산모는 둔부를 모으고(손으로 둔부를 안쪽으로 밀어 넣는다) 앉기 직전에 골반 하부 근육을 긴장시키고, 그 상태를 모든 체중이 아래로 쏠리기 전 수 초간 유지하여 앉는 방법으로 불편감을 줄일 수 있다. 그러나 측방으로 회음절개를 한 경우는 회음부 통증이 더 심하여 절개하지 않은 쪽으로 체중을 유지하여 앉는 방법이 불편감을 줄일 수 있다(표 6-1-9).

(5) 유방 간호

유방 간호는 유방의 청결을 유지하는 것과 산모에게 안위를 제공하고 유방의 기능을 정상화하는 데 필요한 지지간호 등이 포함된다. 수유하는 산모의 경우에는 깨끗한 물로 유두를 청결하게 해야 한다. 모유수유하는 산모는 비누, 알코올, 건조제제 등의 사용을 피하고, 모유수유를 하지 않는 산모의 경우 매일 목욕 또는 샤워 시에 부드러운 비누로 유방을 씻어주는 것이 바람직하다. 유방에 잘 맞는 브래지어를 착용하는 것 외에 다른 특별한 처치는 필요하지 않다. 인공수유하는 산모의 경우에는 흔히 모유 분비 억제를 위해 유방 억제대를 대주기 때문에 유방 증대의 문제는 그리 심하지 않다.

수유는 초유가 분비되는 첫날 유즙 사출이 원활히 되지 않더라도 젖이 부드러울 때(말랑말랑할 때) 유즙 분비 촉진을 위해 신생아에게 3시간마다 3~5분 동안 젖을 빨리도록 지도한다. 울유 정도는 다양하여 산모가 느끼는 불편감도 산모마다 차이는 있으나 대부분이 상당한 통증을 호소한다. 초산모는 경산모보다 심한 통증을 경험한다. 때로는 산모들이 유방의 불편감으로 인해 피로와 두통을 호소할 수도 있다. 울유로 인하여 체온이 0.5°C(1°F) 상승할 수 있으나 38°C(100.4°F) 이상으

로 상승 시에는 감염 등을 고려하여 다른 원인들을 찾아보아야 한다.

유방 울혈의 치료로는 냉온찜질, 양배추잎을 유방에 직접 붙이는 방법, 유방 마사지, 모유유출 등을 포함한 다. 가슴을 마사지하기 전에 뜨거운 샤워나 뜨거운 물수건으로 유방을 부드럽게 한 다음 종창이 있는 유관을 따라 손가락으로 단단하게 돌리는 동작으로 마사지를 하고 자연스럽게 유즙이 배출될 때까지 짜낸다. 가장 좋은 예방법은 2~3시간 간격으로 수유를 자주 하는 것이다.

부득이하게 모유수유를 중단할 때 가장 간단하고 자연스런 유즙 억제법은 유방 자극을 피하는 것이다. 비수유모의 유방은 탄력붕대 등을 이용한 유방대로 싸매주며, 손을 대지 않도록 주의해야 한다. 출산 후 72시간 정도 유방을 단단하게 지속적으로 지지해주면 유즙 분비가 억제되며, 한 달 정도 지나면 유방은 완전히 위축된다. 울유가 되었을 경우에도 젖을 짜지 말고 그대로 두면 유즙의 생산이 억제되기 때문에 며칠 내에 서서히 없어진다는 것을 설명한다. 유방 울혈이 발생하면 대개는 위와 같은 비약물적 중재로 만족스럽게 해결될 수 있다.

유방 울혈로 인한 불편감 감소에는 얼음 찜질 적용이 도움이 되는데 한 시간 간격으로 15분 정도 적용할 수 있으나 우리 문화권에서는 재고할 필요가 있다. 유방의 부종과 이로 인한 불편감 완화를 위해 신선한 양배추잎을 브래지어 안에 넣어주면 울유나 열감을 감소시키는 효과가 있다. 이 외에도 전통적 방법으로 감주나 인삼을 먹는 등의 실증적 연구를 시도하여 유즙 분비를 억제하는 효과도 밝혀진 바 있다.

(6) 조기이상

조기이상(early ambulation)은 순환을 돕고 혈전 정맥염의 위험을 감소시킨다. 방광과 장 기능도 증진되기 때문에 도뇨관 삽입의 필요성 또는 복부 팽만, 변비 등이 감소하는 효과가 있다. 특별한 부적응이 없다면 분

만 후 4~8시간이 지나면 산모가 침대에서 일어나 앉거나 걸을 수 있도록 권장한다. 처음 침대에서 일어나는 초기 이상 시에는 갑작스런 현기증과 쓰러짐에 대비하여 다리는 아래로 떨어뜨린 자세(dangling)로 수 분간 침대에 걸터앉게 한다. 그 후에는 서도록 보조해주고, 균형을 잡으며 몇 걸음 걷게 한다. 이때에 간호사는 산모의 상태와 어지러움증 또는 허약 정도를 사정한다. 간호사는 욕실이나 의자까지 산모를 지지해주고, 갑작스러운 현기증과 쓰러짐에 대비하여 산모 가까이에서 관찰해야 한다. 간호사는 산모 또는 보호자에게 조기이상의 목적과 효과에 대해 설명해야 한다. 활동은 산모의 회복 정도에 따라 점차적으로 늘려간다.

만약 산모가 척수강내 지주막하 마취를 적용했다면 침대 이상 전에 적어도 8시간 정도 똑바로 누워 있어야 한다. 신생아와 상호관계를 맺을 때와 수액을 공급받을 때에도 양와위를 계속 유지하여야 한다. 간호사는 산모에게 고개를 들거나 자세를 변경하지 않도록 주의하게 하고, 자세를 바꾸지 않아도 신생아와 접촉할 수 있도록 신생아의 위치를 조정해준다. 이것은 척수 후방의 두통을 감소시키고, 바늘 삽입 부위로 척수액이 스며 나오는 것을 막기 위함이다. 그러나 8시간 이상 침대에 누워 있으면서 혈액순환을 증진시키기 위하여 다리 운동을 하도록 권장한다. 국소마취, 경막외마취, 미단부 마취 등을 적용한 경우에는 가능한 한 빨리 조기이상하도록 한다.

(7) 휴식과 수면

휴식과 수면은 분만 후 지친 산모에게 필수적으로 요구되는 간호중재이다. 산욕기에는 산모에게 적절한 휴식이 필요하고, 어느 때라도 수면과 이완을 취할 수 있어야 한다. 휴식은 불안과 근심을 감소시키고 안위를 증진시킨다. 수면 부족과 피곤은 산모에게 정서적 문제를 야기시키므로 산모가 충분히 휴식할 수 있도록 지지하여야 한다. 인공수유의 경우에는 산모가 수면 중이거

나 휴식하고 있어서 깨우지 않아야 될 때에는 간호사가 대신해서 인공수유를 할 수도 있고, 만약 산모가 낮잠을 잘 수 없는 상황이라면 가능한 한 여러 시간 동안 최대한 조용한 환경에서 휴식하도록 권유되어야 한다. 산모가 신생아를 돌보는 일에 열망을 갖게 되는 적극기(taking-hold phase)에도 휴식과 수면의 필요성이 강조되어야 한다.

(8) 예방접종

산모에 따라 풍진 백신(rubella vaccine)과 Rho(D) immune globulin(Rhogam) 등을 예방접종 한다. 신생아 또한 필요한 경우 예방접종을 해야 한다. B형 간염이 있는 산모의 신생아는 출생 후 가능한 한 12시간 내에 B형 간염 면역 글로불린(hepatitis B immune globulin, HBIG)을 접종하고 후에 백신으로 접종해야 한다.

① 풍진 백신

풍진 예방접종을 안 했거나 혈청학적으로 풍진항체수치(titer)가 1:8 이하인 산모는 퇴원 전 피하주사로 풍진 예방접종을 하는 것이 추천된다. 항체가 1:16 이상 시 면역력이 있다고 고려된다. 백신은 감염되고 비전염성의 바이러스를 접종하는 것이므로 모유수유 산모에게도 접종 가능하다. 달걀 단백질(egg protein)에 과민 반응이 있는 산모들은 접종에 대한 과민반응을 보일 가능성이 있다. 풍진 백신은 생백신(live vaccine)이므로 접종 후 3개월 동안은 기형 유발 가능성을 고려하여 피임을 권장한다.

② Rho(D) 면역 글로불린

Rh(-)인 여성이 이전에 감염되지 않았다면 분만 후 72시간 이내에 Rho(D) immune globulin(Rhogam)을 주사해야 한다. 이 예방접종의 준거는 간접 Coombs test(-)(Rh항체 없는 경우)인 Rh(-)형의 산모, Rh(+)인

신생아의 제대혈검사 시 직접 Coombs test(-)(Rh항체 없는 경우)인 경우 300 μ g의 Rho(D) immune globulin을 주사한다.

2) 심리적 간호

분만 후 산모의 심리적 적응을 도모하기 위해 간호사는 산모에게 분만에 대한 감정과 느낌을 얘기하게 하여 분만 경험을 통합하도록 도와주고, 다음 출산에 대해 불안감을 갖지 않도록 분만 경험을 긍정적으로 지지해주는 것이 중요하다. 또한 분만 후 산모의 정서적 문제로서 나타날 수 있는 산욕기 우울에 대해서도 정확한 사정과 간호중재가 요구된다.

(1) 산후 우울감

산후 우울감(postpartum blues)은 출산 후 2~3일 후 산모에게 보이는 일시적 우울을 말한다. 산욕기의 우울은 여성의 낮은 자존감에 기인하는 것으로 가족 기능을 저하시키는 결과를 초래한다. 산욕기 우울의 증상은 쉽게 울고 의기소침해지며 식욕 감퇴, 집중 곤란, 수면장애, 실망, 불안 등이 나타난다. 이러한 증상은 흔히 1~2주 내에 없어지지만, 이들 증상이 계속되거나 점차 그 정도가 심해진다면 산후 우울증(postpartum depression)으로 이행되고 있다는 조기 경고로 받아들여야 한다. 간호사는 산모에게 자신의 불안, 낙담, 그리고 다른 근심들을 표현할 수 있는 기회를 제공함으로써 이러한 감정을 나눌 수 있다는 것만으로도 치료가 될 수 있으며, 산모가 신생아에 대해 갖는 부적절하고 비정상적인 반응의 감정은 산욕기의 혼란 경험이라는 것을 산모에게 이해시킬 수 있다. 또한 적절한 휴식과 영양을 취하도록 환자를 격려하고, 엄마로서의 과업을 빠른 시일 내에 수행할 수 있도록 도와주어야 한다. 이러한 일시적 우울감 때문에 정신과 약물을 복용하는 경우는 거의 없으나 지속적이고 심한 우울일 경우에는 정신과 치

료가 필요하다(출산 후 관련 합병증 참조).

(2) BUBBLEE-C

산모의 상태를 체계적으로 사정하여 간호중재 및 교육이 원활하게 이루어질 수 있도록 BUBBLEE-C를 기억하면 된다. 이는 머리부터 발끝까지 훑어 내려가며 점점하는 8가지 주요한 신체·심리적 상태를 포함하며, 각 영역의 약자를 딴 것이다.

- B : Breasts - 수유 여부에 따른 유방의 변화 사정, 유방 울유 예방과 관리
- U : Uterus - 자궁 퇴축 사정, 필요시 자궁 마사지 시행
- B : Bladder - 방광팽만/요실금 사정, 배뇨 독려, 골반저근운동 독려
- B : Bowel - 치질 사정, 배변 독려
- L : Lochia - 오로상태 사정, 오로와 출혈 분별
- E : Episiotomy(or Cesarean incision) - 회음부 간호, REEDA(redness, ecchymosis, edema, discharge, approximation) 확인
- E : Emotional state & Bonding - 산후 우울감과 산후 우울증 분별, 모애착 증진 간호, 애착행위 독려
- C : Circulation - Homan's sign 사정, DVT 고위험요인 확인, 조기이상 독려

3) 산후 자가간호 교육

(1) 영양섭취

수유모의 영양상태는 산욕기 산모와 신생아의 건강에 직접적으로 영향을 주므로 중요하다. 분만 중 음식과 수분을 제대로 섭취하지 못한 동시에 출혈, 발한, 오심 등으로 체액 손실량이 많아 분만 직후의 산모는 배고픔과 갈증을 느끼며 먹을 것 또는 마실 것을 요구할 수 있다. 산모는 식욕을 많이 느끼는 것이 보통이며, 특히 수

유 시에는 식사 사이에도 배고픔을 호소하곤 한다. 전신마취(general anesthesia)를 했거나 오심증이 없는 한 음식을 제공할 수 있으며, 첫 식사로는 소화가 용이한 음식을 소량씩 제공하는 것이 좋다. 산모의 식이로 고려해야 할 영양은 2가지 관점에서 생각하여야 하는데 첫째는 산모 자신의 회복을 위한 영양이고, 둘째는 수유를 위한 영양으로 양·질적으로 고려되어야 한다. 산모가 성인 여성이고 수유를 한다고 간주하였을 때 영양 권장량은 표 6-I-10과 같다.

기타 수분 또한 젖의 분비를 위해 최소한 하루에 2,500~3,000ml를 공급해주어야 한다. 더운 날씨이거나 신체적 활동이 많을 때는 더 많은 수분이 요구되며, 특히 갈증이나 수분 및 기타 영양의 섭취를 위해 하루에 약 1,000ml의 우유 섭취가 권장된다. 이 외에도 과일, 야채 및 과일주스 등 균형 잡힌 영양식을 지도한다.

(2) 산후 운동

산후 운동은 분만 시 늘어난 복벽과 골반 및 근육의 수축력을 회복시키고, 혈액순환을 좋게 하며, 배뇨, 배변 작용과 자궁수축을 도우며, 산후의 긴장과 피로를 회복시키는 데 도움을 준다. 근육 강화운동은 산모의 체형을 정상으로 회복시키며 정신적인 측면에도 유용하다. 운동은 분만 후 첫째 날부터 시작하여 점차적으로 운동의 양을 증가시키되 무리한 운동을 하지 않도록 산모를 교육해야 한다. 산모에게 필요한 운동은 그림 6-I-6을 참조한다. 분만 후 적어도 6주 동안 하루에 5회에서 10회 정도 실시하는 것이 좋다. 산욕 1일부터 골반저근(pelvic floor muscles)의 탄력성 유지를 위한 골반저근운동(pelvic floor muscle exercise, PFME)을 한다(비뇨생식기 기능장에 참조).

표 6-1-10. 비임신부, 임신부, 수유모의 영양소 권장량(한국영양학회, 한국인영양섭취 기준위원회, 2010)

	에너지(kcal)	단백질(g)	칼슘(mg)	철분(mg)	비타민					
					A(μgRE)	B ₁ (mg)	B ₂ (mg)	니아신(mgNE)	C(mg)	엽산(μgDFE)
비임신부(19~29세)	2,100	50	650	14	650	1.1	1.2	14	100	400
임신부 ¹⁾	+0	+0								
	+340	+15	+280	+10	+70	+0.4	+0.4	+4	+10	+200
수유모	+320	+25	+370	+0	+490	+0.4	+0.4	+5	+35	+150

1) 에너지, 단백질 : 임신 1·2·3기별 부가량

출산 여성의 영양관리

- 에너지(kcal) : 수유모의 영양권장량은 하루에 2,420kcal로, 비임신 시보다 320kcal를 증가시킨다. 유즙 100ml는 60~70kcal의 열량을 함유하고 유즙 생산에 소요되는 칼로리는 분비되는 유즙이 갖는 열량의 약 10%에 해당되므로 하루에 580~1,200ml의 유즙이 분비된다면 유즙 분비만을 위해 하루에 600~700kcal의 열량이 소모된다. 과잉 열량 섭취는 비만증을, 열량 섭취 부족인 경우는 여러 가지 합병증이 초래되므로 유의해야 한다.
- 단백질(protein) : 모유 1,000ml 중의 단백질 함유량은 14~15g이며, 모체가 섭취한 단백질의 50%가 유즙으로 이행되므로 수유기에 단백질의 양은 비임신 시보다 25g을 증가시켜야 한다(WHO의 기준에 의하면 하루에 체중 kg당 2g을 섭취한다).
- 당질(carbohydrate) : 필요한 열량의 약 65~75%를 당질로 공급하는 것이 이상적이다.
- 지방질(fat) : 수유기에 필수지방산이 부족하면 유즙 분비에 장애가 온다. 따라서 지방질의 섭취는 단백질 요구량의 50%로 한다.
- 광물질(mineral) : 임신부와 수유모에게 특별히 요구되는 광물질은 칼슘과 철분이다. 칼슘은 모체 자신에 필요한 양 외

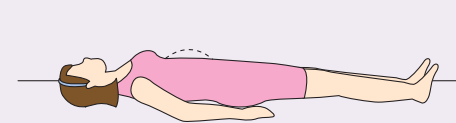
에 유즙 분비에 필요한 양을 첨가하여야 한다. 한국인 비임신부의 1일 칼슘 필요량은 650mg이다. 유즙 100ml당 30mg의 칼슘이 함유되어 있으므로 하루에 분비되는 1,000ml의 유즙 속에는 300mg이 들어 있다. 한편 섭취된 칼슘이 젖으로 전환되는 비율은 25%이므로 유즙 분비에 요구되는 칼슘량은 1,200mg이다. 그러므로 비임신 시의 요구량 650mg과 합하면 수유모의 1일 필요량은 1,850mg이라는 결론이다. 그러나 이것과 관계없이 임신 수유의 전 기간을 통하여 1,020mg을 권장한다. 철분의 권장량은 임신·수유를 고려하여 책정한 것이므로 1일 24mg을 권장한다.

- 비타민(vitamins) : 비타민 A는 저항력을 기르는 데 필요한 영양소로 이것이 부족하면 산욕 감염을 일으키기 쉬우며 신생아의 저항력이 약해지므로 충분히 섭취를 해주어야 한다. 비타민 B는 당질, 지질, 수분대사와 많은 관계가 있으며, 이것이 부족하면 쉽게 피로해지고 부종, 각기 및 자궁 복구가 늦어지기 쉽다. 엽산은 중요한 조혈요인으로서 모유로 분비되어 신생아의 빈혈을 예방하기도 하며, 비타민 B₁₂는 적혈구의 세포분열에 도움이 된다. 비타민 C의 가장 중요한 생리작용은 항괴혈(anti-scurvy)작용으로 산욕기에 산모의 회복을 돕고 감염에 대한 저항력을 증강시키며 산후 출혈을 막기도 한다.

• 산후 골반저근운동

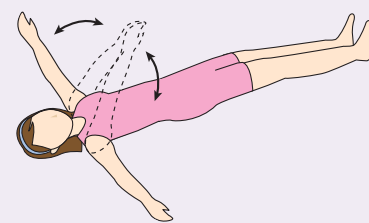
Johanna Briggs Institute for Evidence-based care (2005) The Effectiveness of a Pelvic Floor Muscle Exercise Program on Urinary Incontinence Following Childbirth, Best Practice 9(2) Blackwell Publishing Asia, Australia.

연구방법 : 산욕기의 골반저근운동 교육에 관한 연구물을 선정하여 산모의 요실금에 미치는 영향(6개의 무작위할당 연구), 골반저근운동 빈도에 미치는 영향(5개의 무작위할당 및 유사실험연구), 그리고 다양한 교육방법의 비교(2개 무작위할당 연구)를 분석한 체계적 중설이다.



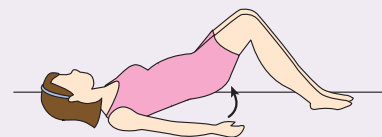
산후 제1일째

복식 심호흡(deep abdominal breathing)
편안하게 똑바로 누워서 숨을 천천히 들이마시면서 복부를 상승시키고 서서히 내쉬는 것을 5회 반복한다.



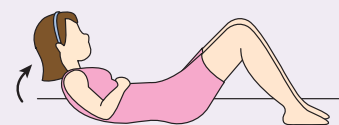
산후 제2일째

팔운동
편안하게 똑바로 누워서 팔꿈치(elbow)를 쪽 편 채 천천히 앞으로 들어 올려 직각이 되게 하여 양손을 붙였다가 천천히 제자리로 내리는 운동을 반복한다.



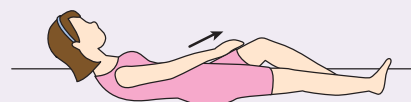
산후 제3일째

둔부 올리기 운동(pelvic tilt)
똑바로 누워서 양쪽 팔은 옆에 놓고 그림과 같이 두 발을 모으고 무릎을 약간 들어 올리면서 둔부를 올려 등이 아치 모양으로 굽어지는 운동을 반복한다.



산후 제4일째

똑바로 누워서 무릎과 둔부를 굴곡시킨다. 이것은 골반근육과 둔부에 탄력성을 주고 머리를 들어 올리면 복부근육을 수축시킨다.



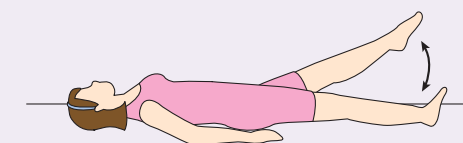
산후 제5일째

바로 누워서 다리를 곧게 펴서 머리와 무릎을 약간 올리고 무릎에 반대편의 손을 거의 닿게 한다. 이것을 오른손, 왼손으로 교대한다.



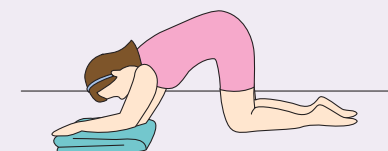
산후 제6일째

똑바로 누워 무릎을 서서히 굴곡시켜 대퇴가 복부에 닿게 하고 발이 둔부에 닿게 한다. 다른 다리는 바닥에 똑바로 편다. 이것을 좌우 교대한다.



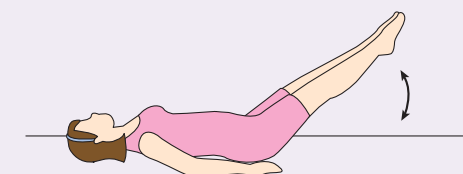
산후 제7일째

베개 없이 똑바로 누워 한쪽 다리는 편 채 그대로 두고 한쪽 다리만 무릎과 발을 쪽 펴고 서서히 들어 올려 둔부에 직각이 되게 한다. 이것을 좌우 교대로 점차로 10번까지 증가시킨다.



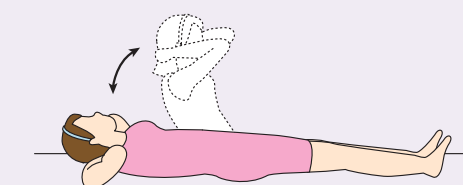
산후 제8일째

상박과 다리가 몸체에 수직이 되도록 팔꿈치와 무릎을 굽혀서 정지시키고 등을 올린 상태에서 둔부와 복부를 힘 있게 수축시키고 이완시킨 후 심호흡을 한다.



산후 제9일째

양쪽 다리를 함께 들어 올려서 둔부에 직각이 되도록 하였다가 내리는 운동을 반복한다. 산후 7일째 운동의 변형이며, 이 운동은 복부근육의 탄력성을 위하여 대단히 효과적인 방법이다.



산후 제10일째

일어나 앉기 운동(situps)
똑바로 누워서 둔부와 다리는 들지 않고 팔을 머리에 대고 머리와 상체를 서서히 들어 올려서 앉고 다시 서서히 눕는 운동을 10번까지 반복해 교대로 한다. 만약 필요하다면 발을 고정시켜도 좋다.

그림 6-1-6. 산후 운동

연구결과 : 산욕기의 골반저근운동 교육을 받은 대로 실천했더니 효과가 있으며 모든 종류의 중재가 도움이 되는 것으로 나타났다. 구체적으로 운동 횟수나 피드백에 대해서는 자료가 더 요구되나 요실금에 영향을 주기 위해서는 최소한 2회의 교육 기회가 요구되는 것으로 보이며 문서만 제공받은 산모는 제대로 수행하지 못하였다.

연구의 적용 : 산모를 위해 적극적으로 적용하도록 권장되는 지침(grade A)은 다음과 같다.

- 올바른 골반저근운동을 실천하고 있는지 확인한다.
- 임신 중과 산욕기 때 모두 골반저근운동을 격려한다.
- 임신 중과 산욕기 때 요실금이 있는 경우 특별한 관심을 가진다.
- 산전 및 산후간호에 골반저근운동 교육을 포함하고, 최소한 2회의 개인적 설명시간을 확보한다.
- 골반저근운동 프로그램들은 단순한 문서자료보다는 다양한 방법과 요소로 구성한다.

이 밖에 다음 사항은 산모를 위해 적용을 고려한다.

- 도움을 받을 수 있는 연락처를 산모, 특히 조기퇴원하는 산모들에게 제공한다.
- 일상생활 중에 산모-신생아에게 부담이 되지 않을 재가 골반저근운동 프로그램을 개발한다.

(3) 감염 예방교육

산후 감염을 예방하기 위하여는 산후에 흔히 올 수 있는 감염성 합병증에 대한 이해가 우선되어야 한다.

혈전성 정맥염의 위험을 감소시킬 수 있는 방법을 산욕기 산모에게 교육해야 하는데 교육 내용으로는 조기 이상(early ambulation)의 중요성을 강조하고 산모에게 조이는 끈이나 순환에 장애를 주는 의복을 피하도록 알려주어야 한다. 산모가 혈전 형성과 감염 시의 증상(편측성의 종아리 또는 대퇴의 심한 통증, 발적, 종창,

표 6-1-11. 산모 교육 : 산욕기의 위험 증상

- 심한 질출혈 또는 선홍색 오로
- 열(오한이 있거나 없음)
- 심한 악취를 동반한 질 분비물이 증가할 때
- 한쪽 다리가 붓고, 압통이 있고, 발적 열감이 있을 때
- 유방에 종창, 압통, 발적, 열감 부위가 있을 때
- 배뇨하기 어렵거나 배뇨 시 따가운 통증이 있을 때
- 회음부 혹은 골반부의 지속적인 통증

열감)을 알고 있어서 이상이 있을 때에는 즉시 의사에게 문의하도록 해야 한다. 회음부 또는 유방의 감염 예방을 위해서는 회음부 절개술 시 혹은 열상이 있을 때에 감염의 위험을 줄이기 위해 회음부 패드 착용과 제거, 배뇨, 배변 후 세척하는 적절한 기술을 산모에게 교육해야 한다. 유방의 청결과 지지법이 유선염의 가능성을 최소화할 수 있음을 산모에게 교육하도록 한다. 다음 증상들은 감염이나 출혈이 있을 때 나타나는 것이므로 즉시 의사나 일차 의료제공자의 도움을 받도록 한다(표 6-1-11).

(4) 성생활

약 50%의 여성이 산후 3주경까지는 성욕이 회복되는 것으로 알려져 있어 이 시기에 원한다면 성교를 해도 무방하다. 절반 이상의 여성들이 2개월이 지나면 성관계를 갖는다. 그러나 성반응 주기의 정상화가 3개월 이상 지연되므로 편안한 성관계를 위한 적절한 시기는 분만 후 보통 3개월 정도이다.

분만 후 성생활에 영향을 주는 요인은 다음과 같다.

- 회음절개와 열상으로 인한 회음부 통증
- 수면 부족으로 인한 피로와 허약감
- 수유로 인한 저에스트로겐으로 초래된 질위축(이 현상을 막기 위해 에스트로젠 질 크림을 사용할 수 있다)
- 성관계 동안 유즙 사출(이 문제를 막기 위해서는 성교 직전 아기에게 수유하도록 한다)

성생활을 재개하기 위해서는 산모의 개인적 특성에 맞게 적절한 상담이 제공되어야 한다. 산욕기의 성생활은 분만 중 회음부 외상의 정도와 산욕기 초기 증상인 스테로이드 호르몬 분비 저하 정도에 의해 영향을 받는다. 간호사는 산욕기의 성생활 접근에 있어서 산모의 문화적 가치 체계에 대한 민감성을 가져야 하고, 개별적 상담을 제공해야 한다.

산후 몇 개월 동안은 성교에 있어 산모가 흥미를 덜 느끼게 되는데 그것은 호르몬 저하, 모성 역할에의 적응, 수면과 휴식 부족으로 인한 피로 등의 이유 때문이다. 간호사는 이러한 성욕 저하에 대한 정보를 제공하고 산모에게 근심을 표현할 기회를 주어 잘못된 이해를 막아야 한다. 분만 후 2~4주가 되면서 오로(lochia)도 점차 감소하고 색이 흐려지며 회음부와 회음부 절개 부분도 통증이 사라지고 아물게 되므로 성욕 저하에 대한 문제가 점차 개선될 수 있다. 다음과 같은 성생활에 관한 환자 교육이 이루어져야 하는데, 성교는 오로가 감소한 후가 적당하며, 성교 시 통증이 없을 만큼 회음부가 아물어야 하고, 혈종이나 감염과 같은 문제가 없을 때에 성교해야 하며, 성교하는 것에 불편감이 있으면 얼마 동안 성생활을 금하도록 한다.

성생활과 더불어 퇴원전 피임 교육이 필요하다. 산후 6주는 주로 무배란성 월경일 수 있으나 정확한 배란 시작일을 예견하기 어려우므로 임신을 원하지 않는 산모의 경우 모두 피임하도록 권장하고 있다.

(5) 일상생활

산모는 조직의 치유와 증가된 활동들로 인해 더 많은 휴식기간이 필요하다. 따라서 적절한 영양과 충분한 수분을 섭취하는 것이 중요하다.

수면과 안정을 취할 때는 복부가 바닥을 향하게 엎드린 자세를 취한다. 엎드린 자세에서는 배개를 배의 상부에 놓고 다른 배개를 머리와 양 어깨에 놓으면 유방

이 눌리지 않으므로 더욱 편하다. 간호사는 오로가 멈출 때까지는 심한 운동을 삼가도록 지도하고, 가볍게 몸을 뻗치거나 산후 운동을 하는 것은 산모의 수준에 맞게 증가시키도록 지도한다. 회음부 상처 회복을 위해 가정에서도 지속적으로 회음부 자가관리를 할 수 있도록 하여 상처회복을 촉진한다. 임신 중에 증가되었던 체액이 배설되면서 산욕기에는 심한 발한을 경험하게 된다. 샤워를 하면 상쾌함과 위생을 증진시켜주므로 별다른 합병증이 없으면 산후 수 시간 내에 샤워가 가능하나 산모의 문화적 신념이 고려되어야 한다. 처음 산모가 샤워할 때에는 안전을 위해 간호사가 가까이 있어야 한다. 통목욕은 산후 오로가 없어졌을 때가 적당하다.

(6) 신생아 간호

신생아 간호는 아기에 따라 매우 다르나 산모는 아기의 특별한 행동과 대화방법을 배워야 한다. 산모들은 아기 상태, 특히 몸무게 증가, 울음, 배변, 젖 먹는 것과 잠자는 양상에 대해 관심이 있으므로 이에 대한 산모들의 요구를 충족시켜야 한다. 신생아 돌보기는 신체적 돌봄에 대한 내용뿐만 아니라 모자 간 상호작용과 애착에 대한 내용도 포함되어야 한다. 산모와 아기가 어떻게 상호작용하는가는 아기의 성장과 발달에 많은 영향을 미친다(신생아 간호 참조).

4) 퇴원 준비

퇴원은 질분만 시 2~3일 후, 제왕절개분만 시 5~6일 후에 이루어진다. 퇴원시기가 언제이든 간에 간호사는 산모의 퇴원을 위한 준비를 해야 하며, 교육 내용은 가정에서의 산모 자가간호, 신생아 간호에 대한 것이다.

병원 혹은 건강센터에서 퇴원하기 전에 산모의 상태는 신체적으로나 정신적으로 정상이어야 한다. 간호사정은 활력징후, 자궁 퇴축, 회음부 회복, 배설(배변·배

뇨), 수유, 유즙 분비 억제, 조기이상, 여러 가지 검사, 예방접종상태 등 모든 면에서 이루어져야 하고 결과가 정상이어야 한다.

간호사는 다음과 같은 사항에 대해 산모의 지식 수준을 평가하고 재확인하여야 한다. 자가간호 및 신생아 간호능력, 배란과 월경의 회복, 피임, 성교의 재개, 약물 복용과 즉시 보고해야 할 위험증상 등이다. 부모들에게 신생아 간호, 음식, 세탁, 장 보는 것, 그 외의 집안 일을 도와줄 사람이 필요함을 인식시킨다. 지역 사회 자원을 이용하고자 하는 욕구가 있는가를 사정하여 필

요한 정보를 제공해준다. 위험증상과 이상 시 연락할 곳의 전화번호가 적혀 있는 인쇄물이나 소책자 등이 도움이 된다. 산모와 신생아의 퇴원 후 통원 치료에 대해 강조해야 하고 가능하면 퇴원 시 첫 방문 날짜를 계획하는 것이 좋다.

조기퇴원을 하는 경우에는 산모와 신생아의 건강 상태가 양호한 경우로 저위험군에 속하는 산모와 신생아는 분만 당일에 퇴원할 수도 있는데, 빠르면 분만 후 2~6시간 내에도 퇴원이 가능하다. 산모와 신생아 모두 임신 기간부터 시작하여 분만 후까지 주의 깊게 관찰되어

표 6-1-12. 간호지침 : 조기퇴원을 위한 평가 지침

상태가 좋아서 위험스러운 점이 보이지 않는다.

출혈이 없다, 정상적 오로 분비, 헤모글로빈과 헤마토크릿의 정상범위 모든 사정 범주가 정상범위 내에 속해야 한다.

■ 산모

- | | |
|---|--------------------------|
| • 활력징후 정상 | • 어지러움이나 허약함이 없다. |
| • 단단한 자궁저부, 중간 정도의 적색오로 또는 갈색오로 배출
혈종이 없는 정상적인 회음부 | • 수분 섭취와 식이 섭취에 어려움이 없다. |
| • Homan's sign의 음성반응 | • 적당한 양의 배뇨 |
| | • 도움 없이 걸을 수 있다. |

■ 수술 후

- | | |
|------------------------|--------------|
| • 회음절개부 상처가 잘 아물고 있다. | • 호흡음이 정상이다. |
| • 장운동이 회복되고 대변이 배출되었다. | |

■ 신생아

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • 태내기간에 맞는 적절한 체중(>2,500g) | • 정상적 울음과 반사, 활동력 |
| • 활력징후 정상 | • 기도 내 분비물과 점액이 많이 배출되지 않아야 한다. |
| • 배뇨와 배변이 정상적이어야 한다. | • 제대혈의 빌리루빈 수치가 정상이어야 한다. |
| • Coomb's test가 음성이어야 한다(Rh 부적합증일 때) | |

■ 아이를 돌봄에 있어 관찰해야 할 사항

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • 부모와의 애착 형성이 잘되어야 한다. | • 신생아를 잘 다루어야 한다. |
| • 어려움 없이 수유할 수 있어야 한다. | • 수유 시 아기가 잘 빨아야 한다. |

■ 자가 및 신생아 간호에 관한 교육

- 자궁저부검사, 회음부 간호, 신생아 간호(수유, 기저귀 갈기, 제대간호, 빨기) 등에 대해 산모가 정확한 시범을 보일 수 있어야 한다.
- 자기 및 신생아 간호, 제한해야 할 행동, 가족적응 등에 대한 사항을 말하거나 글로 쓸 수 있어야 한다.
- 즉시 보고해야 할 위험증상에 대해 말할 수 있어야 한다.
- 산과 의사, 소아과 의사, 일차의료제공자, 산부인과 병동, 응급실 등의 전화번호를 알고 있어야 한다.

■ 48~72시간 내에 병원 재방문의 계획을 약속하거나 간호사의 가정방문 약속이 이루어져야 한다.

■ 도와주는 사람이 있어야 한다.

야 한다. 사정한 결과가 모두 정상이며, 산욕기 시작부터 퇴원하는 시간까지 모든 수치가 정상 범위 내에 들어야 한다(표 6-1-12).

조기퇴원이 적용되는 경우는 적절한 경제적 자원, 건강 간호에 대한 즉각적 사정, 안정된 가정환경, 가정 내에서의 좋은 지지체계 등이 있는 경우이며, 조기퇴원 조건에 부합될지라도, 나쁜 결과가 거의 없을 정도로 부모로서의 역할 준비가 잘 되었을 경우 조기퇴원이 가능하다. 조기퇴원한 산모와 신생아는 퇴원 후 48~72시간 내에 의사를 방문하거나 간호사의 가정 방문을 받아야 한다. 가족에게 잘 숙련된 간호와 교육을 제공하면 가족들의 적응에 많은 도움을 줄 뿐 아니라 산모와 신생아에 대한 신체·정신적 반응 정도를 평가할 수도 있고, 자신 및 신생아를 간호하는 기술, 가족 대처 기능, 성생활, 피임, 그리고 다른 자원의 이용 여부도 파악할 수 있다.

간호사는 고위험 문제가 있는지를 파악하여 적절한 수행을 제공하든지 그 문제에 도움을 줄 만한 자원을 알려주어야 한다. 필요하다면 가정방문도 가능하다. 문제가 있을 때에는 조기에 발견하여 더 이상의 합병증을 예방해야 한다.

5) 간호평가

간호를 효과적으로 수행했는지에 대한 평가는 재사정(reassessment)을 통한 회환(feed back)의 계속적인 과정을 통해 이루어진다. 간호사들은 간호중재의 성공 여부를 결정하기 위해 신체적, 정신적, 지지적 간호 영역의 평가를 실시한다.

신체적 간호의 적절성 평가는 간호중재의 목적에 부합되는 사항, 즉 출혈의 조절, 불편감 해소, 배변, 배뇨의 가능, 성공적인 조기 이상, 감염 방지, 정상적이고 급진적인 회복, 그리고 적절한 영양과 수분 공급 등이다.

정신적 측면의 간호 역시 간호 목적에 맞는 결과들을

가지고 평가한다. 교육의 적절성은 산모 자신 및 신생아 간호의 수행 여부, 그리고 산모의 지식(예를 들어 위험 증상, 즉시 의사를 찾아야 할 때, 이용 가능한 자원, 신생아의 행동, 가족 적응 등)을 평가해봄으로써 알 수 있다. 지지적 간호에 대한 평가는 산모의 표현을 통해 혹은 외견상으로 산욕기 동안 잘 적응하는 것, 산모가 자신의 인지상태를 나누고 감정을 표현하는 것, 그리고 보호받는 환경 내에 있다는 감정을 갖는 것 등으로 이루어진다.

산모와 가족의 간호 목표

- 정상적인 자궁 퇴축이 있다.
- 신체 기능이 효과적인 치유와 정상적 회복을 한다.
- 합병증을 예방하거나 최소화한다.
- 편안함, 휴식, 활동의 조화를 이룬다.
- 수유와 회복을 위한 적당한 영양상태를 유지한다.
- 자신과 아기를 돌보는 지식과 기술을 발전시킨다.
- 신체적, 정서적 변화를 이해한다.
- 아기로 인한 가족구성원 변화에 적응한다.

2. 퇴원 후 방문 간호교육

대부분 생식기관이 분만 후 6~8주 후에 임신 전 상태로 회복되기 때문에 산후방문은 4~6주 후에 이루어진다. 그러나 엄마나 아기에게 문제나 합병증이 있을 때는 더 일찍 진찰방문을 하게 된다. 이때의 간호는 자궁수축 상태, 엄마의 신체 건강상태, 회복상태, 가족의 새 아기에 대한 적응상태, 성관계와 피임의 필요, 아기의 성장 발육을 관찰한다.

1) 간호사정

산후방문 시에 몸무게와 혈압을 재고 소변검사, 혈액 검사를 한다. 복부근육의 상태를 관찰하고 유방을 검사

한다. 엄마가 젖을 먹이는 경우에는 유두상태와 젖의 상태를 관찰하고 젖을 먹이지 않을 경우에는 젖 분비가 멈추었는지 관찰한다. 자궁상태, 회음 절개 부위 상태, 회음 열상, 골반저근육의 탄력, 자궁퇴축이 다 되었는지 알기 위해 골반검진을 한다. 자궁출혈의 양, 상태를 관찰하고 신체의 변화와 질문이 있으면 토의하도록 한다. 새 아기에 대한 가족의 반응을 이야기하고, 아기의 행동, 수유상태, 수면, 배변, 몸무게의 증가, 울음상태 등에 대한 질문에 대답한다(표 6- I -13).

2) 간호중재

퇴원 후 방문 시 감염이나 상처 치유에 문제가 있다면 치료하고 진찰이나 검사가 필요하면 조치하도록 한다. 진찰은 출생 경험에 관련된 문제에 관심에 대한 이야기를 할 수 있는 기회가 된다. 엄마의 휴식과 운동에 관한 관심, 몸무게, 식이요법, 에너지 수준, 집안 일, 친척과 친구와의 관계, 신체적인 불편 등을 이야기한다. 증가된 몸무게가 문제가 되면 적당히 체중을 줄이는 식이요법과 운동프로그램을 시작하도록 한다. 직장생활은 합병증이 없고, 정신적으로 준비가 되었다고 느끼는 한도 내에서 다시 할 수 있다. 그리고 더 이상의 간호가 필요하거나 자문이나 의뢰가 필요하지 알아낸다.

방문 시 피임 문제를 이야기하고 임신을 방지하기 위해 어떤 피임법을 사용할지 결정해야 한다. 부부는 사용할 피임법에 대한 사용법과 위험에 대해 배우도록 한다. 간호의 효율성은 엄마와 가족의 적응결과에 의해 결정된다. 자궁출혈의 정상회복과 회음 절개 부위 상처의 회복은 엄마와 아기의 만족스런 상호관계, 모성능력의 발전과 엄마와 아기의 효과적인 적응 결과를 상징한다. 엄마, 아빠, 가족에게 새 아기에 대한 효과적인 적응을 설명하고 새로운 일상생활을 계획하고 안정시킨다. 엄마와 가족의 질문에 대해 충분히 상담하고 교육하여, 자기의 가정을 꾸려나갈 수 있는 능력을 확인해

야 한다.

3. 산후 관리

1) 산후조리의 정의

출산한 여성이 임신 전의 건강상태로 회복하고 건강을 유지하며 증진시키기 위하여 일정한 기간 동안 산모가 준수하여야 할 구체적인 방법과 과업을 의미한다.

(1) 전통적인 산후조리

전통적인 산후조리(traditional postnatal care)는 6가지 원리로 이루어져 있다.

제1원리는 ‘몸을 따뜻하게 하고 찬 것을 피함으로써 기운을 돋우기’로 음양이론(Yin-Yang theory)에 영향을 받는 대표적인 원리로 몸을 따뜻하게 함으로써 산모가 기운을 내도록 한다. 방법은 따뜻한 음식을 먹이고 환경을 조절해주는 것이다. 이 원리를 지키지 않으면 찬 공기나 바람이 입과 코, 산후에 늘어난 살과 뼈, 관절, 땀구멍, 털구멍, 피부 세포 등을 통하여 들어가게 된다. 특히 근육량이 적고 혈액순환이 잘 안 되는 여성의 경우 몸을 따뜻하게 하는 것은 산후 건강한 회복과 산후병 예방을 위한 필수 여건이 된다. 체온이 1~2℃ 올라가면 대사가 2배 증가되며 대사가 왕성해져야 회복도 빠르다. 그러나 인위적으로 땀을 흘리게 하거나 한 여름에 땀띠가 나도록 땀을 내는 것은 금해야 한다.

제2원리는 ‘일하지 않고 쉬기’로 신체적, 정신적으로 휴식하는 것을 의미한다. 정신적 휴식은 마음이 편안하고, 즐거운 상태를 유지하는 것으로 가족과의 상호 노력 속에서 성취될 수 있다. 산후에는 에스트로겐의 저하로 골밀도가 낮아지고 인대가 늘어진 상태가 되어, 편안히 누워서 자고 쉬면서 몸을 구부리지 않고 완전히 펴서 이완된 상태를 유지해야 한다. 그러나 골반근육이

표 6- I -13. 산욕기 회복의 평가 기준, 사정 분야 및 정상상태

분만 후 2주		분만 후 4~6주
체온	•분만 후 24시간 이내에는 38℃(100.4℉) 이내의 상승은 분만으로 인한 탈수열이므로 정상. 만약 비장근육의 통증이나 악취나는 오로가 있으면 정상적인 것이 아님 •체온 상승이 분만 24시간 후에 나타나서 48시간 이상 지속되면 비정상	임신 전 상태로 회복
맥박	•분만 후 맥박이 1분간에 50~70번으로 떨어짐. 서맥은 6~8일간 지속될 수 있음	임신 전 상태로 회복
호흡	•정상범위 내에 있음	
혈압	•정상범위	
유방	•분만 후 2~3일에 초유가 분비되기 시작하고 차츰 양이 증가함 •유방의 울유가 나타나므로(경산모는 2일, 초산모는 3일) 유방이 단단해지고 통증과민과 유방 팽창이 일어남. 울유는 정맥과 림프순환의 저류로 인해 오며 통증은 36~48시간 내에 없어지고, 젖이 분비되며 부종도 자연 소멸됨. 체온 상승은 37.4℃ 이내임 •울유가 있는 후에 성유가 분비되고, 아기가 유두를 흡인하므로 사출반사가 일어남	
자궁	•정상으로 자궁의 퇴축이 진행 중, 자궁의 크기가 줄어듦 •분만 직후 자궁의 무게는 1kg •자궁의 위치 : 제와부위 중앙이나 약간 우측으로 치우침. 하루에 1cm씩 골반강 내로 하강 •자궁근의 긴장도는 자궁근의 수축과 견축에 의해 유지됨 •자궁축지의 느낌은 단단하고 마사지 후에 즉시 수축되고 혈괴의 배출, 방광과 직장이 비어 있을 때 수축이 잘됨. 분만 후 첫 12시간 내에는 수축이 강하고 규칙적이고 조화가 잘됨. 그 후에 강도, 빈도, 규칙성이 줄어듦. 산후통은 2~3일 동안 나타나며, 경산모가 초산모보다 더 심하고, 수유 시에도 심하다.	자궁은 비임신 시보다 약간 크며 전방전위됨. 만약 후방위면 위치가 변화한 것이다.
오로	•적색오로 : 3일 이내의 자궁 분비물. 혈액, 태반, 탈락막 조각과 응고물이 나타나며 암적색임 •갈색오로 : 4~10일 이내의 자궁 분비물. 묽고 장액성으로 갈색임 •백색오로 : 누르스름한 흰색이고 백혈구, 유기체, 자궁경부점액으로 10일~20일 지속되며 길면 6주까지 분비 •냄새 : 약간 역겨움 •양 : 2~3일은 중정도이고 그 이후는 줄어듦. 3주 후에 없어짐. 때로는 6주까지 지속	오로 : 4주 지속 후에 없어짐 질분비물 : 소량 월경 : 분만 후 14~15주에 회복, 모유수유 여부에 따라 다름

<계속>

표 6-1-13. 산욕기 회복의 평가 기준, 사정 분야 및 정상상태

분만 후 2주		분만 후 4~6주
경관	모양 : 며칠 후면 회복 외자궁구 : 1주 후에 수축(1cm probe 삽입이 어려움) 경관 점액 축적	경관치유 : 외자궁구는 황으로 약간 열려져 있음. 경관의 선에는 상피세포가 덮이고 외자궁구 주위는 밝은 적색으로 보임.
질	질의 팽창성 : 질 입구가 분만 시 힘을 줄 때 생긴 복압이나 기침으로 인해 포도 모양으로 약간 팽창되어 있음	골반저근의 긴장감 회복. 약간의 자궁하수, 방광류나 직장류는 묵인됨. 외음과 회음부의 감염은 없음. 회음절개 부위, 열상부위 치유되고 성관계 시 불편감 없음
복부	복벽 : 복부 중앙이 늘어나 있고 약함, 복부근육은 넓게 분리되어 있어서 만지면 복부의 옆면이 mass가 있는 것처럼 느껴짐(자궁저부와는 혼동 없음)	복부근육이 약간 느슨함. 그러나 긴장감은 임신 전 상태로 회복됨.
체중	체중 감소 : 분만 즉시 4.5~5kg, 첫 3~4일에 다시 1.8~2.3kg 감소, 그 후에는 자궁 퇴축과 혈장량 감소에 따라 체중이 줄어듦	산모들은 임신 시 증가된 체중(11kg)의 60%가 산욕기가 끝난 후에도 그대로 남아 있다.
비뇨기	자연배뇨 : 분만 후 8시간 이후에는 용이하며, 2~7일 사이에는 소변을 자주 본다(체내에 축적된 수분 배설 때문에).	비뇨기에 감염증상 없음(예 : 빈뇨, 요급증, 배뇨곤란, 실금) 소변검사 결과 : 정상, 단백뇨 없음, 유당은 수유모에게 볼 수 있음
위장관계	공복감이 있고 식욕이 좋음. 배변 : 3일째 자연배변. 규칙적인 변습관이 회복되기 위해 완화제나 관장을 해줄 것. 섬유질이 많은 식품과 수분 섭취 증가	식욕 양호, 식이는 체중을 유지 또는 감량에 따른 계획을 세운다. 만약 수유를 하면 칼로리를 500cal 증가시키고 수분 공급은 500ml 증가시킨. 규칙적인 배변 습관의 회복. 변실금이나 수공 형성이 없음. 치질 완화, 정맥류 소멸. 필요하다면 긴 양말로 지지
혈관계	수분 축적으로 인한 혈액농도가 정상으로 회복됨. 가끔 혈전이 생김 헤마토크리트 : 분만 후 3일에 정상으로 회복됨 혈전성 색전이 없음	혈색소치 12g 또는 그 이상 헤마토크리트 level : 37%
통증과 불편감	많은 산모들이 분만으로 인한 스트레스와 긴장을 1~2일까지 느낌. 회음 절개 부위, 치질, 유방 울혈 또는 다른 원인으로 불편감을 가지나 3~5일이면 없어짐	회음 절개 부위의 불편감
정서적 반응	초산모는 분만 후 24~48시간 동안 특징적인 의존적 행위를 보임. 대개는 의존적 행위와 독자적 행위가 혼합되다가 독자적 행위로 변화함. 분만 후 2일째에 산후 우울감이 나타나서 1~3일간 지속됨. 모아관계는 즉각적으로 긍정적이 됨. 부부는 분만 경험에 대하여 자유롭게 대화함	정서상태가 안정됨. 가족의 역할이 새로이 형성
신생아 간호 건강유지	신생아 간호 기술이 신체적 회복과 시범을 통하여 증가됨. 부부가 피임법에 대해 알고 활용할 수 있음	육아 기술이 능숙하고 덜 불안해함. 부부가 선택한 피임법을 실천

약해지지 않도록 가볍게 시작하여 점차 늘려가는 체계적인 산후 운동이 필요하다.

제3원리는 ‘잘 먹기’로 산모를 위해 특별히 처방되고 마련된 음식을 먹는 것이다. 특히 근육량이 적고 혈액순환이 잘 안되는 여성에게 더 요구된다. 철분, 칼슘, 요오드가 많이 들어 있는 따뜻한 미역국과 보양식으로 몸에 기운을 돋운다. 치아와 소화기를 보호, 몸의 회복과 혈액순환을 증진하는 음식을 권장하고, 자궁 내 남아 있는 오로의 배출을 증진한다. 산모의 바람직한 식생활은 식욕을 돋우고 부정한 음식으로부터 보호한다는 원리를 포함한다. 즉 따뜻하고, 부드럽고, 연하며, 짜거나 맵거나, 달거나 시지 않고 기운을 돋우는 음식을 하루 5회에서 7회 제공한다. 동물성 단백질을 과다섭취하면 체내에 칼슘이 배출되기 쉬우므로 콩, 두유 같은 식물성 단백질을 섭취한다.

제4원리는 ‘무리하게 힘을 쓰지 않아 몸을 보호하기’로 몸이 완전히 회복되기 전에 몸을 과도히 사용하지 않도록 하는 것이다. 이를 위해 따뜻한 방에서 적당히, 그리고 주의하며 움직이도록 추천해야 한다.

제5원리는 ‘청결 유지하기’로 다른 원리들과의 조화로운 관계 속에서 행해져야 한다. 그러나 질병이 없이 몸이 완전히 회복되는 것이 청결을 위해 씻어서 얻어지는 일시적인 상쾌함보다 훨씬 중요하다. 전통적인 회음 청결의 한 방법으로 쑥을 이용하는 것(쑥찜, 쑥물에 앉기)이 있는데 이는 쑥이 체내의 냉기를 몰아내고 몸을 따뜻하게 하며, 지혈, 소염, 진통, 그람음성균의 성장 저지 및 항염증작용이 있고, 또한 요통, 월경곤란증, 허약 자궁, 산후 출혈을 예방하기 때문이다.

제6원리는 ‘정성껏 돌보기’로 산모의 주위 사람이 산모를 정성껏 돌본다는 것이다. 우리나라 여성은 전통적인 산후조리를 중요하게 여겨, 병원에서 이루어지는 산후조리는 충분하지 않다고 생각하며 가정 내에서 남편을 포함한 가족의 지지를 받는 개별적 보살핌을

기대한다.

최근 가정에서 가족의 돌봄을 받는 산후조리 외에도 훈련된 산후조리요원의 돌봄을 받거나 산후조리원에서 1~2주 지내고 오는 경우가 늘고 있다. 임신을 의료화하여 고위험 요소를 부각시키고 임부의 내재적 힘과 역량은 위축시킨 채 의료전문인의 ‘관리’를 강조하는 시대적 담론을 비판적으로 볼 수 있어야 하듯, 그 영향이 왜곡된 산후조리문화로 나타나지 않는지 살펴야 할 것이다. 즉, 산욕기의 의료화를 지양하여 산모는 스스로 돌보며 어머니가 되어갈 수 있는 힘을 지닌 존재임을 인식하고 독려해야 한다. 또한 산욕기의 상업화 경향에 주의해야 한다. 산모가 충분한 휴식과 돌봄을 받도록 돕는 개념을 넘어, 일부 산후조리원에서 산모를 위한 고가의 피부관리, 보양식, 취미프로그램을 강화하는 데 집중하여, 왕비대접을 받을수록 좋은 산후조리를 한 것으로 착각하게 하는 현상은 산후조리의 참의미에 어긋나는 것이다. 이러한 왜곡된 시대적 담론을 인식하여 산모의 신체적 회복뿐 아니라 신생아를 돌보는 능력과 이에 대한 준비와 자신감, 모아 간의 애착증진 등 어머니가 되어가는 과정을 독려함으로써 산후조리기간이라는 기회의 창을 제대로 활용해야 할 것이다.

(2) 고서를 통해 본 산후조리

① 천금방 ; 당나라 손사막(581~682)

산후관리를 잘 하지 못하면 신체가 강직하여 뒤틀어지는 바람이 생긴다.

② 부인대전양방 ; 송나라 진자명(1190~1270)-한의학계 최초의 산부인과 전문의학서

산후에는 바람을 꺼려 산문을 단단히 보호해야 한다. 비록 7일 후라도 보온을 잘 해서 반드시 따뜻한 의복으로 배를 따뜻하게 해야 한다. 바람과 한기를 피하지 않고 옷을 벗고 목욕을 하거나 찬물에 빨래를 하면 그때

에는 크게 나쁜 것을 모르나 한 달 후에는 피로가 생겨 팔, 다리, 허리, 허벅지가 시큰거리고 무겁고 시리면서 아프고 뻣속까지 바람이 들어오는 것 같은데 이는 이름 있는 의사라도 치료할 수 없다.

③ 의학입문

산후 7일 이내에는 절대로 씻어서는 안 된다. 7일이 지나서야 따뜻한 물로 침구에 앉아서 씻을 수 있다. 한 달이 지나야 비로소 세수와 머리를 감을 수 있고 두 달이 지나야 목욕을 할 수 있다. 너무 일찍 옷을 벗고 씻거나 목욕하면 몸이 뻣뻣하여 활과 같이 몸이 휘어지니 이것을 산욕바람이라 한다.

④ 동의보감 잡병편에 수록된 산후허로(産後虛勞)

산후에 충분한 회복기가 지나기 전에 칠정(七情 : 喜, 怒, 哀, 樂, 愛, 惡, 慾)을 과도히 하고 힘든 일을 많이 하며 바느질을 하거나 차고 냉한 음식, 찔지고 굳어 소화하기 힘든 음식 등을 과식하고, 찬바람을 쐬거나 하면 당장에는 몰라도 좀 지나면 산후 쇠약증이 생긴다. 해산 후 백일이 지나야 비로소 부부관계를 다시 시작할 수 있으며 이를 지키지 않으면 몸이 허약해지고 백 가지 병이 속출하게 되니 조심해야 한다.

(3) 산후조리의 문화적 차이

산모의 문화에 따라 산모가 나타내는 반응은 다르므로 대상자의 문화적 특성을 이해해야 한다. 문화적 신념과 인종적 차이, 관례들은 산후 기간 동안 부모의 행동에 영향을 준다.

중국, 베트남, 필리핀, 인도네시아, 남미, 카메룬, 사우디아라비아 등은 우리나라와 마찬가지로 출산 후 따뜻한 것을 먹고 마시고, 따뜻한 방에서 찬바람을 쐬지 않으며, 7~10일간은 샤워나 목욕을 금하고 있다. 그러나 유럽이나 서양에서는 출산 직후 차가운 주스나 우유

를 마시고, 다음날 아침부터 샤워와 조기이상을 권장한다. 그러므로 산후에 몸을 따뜻하게 유지하는 전통적 산후조리를 원하는 여성이 문화가 다른 나라에서 출산을 하는 경우 심각한 신체적·정신적 어려움을 경험하게 된다.

2) 음식 돌보기

산욕기에는 질 좋고 영양가가 풍부한 음식을 충분히 먹어 출산 후 허약해진 몸을 보완하여야 한다. 입맛을 잃기 쉬울 뿐 아니라 빈혈, 변비, 골다공증, 부기 등의 증세가 있으므로 이런 점을 보완하면서 음식을 먹는 것이 좋다. 특별히 입맛이 당긴다면 제한할 음식물은 없지만 이때 찬 음식과 짠 음식, 매운 음식, 단단한 음식은 좋지 않다. 찬 음식은 몸의 기운을 차갑게 하여 혈액순환을 저하시키고 소화력을 나쁘게 하며 생리기능 전반의 회복에도 좋지 않으므로 주의하여야 한다. 과일은 몸을 차게 하므로 많이 먹지 않도록 하며, 또한 지방이 많은 음식도 상처회복을 지연시키고 수유를 하는 경우 젖이 끈끈해질 수 있으므로 피해야 한다.

(1) 전통적 산후음식

우리나라의 전통적인 산후음식인 미역국은 칼슘이 풍부한 알칼리성 식품으로 산모의 뼈를 보호하는 데 도움을 준다. 또 요오드 함량이 많아 혈액순환을 촉진하고 오로의 배출과 갑상샘호르몬의 보충을 돕는 역할을 한다. 그리고 알긴산은 장의 점막을 자극하여 장의 소화 운동을 촉진해준다. 이렇게 미역국은 산후에 생리적으로 걸리기 쉬운 변비를 예방하고, 산모 몸의 해로운 중금속을 몸 밖으로 배설시키는 작용을 한다. 한편 미역국은 산후에 생기기 쉬운 부종을 가라앉히는 작용이 있기 때문에 몸이 회복될 때까지는 미역국을 먹는 것이 좋다. 우리나라 내륙지방에서는 산모에게 쇠고기를 넣고 끓인 미역국을 먹인다. 그러나 한방에

서는 고기가 피를 탁하게 하고 유선의 발달을 막으므로 좋지 않다고 하여 멸치 또는 조개, 홍합, 새우살 같은 해물을 번갈아 사용하도록 권장한다.

(2) 모유 분비 촉진 음식

모유의 질은 단백질에 따라 좌우된다고 한다. 생선, 쇠고기, 닭고기, 달걀 같은 단백질 식품은 유즙 분비와 상처 치유, 통증 완화에 도움을 준다. 짠 음식은 혈액순환을 저하시켜 유즙 분비를 막으므로 금하는 것이 좋다. 자극성이 강한 고추, 후추도 피하는 것이 좋고, 콜라와 커피, 초콜릿도 그 안의 카페인 성분이 모유수유 시 그대로 아이에게 전달되므로 먹지 말아야 한다. 젖을 잘 나오게 하려면 최소한 물과 우유 등 음료수를 하루에 1,500~2,000ml 정도 마시는 것이 좋다. 그러나 식혜는 젖을 말리는 음료수이므로 주의해야 한다. 채소, 과일 등 비타민이 풍부하게 함유된 식물성 식품과 감자국, 토란국, 곰국같이 걸쭉한 국물이 좋으며 쇠고기에는 숙지황을 넣고 끓여서 그 물을 계속 마시면 유즙 분비가 원활해진다. 전통적으로 모유 분비를 촉진하는 음식으로는 우족탕, 돼지족탕, 잉어탕 등이 있다.

그러나 영양과잉의 경향이 있는 현대인에게는 이와 같은 음식이 오히려 젖의 질에 악영향을 미칠 수 있으니 전문가와 상담 후 섭취하도록 한다.

(3) 산후 보양식

산후 보양식(補陽食)에는 잉어팔탕, 잉어죽, 용봉탕, 용봉죽, 호두죽, 흑염소탕, 가물치탕, 늙은 호박 등이 있으나 먹거리가 풍부한 나라의 산모에게는 오히려 모유 분비에 악영향을 미칠 수 있다.

① 잉어팔탕(잉어탕)

잉어는 소화 흡수가 잘 되는 질 좋은 단백질 성분이 많이 함유되어 있고 칼슘, 비타민 B₁이 많아 대사활성

과 탄수화물의 소화를 돕는다. 팔은 단백질, 지방, 다당류, 비타민 B₁이 풍부하고 이뇨작용을 한다. 그러므로 임신부의 부종 치료와 젖 분비 촉진을 위해 이용할 수 있다.

② 잉어죽

잉어는 여러 가지 요리로 먹을 수 있다. 잉어는 산후의 허약증세 및 소화장애, 관절통, 발열, 냉증 등에 좋은데, 특히 젖이 부족하고 식욕이 부진한 산모, 허약한 산모에게 좋다.

③ 흑염소탕

흑염소는 몸을 따뜻하게 해주고 기를 보(補)해주는 효과가 있다. 흑염소에 사물탕과 감초, 생강을 넣고 잘 고아서 먹으면 식은땀이 나고 손발, 허리, 배 등이 차거나 아픈 산후풍에 좋다. 그러나 염소는 성질이 뜨거운 식품이므로 자신의 몸의 상태와 음식의 성질을 고려해 복용을 결정해야 한다. 몸이 냉하고 손발이 찬 체질의 산모에게는 알맞으나, 성질이 급하고 열이 많은 산모는 피하도록 한다. 아기를 낳고 4주 정도 지나 몸이 어느 정도 정상으로 돌아왔을 때 먹기 시작한다. 속이 더부룩하고 소화가 안 되며 변이 묽어지는 증세가 나타나면 복용을 중단한다.

④ 가물치탕

가물치는 산모에게 좋은 물고기라 해서 ‘가모치(佳母치)’라는 이름이 붙었다. 가물치에는 질 좋은 단백질이 많은 뿐 아니라 소화되기 쉬운 형태의 지방이 포함되어 있고 칼슘성분도 많아 조혈작용이 매우 좋은 알칼리성 식품으로 차가운 성질에 속한다. 가물치는 천연의 이뇨제로 소변 배출, 부종 완화에 효과를 나타낸다. 특히 소양인 체질의 산후조리에 효과가 있다. 임신 중 기운이 떨어지고 손발이 냉하며 잘 저리고 부을 때도 좋고 산

후에 온몸이 쭈시고 빈혈이 심하며 젖이 부족한 산모에게도 좋다. 그러나 가물치는 기름기가 아주 많은 음식이므로, 회음부 절개와 제왕절개수술 후 가물치탕은 산모의 회복을 더욱 더디게 하는 음식이다.

또한 호박에 비해 훨씬 더 강력한 이뇨작용을 발휘하는데, 출산 후 적어도 한두 달이 지난 후에 먹는 것이 안전하다. 출산하고 한 달이 넘도록 부기가 빠지지 않거나 오히려 더 부은 경우나 배뇨장애가 계속되고 갑자기 젖이 돌지 않을 경우에 먹어보는 것이 좋다.

⑤ 늪은 호박

늪은 호박은 미역국과 함께 산모들이 가장 즐겨 먹는 보양식품의 하나로, 산후 부기를 뺀다고 인식되어 대부분의 산모들이 호박물을 복용한다. 호박의 주요 성분인 카로틴은 부기로 인해 약해진 피부점막을 튼튼하게 해 주고 면역체 형성에 도움을 준다. 호박 당질의 일종인 펙틴은 유해물질을 흡착하여 체외로 배설하는 것을 돕고 이뇨효과도 있어 부기를 가라앉게 한다. 호박에는 당분이 많은데 특히 잘 익은 늪은 호박일수록 많다. 그런데 호박은 단지 이뇨작용만 하기 때문에 산후의 부종은 조금 제거할 수 있으나, 산후 저항력을 기르고 어혈을 제거하는 효능은 없다. 오히려 부종이 심하지 않은 산모가 복용하면 기운이 빠지고 허약해지는 수도 있으니 산후 만병통치약처럼 호박을 남용하는 것은 금물이다. 늪은 호박의 이뇨작용을 확대 해석한 산후의 호박 남용은 출산 직후 생리적으로 기능이 활성화된 신장에 오히려 더 부담을 주게 된다.

출산을 하고 한 달이 넘었는데도 배뇨가 개운치 않거나 부종이 있을 때는 1~2개 고아먹는 것도 괜찮다. 산모에게 늪은 호박이 좋다는 말은 한 달 뒤 호르몬이 정상으로 돌아오고 나서도 소변이 잘 나오지 않거나 다리의 부종이 빠지지 않을 때 효과를 볼 수 있다는 의미이다. 늪은 호박의 씨를 파내고 물을 넣어 중탕하거나 꿀

을 넣고 달여 먹는 것을 호박 꿀단지라고 한다.

(4) 증상에 따른 식이요법

① 변비가 심할 때

산모는 출산 때 피와 땀을 많이 흘리고 산후에도 오로가 계속 분비되므로 변비가 되기 쉽다. 잣, 은행, 행인(杏仁; 살구씨) 등을 먹거나 팔로 밥이나 죽을 끓여 먹으면 배변에 도움이 된다. 은행과 행인은 익혀서 먹고 하루에 7알 이상 먹지 않는다.

② 입맛이 없을 때

너무 지쳐 입맛이 없을 때는 맛이 부드럽고 담백한 음식이 좋다. 전복죽이나 깨죽, 잣죽, 검은깨죽 등을 간식으로 이용하면 입맛이 살아난다. 또 산모가 좋아하는 재료로 죽을 끓여 먹는다.

강한 조미료나 향신료는 오히려 식욕을 떨어뜨리므로 많이 사용하지 않는다.

3) 활동 돌보기

(1) 산후 운동

골반저근운동(Kegel's exercises)과 함께 하는 전신운동은 임신과 분만으로 늘어난 복벽과 골반근육의 수축력을 회복시키고 혈액순환을 좋게 하며 산후의 긴장과 피로를 해소시켜 준다.

(2) 보완·대체요법

산후운동과 함께 수지요법(압봉, 뜸), 발 반사요법, 귀 자극요법, 향요법 등과 같은 보완·대체요법(complementary and alternative therapy)은 산모에게 기혈의 소통을 원활히 해주어 생식기 기능의 신체적 회복뿐 아니라 정서, 심리적 안정을 가져다준다.

① 수지요법(手指療法)

고려수지요법(koryo sooji chim hand acupuncture, 유태우(1987)에 의하여 창안)의 기본원리는 인체의 축소판인 손에는 내장기능을 조절하는 14기맥과 345개의 치료혈이 있는데, 그중 특히 다섯 손가락은 오장, 즉 간, 심장, 비장, 폐, 신장과 각각 관계가 있다는 것이다. 산후 생식기 건강회복과 각종 자궁질환의 예방을 위하여 여성의 기본방인 A2, A4, A6, A8, A12, A16, A20에 삼음교혈 자리인 F6을 추가하여 자극적인 침보다는 뜸과 압봉으로 다스린다. 또한 출산 후 초유 분비와 유방관리를 위해서 유방과 관계있는 위치인 E12를 추가하는 것이 좋다(그림 6-I-7).

② 발 반사 마사지요법

발 반사 마사지요법(foot reflex zone massage therapy)은 발에 인체 각 장부 기관들에 대응하는 반사구가 있다는 반사요법 이론에 근거하여 실시하는 것으로 혈액순환을 촉진시켜 인체 혈액의 흐름을 원활하게 함으로써 유독물질을 몸 밖으로 배출하는 기능을 강화

게 하여 자연치유력을 극대화시키는 데 목적을 둔 건강관리법이다. 그러므로 반사구들을 손으로 마사지하여 자극함으로써 인체 각 부분의 기능을 조절하여 건강관리의 효과를 얻는 것이다. 따라서 산욕기 건강회복을 위하여 유의사항을 지키면서 가정에서 스스로 할 수 있는 발 관리를 10~20분 동안 매일 시행하도록 한다.

산후 발 관리 주의사항

- 식후 1시간 이내에는 자극하지 않는다.
- 시작과 끝 순서는 기본반사구인 비뇨기계 반사구(신장, 수뇨관, 방광, 요도)를 자극한다.
- 생식기에 해당되는 부위와 갑상샘, 임파선 부위는 주의 깊게 한다(그림 6-I-8).
- 자극이 끝나면 200ml 정도의 따뜻한 물을 마신다.
- 출혈이 있을 때는 발 반사자극요법을 하지 말고 부드럽게 발 마사지를 한다.
- 오로도 끝나고 출혈증상이 없을 때는 발 반사자극요법을 적용해도 된다.

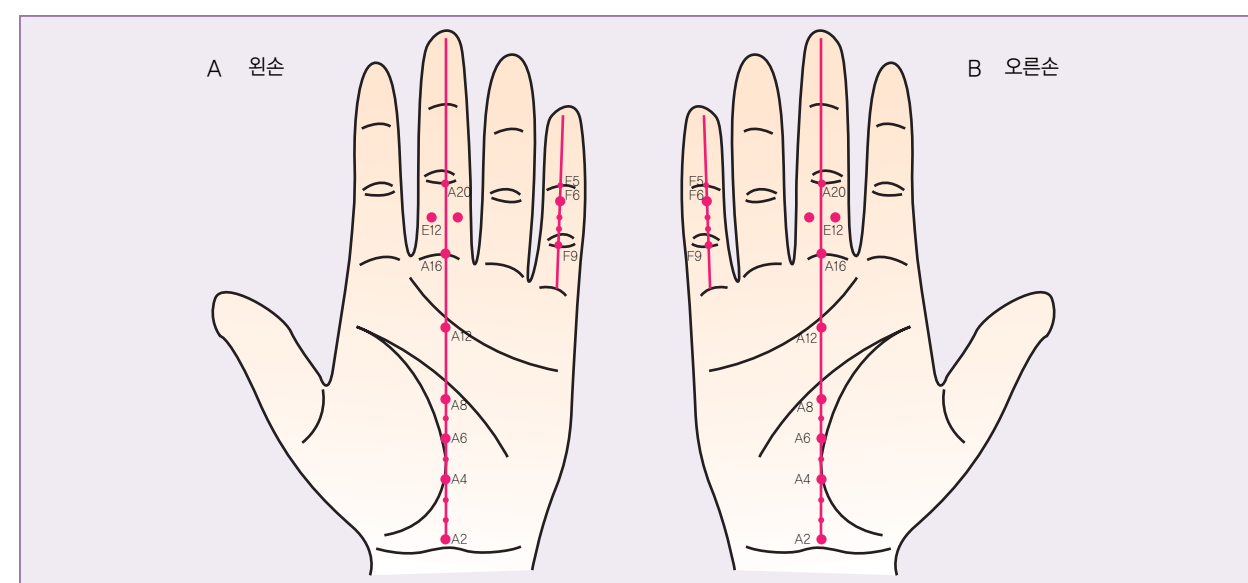


그림 6-I-7. 수지요법

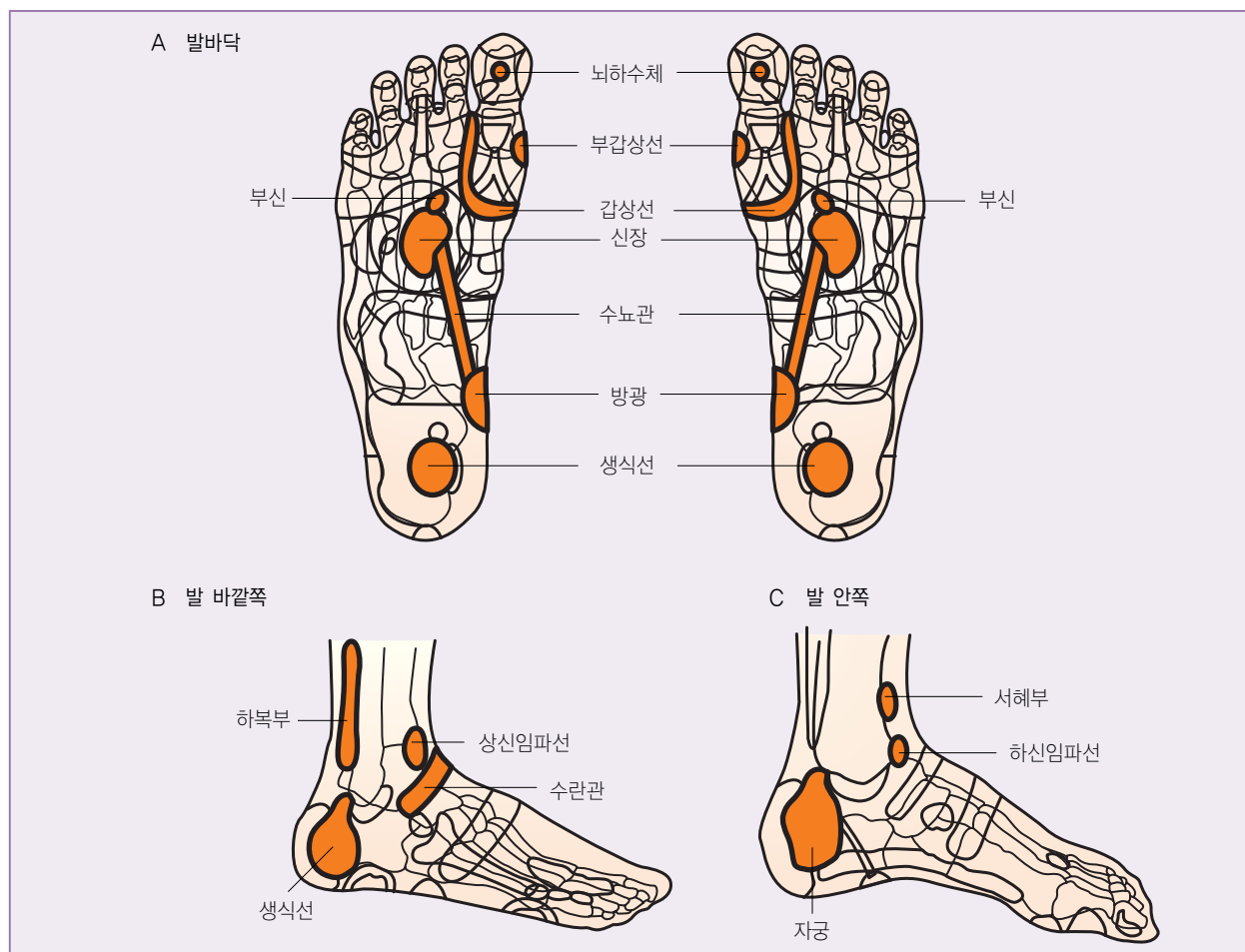


그림 6-1-8. 발 반사 마사지요법

③ 귀 자극요법

귀 자극요법(ear reflex zone therapy)이란 인체의 축소판인 귀를 인체에 상응하는 반응구역으로 나누어 그 반응점을 기통환을 이용하여 자극하는 것이다. 이는 과학적으로 검증된 자연요법의 하나로 장기는 물론 신경, 골격, 근육 등에 작용하여 질병을 예방하고 건강을 유지, 증진시켜준다. 반사구란 인체의 장기, 기관, 조직의 신경이 집결된 민감 부위를 말하는 것으로 기본 반사구와 상응 반사구로 분류한다.

산후 생식기 건강회복과 정신적 휴식을 위하여 기본 반사구인 신장, 심장, 피질하와 상응반사구인 내생식기, 외생식기, 골반강, 방광, 복부, 신문을 기통환(왕부

류의 씨앗)으로 첩압하여 자극한다(그림 6-1-9).

④ 향요법

향요법(aroma therapy)은 식물의 여러 부분, 즉 잎, 꽃, 줄기, 껍질, 뿌리, 열매 등에서 추출한 정유(essential oil)를 치료적 목적으로 사용하는 것으로 정유의 종류는 200여 가지가 넘으며 각각의 향 성분이 다르기 때문에 목적에 맞는 정유를 선택하는 것이 중요하다.

산후 정유의 사용은 방부제 효과, 항균, 감염예방 차원에서 중요할 뿐만 아니라 정서적, 영적 고양을 가져온다. 산후는 매우 민감한 때이므로 이 시기에는 모든

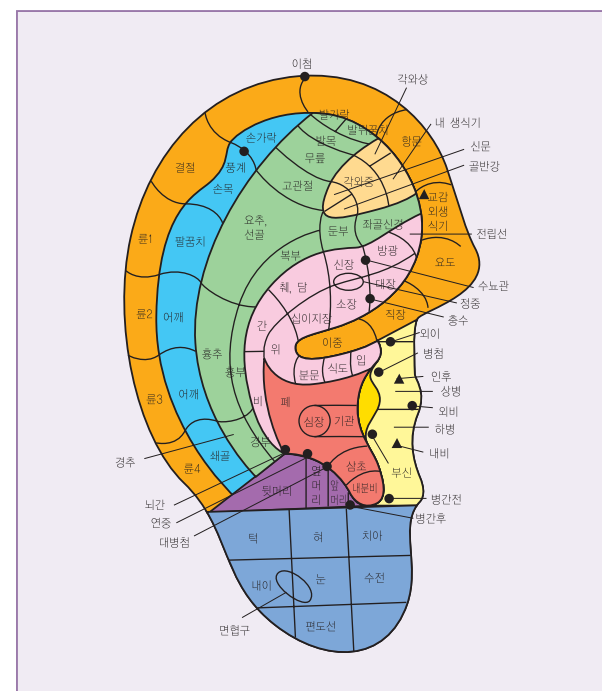


그림 6-1-9. 귀 자극요법

정유를 사용할 수는 없으며 다음에 소개하는 정유를 사용하여 샤워 후에 정유 4방울을 작은 수건에 떨어뜨려 온몸을 문지르도록 한다. 질 세척이나 좌욕 시에는 사용하지 않도록 한다.

산후에 사용하는 정유(essential oil)로는 rose, neroli, lavender, nutmeg, clary-sage, geranium, grapefruit, fennel, calendula, frankincense, myrrh, patchouli, bois de rose 등이 있다.

기분전환을 위해서는 Nutmeg 7방울, Bois de rose 6방울, Frankincense 2방울, Lemon 9방울, Rose 6방울을 마사지용 식물성 오일 2큰스푼에 섞어서 마사지하거나 발향기(發香器)를 이용하여 향을 피워 놓는다.

4) 거처 돌보기

한국인을 위한 거처 돌보기는 기본적으로 산모가 춥거나 차다고 느끼지 않게 하는 것이다. 실내 환기를 위해서는 바람의 방향과 온도를 조절하여 산모가 시원한

느낌이 들지 않게 한다. 집 안에서 거동할 때 갑자기 찬 바람을 쐬는 것을 피해야 한다. 특히 난방 시스템이 고르지 않은 가옥인 경우에 특별한 주의가 요구된다. 그러나 아파트와 같이 밀폐되기 쉬운 가옥구조에서는 지나치게 찬 바람을 막으면 환기 불량으로 실내공기가 나빠질 수 있다. 분만 후 원기가 회복되지 않은 상태에서 찬바람이나 찬물을 만지는 경우도 산후풍이 발생하기 쉽다. 산후풍의 증상으로는 손목, 발목, 허리, 어깨, 팔 등 전신이 시리거나 찬 바람이 들어오는 듯한 느낌과 오한이 나며 땀을 많이 흘리거나 심한 피로감으로 모든 일에 의욕이 떨어지면서 이에 따른 두통, 빈혈, 식욕부진, 우울증 등이 나타난다.

5) 산후 보약

산후 산모는 영양가 있는 음식을 먹고 잘 자고 잘 쉬면 건강을 회복한다. 보약은 몸에 기력을 되찾아주고 산후병을 예방할 수 있어서 좋다. 특히 뼈마디가 쭈시고 아랫배와 수족이 얼음 같고 찬 바람을 쐬면 눈물이 나는 산후풍에는 산후 보약이 필요하다. 하지만 대부분의 보약은 출산 직후에 먹는 것은 좋지 않다. 보약에 따라서는 출산 초기에 잘못 먹으면 몸속에 남아 있는 오로의 배출을 지연시켜서 몸 안에 오래 남아 있게 할 수도 있다. 보약이 도리어 해가 되지 않으려면 우선 산모의 건강상태를 충분히 살피고 고려해야 한다. 산후 보약은 무조건 몸에 좋다는 것이 아니라 허약해진 기혈을 보하고 산후회복을 빠르게 하며 산후병을 예방하는 약의 처방이어야 한다. 일반적으로 산모에게는 인삼, 황기, 당귀, 천공 등을 배합한 보허탕을 기본으로 처방하고 팔물탕, 보중익기탕 등도 많이 처방한다. 이 약들은 출산으로 허약해진 산모의 기운을 북돋아주는 효능이 있지만 산후 초기에 복용하면 오로의 배출을 지연시킬 우려가 있다. 따라서 출산 직후에 자궁을 수축시켜 오로의 배출을 촉진하고 어혈을 풀어주어 피를 맑게 하는

‘생화탕’을 먼저 복용하여 산후병을 예방한 뒤에 하복통이 없어진 산후 약 2주 후부터 여느 보약을 복용하는 것이 산모의 올바른 한약 복용법이라 할 수 있다. 또한 인삼은 소양인 산부의 젖을 줄이므로, 체질에 따라 조심해야 한다. 이와 같이 한의학에서는 임산부가 완전히 건강을 회복할 수 있도록 보약을 쓰는 법도가 있는데

이를 산후용약법이라 한다. 산후용약법은 ‘선축어(先逐瘀) 후보허(後補虛)’의 원칙에 따라 이루어진다. 즉, 산후 보약을 쓸 때 먼저 어혈을 없앤 다음에 노폐물이 제거되면 허약해진 몸을 보해야 한다는 원칙이다. 보약은 산모의 상태에 맞춰 지어야 하며 그러기 위해서는 한의사의 처방이 필수적이다.

관련사례

유○○씨는 25세의 초산모로서 24시간 전에 3,500g의 신생아를 질식 분만하였다. 신체사정 결과 출혈이나 감염증상 없이 잘 회복되고 있으며, 활력징후도 정상 범위 내에 있다. 그러나 모유수유에 어려움을 겪고 있으며 “아무래도 젖이 부족한 것 같아요. 젖 물릴 때마다 배도 너무 아파서 더 겁이 나요. 아기를 어떻게 목욕시키고 돌봐야 할지도 자신이 없고...”라며 울먹인다. 퇴원 후에는 친정어머니가 집에서 산후조리를 도와줄 예정이며, 가능한 한 빨리 퇴원하고 싶어한다.

유○○씨를 위한 간호교육을 계획할 때 가장 우선할 내용을 설명하시오.

핵심문제

1. 출산 후 신체사정 내용을 요약 설명하시오(BUBBLE-HE).
2. 퇴원 후 가정 내에서 수행해야 하는 산모의 회음부 간호를 설명하시오.

3장 출산후 부모의 사회심리적 적응

● 학습목표

- 부모와 신생아 적응을 촉진하는 신생아의 행동을 설명한다.
- 부성전환의 필수적 요소인 애착과 결속의 중요성을 설명한다.
- 부모로의 역할 이행과정을 이해한다.
- 부성적응에 대해 설명한다.
- 부모의 반응에 영향을 미치는 요인에 대해 설명한다.
- 형제의 적응을 설명한다.
- 조부모의 적응을 설명한다.

● 주요 목차

1. 부모로의 역할 이행
2. 부모의 역할행위
 - 모성 역할행위
 - 부성 역할행위
3. 부모의 행동에 미치는 영향
4. 모아관계 형성
 - 모아상호작용단계
 - 모아상호작용 촉진
 - 모아의 조기접촉
 - 초기 수유 시 모아상호작용
 - 신생아에 대한 지각
 - 신생아 양육태도
5. 출산후 우울

● 주요 용어

결속	bonding
모성행위	maternal behavior
부모	parenthood
부모전환기	transition to parenthood
부성행위	paternal behavior
사귀	acquaintance
산후 우울감	postpartum blues
상호작용	interaction
상호적응기	letting-go phase
소극기	taking-in phase
애착	attachment
예측기	anticipatory phase
적극기	taking-hold phase

부모의 역할은 생물학적으로 난자와 정자의 결합에서부터 시작된다. 부모로서의 역할을 한다는 것은 아기와 부모가 각자의 삶을 통해서 지속되는 중요한 관계를 형성하는 것이다. 부모가 된다는 것은 임신부터 시작되는 역할 획득과 역할전이과정으로 전이(transition)는 부모가 부모 역할을 수행하면서 편안함과 자신감을 느낄 때 끝이 난다. 간호사는 부모로의 역할 이행기 동안 경험하는 부모화과정을 이해함으로써 가족구성원들의 적응을 도와줄 수 있다.

1. 부모로의 역할 이행

부모와 자녀는 상호작용을 통해 역할을 수행하게 된다. 애착(attachment)은 부모가 자녀를 사랑하고 받아들이는 과정이며 자녀가 부모를 사랑하고 받아들이는 과정이다. 애착은 매력, 반응성 및 만족스러운 느낌이 상호교환되는 것이며, 근접성과 상호작용에 의해 발달되고 유지된다. 애착과정은 임신 동안에 시작하여 분만 후 초기에 고조되며 한 번 형성이 된 것은 계속되고 지속적이다. 애착은 일생 동안 정신적, 육체적 건강에 중요한데, Mercer는 애착에 영향을 미치는 요인을 부모의 정서적 건강, 동료, 친구 및 가족을 포함한 사회적 지지체계, 의사소통과 돌봄을 제공할 수 있는 능력, 부모와 아기가 가깝게 지낼 수 있는 근접성, 부모 아기 간의 적합성 등으로 설명하고 있다.

애착에 관한 이론은 정신분석적 이론, 사회학습이론, 인지발달이론, 생태학적 이론 등 다양하다.

정신분석적 이론은 인간의 사회화 욕구, 생존을 위한 신체적 욕구와 관련된 신생아의 내적 욕구를 어머니가 충족시켜줌으로써 모·아간의 유대관계가 발달되었다고 주장하는 것이다. 신생아는 빨기(sucking)에 대한 선천적인 욕구를 가지며 이러한 구강을 통한 만족의 욕구는 어머니의 가슴에 대해 애착을 갖게 만들고 이에 따라 결국 어머니에게 애착하게 된다고 한다. 그러므로 아기가 어머니 이외의 다른 사람과 먼저 애착관계가 형성되

는 것은 바람직하지 못하다. 어머니와의 애착이 일단 시작된 후 발전하여 타인과의 애착이 발생하도록 한다.

사회학습이론은 어머니가 신생아의 불쾌감을 감소시켜주거나 완화시켜주며 신생아가 쾌감을 느끼게 되어 어머니가 만족감과 즐거움을 느끼고 신생아가 어머니를 중요한 존재로 사랑하게 된다는 애착의 강화원리를 강조한다. 이 이론은 신생아의 행동이나 특성이 어머니의 반응에 영향을 미친다는 상호성(mutuality)의 개념을 포함하고 있다.

사회학습이론에서는 애착이란 선천적이거나 본능적인 과정이 아니라 신생아의 환경에서 자신에게 만족감을 제공해주는 주요한 양육자의 반복적인 관계 속에서 발달한다고 하였다. 따라서 신생아에게 음식을 제공하는 것 이외에 다른 보살핌 속에서 어머니를 이차적 강화자로 삼아 애착하게 되는 것이다.

인지발달이론은 신생아의 행동은 신생아가 도달한 인지발달 수준에 따르는 것으로서 애착에 대해서도 이와 관련시켜 설명하고 있다. 즉 신생아는 상대방을 식별하고 인지할 수 있을 때까지 특별한 애착을 나타내지 않으며, 그러한 능력이 발달되었다 하더라도 대물항상성(object constancy)에 대한 발달이 이루어진 후에야 비로소 애착행동을 나타내게 된다는 것이다. 인지발달이론은 애착에 있어 개인차가 인지발달 수준에 따른다고 설명하고 있기 때문에 애착행동 역시 인지발달이 빠를수록 보다 빨리 된다고 하였다.

생태학적 이론은 현재 애착이론 중 가장 설득력이 있는 것으로 받아들여지고 있다. Bowlby(1962)는 애착은 격리되어 양육되지 않은 모든 종(species)들에서 발견되는 것으로 환경의 변화에 거의 영향을 받지 않는다고 주장하였다. Bowlby는 진화이론과 동물관찰연구에서 영향을 받아 애착이란 모든 종이 갖고 있는 자기보호와 구제를 위해 나타내는 중요한 본능적인 반응들의 결과라고 하였다. 울음, 미소, 빨기, 매달림, 따라감 등 신생아의 행동들은 부모로 하여금 신생아를 위해 필수적인 양육과 보호를 하도록 하며 신생아와 어머니 사이에 접촉을 증진시킨다고 하였다. 즉 애착은 신생아와 어머니가 서로 상호적으로 애착하도록 짜여지고 생물학적으로 계획된 산물이라는 것이다.

애착은 아기를 독립된 한 개인 및 가족의 일원으로 인정하면서 아기와 가깝게 지내면서 상호작용을 하여야 유지될 수 있다. 애착은 상호 만족스러운 경험을 통하여 발생하며, 사회적, 언어적 및 비언어적인 긍정적 피드백을 통해 촉진된다. 애착은 아기의 기질, 사회적 능력, 외모, 성이 부모의 기대에 적합할 때 좀 더 빨리 나타난다.

초기의 부모 자녀 간의 애착은 후에 사회·인지적 발달에 영향을 주며, 애착은 내적인 것으로 객관적으로 관찰하기 어렵지만 눈맞춤, 웃기, 울기, 빨기, 매달리기, 따라하기 등이 애착행동으로 해석된다. 애착이 생

기면 행동의 신호를 알아차리고 애착행동을 한다. 애착이 없다면 행동장애가 온다.

결속(bonding)은 어머니가 진통 및 아기와의 눈맞춤, 아기의 웃음 등을 경험한 후에 생기는 것으로 처음에는 아기에게 별로 사랑하는 감정이 없다. 따라서 결속은 어머니의 이성, 생의 경험, 아기의 행동특성에 따라 달라진다. 특히 결속은 환경에 따라 좌우되어 임신 및 분만 경험이 긍정적이면 강화되고 부정적이면 약화된다. 남편과 아기의 결속은 아내가 겪는 임신, 분만과정에 함께 참여한 정도에 따라 달라지며, 남편의 참여 정도가 많을수록 결속은 더욱 강화된다.

Klaus와 Kennel(1976)은 결속이란 현상을 정의내리면서 출산 후의 시간은 민감하며, 이 기간에 부모와 아기가 친밀하게 접촉하면 후에 최적의 관계로 발달할 수 있다고 하였다.

모아의 관계를 증진하기 위해, 즉 애착과 결속을 강화하기 위하여 우선 분만 후 어머니와 아기가 함께 있는 모자동실의 체제를 갖추어 모자의 분리를 없애야 한다. 또한 모아관계를 조기에 형성하도록 간호사는 분만실에서 산모가 아기를 첫 대면할 때 눈맞춤, 언어표현 등을 통하여 상호 적응하도록 도와주어야 한다. 그 외에 신생아의 인지적 특성에 관한 교육을 하며 아기 다루는 법을 시범 보여 주어야 한다.

사귀(acquaintance)은 애착의 중요한 부분으로, 분



A 신생아는 환히 웃는 얼굴에 반응한다.

B 신생아는 엄마와 시선을 맞춘다.

C 엄마가 웃고 말하면 신생아도 입을 움직인다.

그림 6-1-10. 모아관계 증진

만 후 부모는 아기와 친숙해지기 위하여 눈맞춤, 접촉, 목소리 등을 이용하여 상호작용을 한다. 부모를 포함한 가족들은 아기와 대면했을 때 아기가 가족구성원 중 누구와 닮았는지를 찾게 되며 그 다음 아기가 가족구성원과 다른 점을 확인하면서 독특한 존재로서의 아기를 가족의 일원으로 받아들인다.

부모와 아기의 애착 증진을 위해서는 간호사의 역할이 중요하다. 간호사는 부모와 아기의 상호작용에서 양쪽의 감각적 반응이나 능력을 사용함으로써 이들의 애착을 증진시킬 수 있다. 즉 간호사는 부모로 하여금 아기가 나타내는 반응에 대한 인지능력과 아기와의 의사소통 능력을 강화시켜줌으로써 아기와 긍정적으로 접촉할 수 있도록 도와주어야 한다.

2. 부모의 역할행위

부모의 역할은 임신기간부터 분만 후 기간을 거치면서 변화하며 그 변화의 과정은 대개 예측할 수 있다. 임신기간 동안 임부는 건강한 아기의 출산을 위해 임신 중 식사, 운동 및 휴식 등에 대해 신경을 쓰게 되며, 태어나는 아기와 애착형성을 위해 노력하게 된다. 분만 후에는 부모로서의 새로운 과업과 부모 역할에 맞는 새로운 행위를 하게 된다.

1) 모성 역할행위

(1) 모성 역할

Mercer는 모성 역할 획득(maternal role attainment)이란 확립된 역할 구조 안에서 모성행위를 통합시키며, 어머니 역할에 대한 능력을 성취하는 과정으로 어머니로서의 정체감을 편안하게 만든다고 하였다.

Mercer는 후에 이 개념을 어머니 되기(becoming a mother)로 새롭게 정리하며 어머니 역할은 한순간에

체득되는 것이 아니라 과정적 특성과 역동적 성장이 있음을 강조하였다(Mercer, 2004). 모성 역할 획득에 관련되는 중요변수는 산모의 연령, 분만 경험에 대한 지각, 산육 초기 모아의 분리상태, 지지체계, 성격, 어머니 및 영아의 질병, 양육 태도, 영아기질, 그리고 문화, 사회적 수준 등이 있다.

모성 정체감은 모성 역할 획득의 한 요소로, 모성 정체감 형성은 역할 내면화와 동시에 발생하기도 하며 역할획득의 마지막 단계가 되면 역할이 내면화되어 정체감 확립이 되기도 한다.

모성 역할은 두 가지 요소로 구분할 수 있다. 즉 정서적 요인으로서의 모성(maternity)과 신체적 돌봄으로서의 모성행위(mothering)이다. 정서적 요인으로서의 모성은 아기와의 유대 및 애착 애정 등을 의미하며 따뜻함, 헌신, 보호, 아기에 대한 관심, 즐거운 기대 등의 감정을 포함한다. 신체적 돌봄으로서의 모성은 '한 사람이 다른 사람을 돌보는 관계'로, 아기에게 필요한 수유, 목욕, 기저귀 갈기 등의 행동이다. 정서적 요인으로서의 모성이 발전된다면 신체적 돌봄으로서의 모성은 부수적인 것이다. 예를 들면 직장에 다니는 어머니는 신체적 돌봄 차원의 모성행위는 거의 못하지만 정서적 요인 차원의 모성은 계속 발전하고 유지되어 건강한 모아관계를 형성한다.

(2) 모성 행위

어머니는 상상해왔던 아기를 실제로 갖게 되어, 보고 만지고 듣고 냄새를 맡을 수 있게 되었으나 임신 동안 아기에 대해 겪었던 두려움이 여전히 상상 속에 남아 있다. 어머니는 또한 아기의 다른 감각, 시각·후각·청각·바이올리듬 등을 확인하고 그것을 친근해지는데 사용한다.

- **접촉** : 접촉(touch)은 신생아와 관계를 형성하는 수단으로 가장 많이 사용된다. 접촉에서 가장 민감한

신체부분 중의 하나는 손가락 끝이다. 아기를 처음 대면한 후에 어머니는 처음 하는 접촉행위로 손가락 끝을 이용한 접촉을 하게 되며, 손바닥과 팔을 이용해 아기를 다루는 행위를 한다. 첫 접촉행위의 시작은 접촉의 포근함, 옷의 압박, 아기의 신체적 상황에 따라 수 분에서 수 시간이 걸릴 수 있다. 처음에는 손가락 끝으로 아기를 탐색하며 신체의 부위(머리, 얼굴, 체표면 등)를 만진다. 다음으로 손바닥을 벌려 아기를 안는다. 그리고 아기를 팔로 안아서 품으로 안아 올린다.

접촉하는 행위는 문화에 따라 차이가 있으며, 접촉 중 아기가 좋아하는 방법과 싫어하는 방법을 구별하면 부모와 아기가 좀 더 친밀해진다.

- **눈맞춤** : 어머니와 아기가 눈을 맞추는 것은 시각 발달과 신뢰형성에 효과적이다. 간호사는 어머니와 아기가 눈맞춤을 자주 하도록 한다. 이때 간호사는 눈맞춤이 방해되지 않도록 아기 눈을 뜨게 하기 위해서는 약간 빛을 어둡게 하는 것이 좋고 어머니가 아기를 안을 때 시각 접촉을 위해 아기와 얼굴을 마주 볼 수 있도록(enface position) 아기를 이동해야 한다(그림 6-1-11). 이러한 마주보기 자세는 부모의 얼굴과 신생아의 얼굴이 같은 평면에서 약

20cm 떨어진 자세로, 상호작용이 많이 일어난다.

- **냄새** : 부모와 아기는 서로의 냄새에 대해서 반응하는 행동을 보인다. 어머니는 아기가 태어난 직후 아기들은 각각 특유의 체취를 갖고 있고 아기 또한 엄마의 모유 냄새를 구별하게 된다는 것을 알 수 있다.
- **목소리** : 부모와 아기는 서로의 목소리에 대해 뚜렷하게 반응한다. 부모와 아기는 목소리로 서로 알아보게 되는데 아기는 첫 울음으로 자신의 건강상태를 알려주게 되고 부모가 고음으로 말을 하면 아기는 각성하고 고개를 돌린다.
- **바이올리듬** : 아기는 태어나기 전에 심박동과 같은 어머니의 자연적 리듬에 익숙해져 있다. 출생 후 아기는 바이올리듬을 확립하는 과업을 갖게 된다. 부모는 이 과정에서 일관성 있고 지속적인 사랑으로 돌보고, 아기가 기민한 상태일 때 아기와 접촉해 반응하게 함으로써 사회적 상호작용 학습을 위한 기회가 증가하도록 도울 수 있다. 부모가 아기를 능숙하게 돌보게 되면, 심리적 이미지를 관찰하고 빠르게 반응함에 따라 아기가 보내는 신호를 더 잘 알아차릴 수 있다.

어머니는 아기의 외모와 행동을 자신에게 의미가 있



A 엄마와 아기가 눈을 맞춘다.



B 손가락 끝으로 신생아를 탐색하는 과정

그림 6-1-11. 엄마의 접촉을 통한 동일화 과정

고 친숙한 사물이나 사람과 관련시키기도 하며 마침내 아기의 행동이나 특성이 의미하는 것과 의미하게 될 것을 해석하게 된다. 어머니는 곱슬머리가 여자아이에게 멋질 것이라든지 아기가 즉시 젖을 찾는 것을 보고 튼튼하고 건강한 성품을 가질 것이라고 기대하기도 한다.

애착이 진전되면서 상호조절과 상호의존 단계를 발견할 수 있다. 아기와 어머니는 둘만의 암시체계를 발전시키고 이러한 암시체계는 어머니와 아기의 상호요구를 충족시키게 된다. 어머니는 아기의 상태에 민감해져야만 하고 아기는 어머니가 알 수 있는 신호와 암시를 보내는 방법을 배워야 한다. 이렇게 하는 동안 상호조절의 부정적인 감정이 표출될 수도 있는 어머니는 아기의 요구사항이 너무 많고 아기의 암시를 이해할 수 없다고 느낄 수도 있으나, 상호조절은 결코 순간적인 것이 아니고, 이는 신생아기에서 대략 아동기까지 계속된다. 만약 어머니의 이러한 감정이 의료인이나 가족에 의해 부정된다면 어머니는 자신이 부적합하다고 느끼며 죄의식을 가지게 되고 부정적인 감정을 심화시킬 것이다. 이 시기에 이러한 감정들이 자연스럽다는 것을 인정하게 하는 간호사의 지지는 어머니와 아기의 상호작용을 많이 고무시켜주게 된다.

(3) 산모의 심리적 변화과정

Rubin은 어머니에 중점을 두고 어머니의 접촉과 아기에 관련된 어머니의 행동의 다양한 단계를 파악한 선구자이다. 즉 그는 어머니의 역할이 자녀의 정서적, 지적, 육체적 발달을 조장하도록 계획된 일련의 개인 상호적인 행동기술이라고 주장하였다. 그는 산욕기에 산모의 심리적 변화과정을 소극기(taking in phase), 적극기(taking hold phase), 상호적응기(letting-go phase)로 나누었다.

① 소극기

분만 후 첫 2~3일 동안 산모의 특성을 소극기(taking in phase)라고 한다. 이 시기는 새롭게 어머니가 된 산모가 보살핌과 보호적인 간호를 요구하는 시기로, 산모는 먹고 자는 것이 가장 중요하다. 그들은 수동적이고 의존적인 경향이 짙으며 모든 행동이나 사고는 자기중심적이다. 수면과 휴식은 이 기간에 필요 불가결한 것으로 분만 후 얼마 동안은 지쳐서 깊은 잠 속에 취해 있다. 이렇게 수면을 계속적으로 취하는 것은 분만으로 소모된 에너지를 회복하기 위한 활력소가 된다. 이때에 충분한 수면을 취하지 못하면 심한 수면부족에 빠지게 되어 며칠 동안 피로감이 지속되며 정서적으로도 안정 부절못하게 된다. 그 결과 산욕기의 회복과정이 지연될 수도 있다. 따라서 산모는 충분한 휴식과 수면을 취할 수 있는 시간과 환경이 확보되어야 한다. 분만 시에 산모는 심한 노동과 에너지가 소모되며 분만 전 과정을 통하여 오랜 시간 동안 먹지 못한다. 그러므로 먹고 싶은 강한 욕구는 회복과정에서 신체적이고 정신적인 면에서 자연스러운 반응이다. 이러한 때에 음식물을 충분히 섭취하게 되면 생리적인 만족은 물론이고 정서적으로도 만족감을 주게 된다. 뿐만 아니라 산욕 초기의 회복과정을 돕는 데도 매우 유용하다.

이와 같이 소극기의 산모는 의존적이고 수동적인 행동 특성을 갖게 되며 자가간호의 행위를 주도해서 적극적으로 수행하지 못한다. 간단한 육체활동일지라도 쉽게 피로를 느끼며 다른 사람이 대신 간호해주기를 바란다. 따라서 간호사는 분만 후 24시간 이내에 산모를 위한 신체적 간호를 제공해주는 것이 가장 큰 역할이라는 것을 인식하고 산모에게 간단한 활동이나 판단만을 하게 함으로써 피로하지 않도록 배려해야 한다. 산모가 필요로 하는 것을 충족하는 일을 도와줌으로써 충분한 휴식을 취할 수 있도록 하며 만족감을 갖게 하는 간호도 중요하다. 신생아의 간호요구를 산모 자신이 충분히

할 수 있기 전까지는 간호사가 도와주어야 한다. 소극기 동안에 산모는 분만을 자세히 재음미하기도 한다. 이는 출산 경험에 대한 심리적인 반응들이다. 산모는 힘들었던 분만 경험이 서서히 완화되면서 대부분 분만실에서 실제로 일어났던 분만과정의 전모를 자세히 알기를 원하며, 대개 수다스러워진다. 이때 의사나 간호사가 들려주는 바른 정보를 보통 사실 그대로 받아들이면서 자신이 겪은 임신과 분만의 경험을 실감하게 하고 자신의 아기가 출생하였으며, 탄생한 아기가 자신과 동등한 하나의 개체임을 인식하게 된다.

산모는 자신이 겪은 경험을 누구에게나 이야기하고 싶어 하며 힘들었던 분만으로 인하여 의존적 경향을 지니고 애정과 주의를 받고 싶은 욕망을 갖는다. 또한 남편이나 가족의 방문을 기다리게 된다. 이때 간호사나 남편이 인간애를 가지고 온정이 담긴 몇 마디 말로 격려를 하거나 몇 분 동안이나 귀를 기울여서 산모의 말을 들어주는 것은 어떠한 간호보다 좋은 간호가 될 것이다. 이러한 간호를 통하여 산모는 차츰 자신의 위치를 깨닫게 되고 새로운 역할을 인식하게 되어 앞으로 수행해야 할 의무를 받아들이려는 수용적인 자세를 갖게 된다.

② 적극기

적극기(taking hold phase)는 대개 산욕 3~10일간을 말한다. 이 기간은 분만으로 인한 피로가 차츰 회복되고 모성으로서의 새로운 역할을 독립적이고 자율적으로 수행하려고 노력하는 시기이다. 이 시기의 산모는 보살핌을 계속해서 받고자 하는 욕구와 아기의 양육 책임을 맡고자 하는 욕구가 있다. 그러므로 아기를 돌볼 기회가 있을 때 열심히 배우려고 노력한다.

먼저 신체적 기능 면에서는 산모 자신이 스스로의 신체를 조절하기 위해 앉거나 걷고 싶어 하며 몸을 움직여 보고 대소변을 자의로 보려고 한다. 그러나 기운이 없고 통증 등으로 분만 이전처럼 몸을 자유롭게 할 수

없으므로 “내 몸을 자유롭게 조정할 수 없는데 다른 일을 수행할 수 있을까?” 하고 걱정하며 조바심을 가지게 된다. 간호사는 다양한 교육과 설명으로 격려함으로써 산모가 신체의 기능조절을 능동적이고 지속적으로 하도록 도와준다.

이와 동시에 처음으로 산모는 어머니로서의 역할을 시도하게 된다. 이때 간호사는 육아법(수유법, 목욕, 기저귀 교환법, 아기 돌보는 법 등)에 대한 교육을 하고 시범을 먼저 보인 후 산모로 하여금 새로운 일을 수행하게 하여 자신감을 갖게 하며 새로운 일을 하는 동안에도 계속 보강이나 격려를 줌으로써 산모가 만족스러운 경험을 얻게 된다. 이를 통해 산모가 아기를 돌보는 기술에 자신을 갖게 되면 산모 자신의 신체적 간호에 대해 지도를 받는 것처럼 아기의 욕구에 대해서도 판단을 내릴 기회를 가지게 된다. 이때 간호사는 명령이나 지시를 하는 태도보다는 산모가 지도를 필요로 하는 질문에 대해 답해주고 산모가 바른 판단을 할 수 있도록 도와줌으로써 산모는 안심을 하게 되며 신생아의 요구를 정확하게 알아차리고 판단할 수 있는 자신감을 가질 수 있게 된다. 또한 또 다른 문제에 당면하였을 때도 잘 처리할 수 있는 능력을 지니게 된다. 더욱이 초산모일 때는 젖의 분비는 언제부터 되는지 등을 알고 싶어 한다.

초산모가 아기를 처음 돌볼 때 실패하게 되면(아기 다루는 법이 서툴 때, 아기가 젖을 잘 빨지 못할 때, 목욕시키는 것이 서툴 때 등) 능숙하게 다루는 간호사에 대하여 “당신은 항상 우유를 먹이며 무엇이나 쉽고 능숙하게 잘할 수 있지만 나는 아무것도 할 수 없군요”라고 말하며 절망에 빠지기도 한다. 이런 경우에 간호사는 능숙한 간호중재로 산모의 서툰 면을 충분히 보강할 수 있도록 도와주며 반대로 산모가 아기 돌보는 일을 잘 하였을 때는 아주 잘했다고 칭찬하여 사기를 높여줌으로써 가정에서 아기를 다루는 능력에 자신감을 주어야 한다. 산모는 새로운 역할을 수행해야 하는 책임감이

증가됨으로써 정서적으로 몹시 불안정한 시기에 놓이게 된다. 이 시기에 산모는 정신적으로는 아기의 돌봄을 통하여 아기를 자신과 동등한 인간으로 받아들이고 나아가서 아내로서, 가족의 한 일원으로서, 사회의 구성원으로서 주어진 책임을 충실히 수행할 수 있도록 적응해 나가게 된다.

③ 상호적응기

상호적응기(letting-go phase)는 아기에 대한 환상적 이미지를 버리고 실제 모습을 수용하며 과거의 생각과 행동을 정리하여 적응하는 단계이다. 이후 산모는 아기와의 상호의존적(inter-dependent) 과정으로 계속 자신의 새 역할을 규명해간다.

2) 부성 역할행위

아버지의 적응에 대해 지난 10년 동안 더욱 더 관심이 생기며 아버지의 행동에 대한 연구가 필요하다고 인정됨에도 불구하고 그러한 연구는 아직 초기 단계이다. 부성적응에 대한 연구는 아버지들은 부모전환기 동안

예측기를 통과한다고 지적하고 있다. 이 기간 동안 어머니와 마찬가지로 수면장애, 불확실성, 아기 양육과 부부관계의 재형성 등에 대해 어려움을 경험하게 된다. 반면, 아기에게 관심이 많은 아버지는 접촉, 눈맞춤과 같은 감각적 반응을 유도한다. 아버지는 처음 자신의 아기를 보고 난 후에 자존감이 증가되고, 자신이 자랑스럽고 위대하며 성숙한 것처럼 느낀다.

출산 후 아버지는 애착에 전념하여 임신이라는 사실과 아기의 실체를 감지해야 한다. 아기는 임신이 진행되는 동안과 분만 후 처음 한 달간의 산욕기간 동안 실제적인 존재가 된다. 어머니처럼 아버지도 아기가 ‘실제’이고 그들의 것이라고 느껴지도록 하기 위해 ‘아버지 역할’과 ‘임신’ 경험에 함께 관련되어 있음을 인식하도록 해야 한다. 대부분의 경우 아버지들은 아기와 유대를 맺게 되며 신생아의 신호에 대단히 민감한 반응을 보인다는 최근의 연구결과가 있다. 신생아 출생 후 아버지의 반응은 아기를 매력적으로 인지하고, 잡거나 만지고 싶어 하고, 관심을 아기에게 집중시키려는 경향을 가지고 있다. 새로 태어난 아기에게 아버지가 하는 행

표 6-1-14. 부성행위와 애착증진

부성행위		
임신 중 산전방문 동참 부모교실 참여 태아관계 촉진 아기간호 정보제공 아버지 역할 논의 격려	분만 중 참여, 역할 부여 신생아 접촉 셋이 함께 하는 시간 산모 옆에 함께 아기 돌보는 기능	분만 후 수유 참여 양육 참여 추후 방문 동참 경험 내용 상담 역할분담 아버지 관계 의식 높임
아버지의 애착형성을 도울 수 있는 경험들		
임신 중 • 임신의 이론적 생각-임신에 대한 확실한 진단 • 어머니의 신체변화와 행동변화 • 태아 심음청취와 초음파검사서서 태아의 모양을 관찰함 • 임신에 대하여 타인에게 말함 • 보금자리 : 아기를 맞이할 준비를 가정에서 부인과 함께 함	분만 후 • 분만 직후 아기를 안고 쳐다봄 • 분만에 대하여 타인에게 알림 • 아기를 가정에 데리고 옴 • 아기간호에 대한 책임감 • 한 인간으로서 아기를 인식하게 됨	

동들을 관찰해보면 생후 며칠 동안 언어적, 비언어적 상호작용이 많이 나타난다.

우리 문화에서 신생아는 아버지에게 강한 영향을 미치며, 아버지가 아기와 깊게 관련되어 있음을 보여준다.

Jordan(1990)은 아버지의 역할을 지지, 애착을 증진하는 방법으로 임신, 분만, 분만 후 부성행위를 제시하고 권장하였다(표 6-1-14).

3. 부모의 행동에 미치는 영향

새로이 부모가 되어서 직면하는 중요한 과제 결정에 성역할이 관여한다. 예를 들어 여성은 총체적 가정 관리자로서 어머니의 전통적인 역할을 할 수 있을까, 모성 역할과 직업을 겸해야 할까를 생각하게 된다. 아버지도 마찬가지로 가정관리와 자녀양육의 능동적 책임을 그의 역할로 확대시킬 수 있을까 고민하는 등(그림 6-1-12) 전통적 부모 역할을 선택하는 데에는 많은 스트레스가 동반된다.

직장에서 아버지에 대한 배려도 거의 없고, 주위의 중요한 사람으로부터의 지지도 거의 없을 수 있다. 최근 우리나라에서는 출산휴가 3일을 유급으로 인정하고 있다. 반면에 전통적 부모 역할의 과정이 부모의 잠재력



그림 6-1-12. 아버지의 역할 수행(아버지와 아기의 상호작용)

과 자아실현을 하는 데 저해가 될 수도 있기 때문에 역시 스트레스를 받기 쉽다. 연구자들은 아버지의 역할 적응에 있어서 아버지가 전통적 역할과 비전통적 역할 중 어느 것을 선택하느냐보다는 그들의 역할을 일관성 있고 한결같은 태도로 받아들이느냐의 여부에 대해 더 관심을 가지고 있다. 아버지의 역할에 몰두하는 것은 모두의 마음을 사로잡고 만족스럽게 수행할 수 있도록 도울 수 있는 통찰력을 지녀야만 한다. 따라서 간호사는 가족이 부모 역할 전환을 좀 더 자연스럽게 하도록 부모 역할 전환에 대한 예비지침을 제공한다.

4. 모아관계 형성

모아관계는 신생아의 성장발달뿐만 아니라 부모 역할 획득과 가족의 생활주기상 적응을 위해서도 중요하다. 간호사는 어머니로 하여금 자가간호능력을 향상시키고, 모아체계의 균형과 안정성을 유지하고 원만한 모아 상호작용을 증진하기 위한 모아에 대한 이해와 보호, 자극, 교육 및 상담 등의 포괄적인 역할을 담당하여야 한다.

부모와 아기의 관계를 이해하기 위하여 간호사는 애착 및 결속이론을 파악해야 한다.

1) 모아상호작용단계

신생아 발달에 영향을 미치는 가장 결정적인 환경은 아기를 돌보는 어머니이다. 어머니와의 조기접촉효과의 중요성이 수많은 연구에서 밝혀졌다. 간호사는 엄마가 아기와 상호작용할 수 있는 능력을 갖도록 도와주어야 하는데, Barnard(1978)는 엄마의 세 가지 책무를 아기의 신호에 반응을 보내는 것, 울 때에 달래는 것, 그리고 성장촉진 상황을 마련하는 것이라고 지적하였다. 동시에 아기의 책임은 엄마가 알아차리고 반응할 수 있는

신호를 보내는 것이라고 하였다. 아기의 신호를 엄마가 해석하기 어렵거나 아기에게 반응을 했는데 아기가 되돌려주는 반응이 미약하면 엄마는 아기 돌보는 일을 어렵게 느낀다.

또한 아기의 행동에 따라 엄마와 아기의 상호작용의 과정에서 적절한 피드백이 있어야 상호작용이 발전되는 것이므로, 분만 후 초기의 모아분리가 있거나 회환이 부적절하게 이루어지면 어머니로서 자식에 대한 사랑이 깊어지기 어렵다.

어머니로서 가장 처음 해야 할 일은 신생아의 고유한 행동적 반응을 알아차리는 것이다. 한편 아기의 행동 반응은 부모의 안아주기, 꼭 껴안기, 말하기, 웃어주기 등의 자극에 따라 달라지는데 이러한 자극은 아기 성장 발달에 필수적이다. 간호사가 신생아의 능력을 이해하고 행동적 특성에 관한 지식을 갖고 부모들의 반응양식을 이해하고 조절할 수 있도록 돕는 것은 중요하다. 모아상호작용은 점진적으로 다음과 같은 단계를 거쳐 심화되므로 각 단계를 유심히 관찰하고 이 단계를 충분히 거치도록 격려하고 지도하여야 한다.

(1) 도입단계(introductory phase)

도입의 단계는 최초로 아기를 알아가는 과정으로 분만 과정에서 겪었던 경험이나 엄마 자신의 성장과정의 경험에 따라 느낌을 표현하는 방법과 능력에 차이가 있다.

- 만짐의 단계 : 손가락으로부터 시작하여 손바닥을 거쳐 팔을 만지게 된다.
- 마주하는 자세(en face position) : 아기의 얼굴을 마주하고, 눈을 맞추려 하고 말을 건다.
- 감각적 접촉 : 시각, 촉각, 청각, 율음, 재채기 소리를 듣고 냄새를 맡아본다. 도입단계의 접촉 경험은 이후 계속적인 의사소통방법에 영향을 미친다.

(2) 사귀의 단계(acquaintance phase)

- 동일시 : 몸의 닮은 부위나 닮은 행동을 식별하고 자신의 일부로, 자신의 것으로 인식한다.
- 주위 사람을 연관시킴 : 행동이나 몸짓 등을 주위 사람과 동일시하며 아기의 사회적 관계망을 그려낸다.
- 의미 부여 : 아기의 고유한 행동이나 모습에 대해 이를 해석하고 의미를 부여한다.

(3) 상호조절단계

(mutual regulation phase)

- 돌보기 : 모유수유를 하고, 목욕을 시키고, 배설물을 처리하며 정서적으로 달래주려고 한다.
- 아기를 인식함 : 어머니의 요구나 소망과 아기들 간에 차이를 발견하고 고유한 존재임을 인식한다.
- 아기 요구 파악 : 아기의 특징과 요구를 분명히 파악하게 된다.
- 상호 유희 : 엄마는 아기에게 재미있게 해주려고 노력하며 이를 즐거워한다.
- 아기의 고유성 격려 : 아기가 하고 싶은 대로 하게 하며 이를 긍정적으로 자극한다.

이상의 과정에서 엄마는 자연스럽게 긴장 없이 상호반응이 유기적으로 일어나는 경험을 할 수 있을 뿐 아니라 필요시에는 상호통제를 할 수 있게 되어야 한다.

2) 모아상호작용 촉진

엄마가 신생아를 돌보는 데에는 복합적인 요인이 작용되지만, 분만 직후 특별히 애착형성이 되는 민감한 시기가 있음을 발견하였다. Klaus & Kennell(1972)이 애착형성이 특별한 시점에만 유의하고 일정시간이 소모되어야만 유의함을 알게 된 것은 놀라운 일이다. 분만 후 수 시간, 수 분 내에 모아분리가 된 경우에는 아기가 와도 거부하거나 기피하는 것이 관찰되었다. 애착이

란 오랜 시간 특정관계에 있는 두 사람 간에 고유한 정서적 관계를 말한다. 분만 후 민감한 시기에 애착이 형성되는 것이다.

민감한 시기(critical period)란 엄마와 아기를 결속시키고 결속과 애착을 매개하는 상호작용이 폭포수처럼 일어나는 시점을 말한다. 사실적 예로서 분만 후 처음에 엄마에게 아기를 데려다줄 때에 다른 엄마의 아기를 잘못 데려다주고 상호작용이 충분히 된 후에 다른 아기 임이 밝혀졌을 때에 엄마들이 이제까지 애착이 형성된 아기를 포기하기 힘들어했던 사례를 들고 있다. 반대로 분만 후에 아기가 미숙아이거나 건강 문제가 있어서 모아가 떨어져 있었던 경우에는 아기에게 수유를 시키거나 기저귀를 갈아주는 등의 돌보는 행위를 엄마가 어색해하고 주저하는 것을 볼 수 있었다. 심지어 그와 같이 초기에 애착이 형성되지 못한 엄마들은 아기와 떨어져 있는 동안에 자기가 엄마임을 쉽게 잊어버리고 마치 수간호사나 의사의 아기처럼 느끼는 경우도 있었다. 초기접촉에서 가장 중요한 요소는 시각과 촉각이었다. 한 연구에서 출산 후 2일 내 엄마들에게 반사와 지남력 등 신생아의 행위특성에 대해 시범을 보인 군과 시범을 보이지 않은 군을 산후 한 달이 지나 비교한 결과 어머니나 신생아의 행위에는 차이가 없었지만 시범을 보여준 집단의 엄마들이 시범을 보여 주지 않았던 엄마 군보다 아기의 수면문제와 수유문제가 적었다고 보고하였다. 출산하고 2일이 지나 시범을 보였던 엄마들은 한 달 후에 확인한 결과 대조군보다 아기의 행동에 대하여 '보통 이상'이라고 평가하였다.

3) 모아의 초기접촉

모아가 초기에 접촉하면 할수록 아기양육 행위는 활발해지고, 어머니는 아기양육을 긍정적인 경험으로 받아들이게 되며 신생아의 생리적 적응도 탁월함을 알 수 있다. Siegel(1982)은 그의 연구에서 출산 후 모아의 조

기접촉이 출산 후 첫 며칠 동안 어머니의 애정적 행동과 모유수유 기간에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다. 포유동물을 연구한 결과 엄마와 자녀 간의 초기접촉이 향후 관계를 발달시키는 데 중요하고 초기 밀착접촉은 부모와 아기 간의 애착과정을 촉진한다고 한다. 분만대에서부터 산모가 신생아를 돌보게 한 군과 분만 후 4~6시간에 돌보게 한 군의 모유수유 결과를 비교한 결과, 초기에 아기를 돌본 엄마 군은 여섯 명 중 다섯 명이 모유수유를 하고 있었으나 후기에 아기를 돌보았던 엄마들은 두 주 이내에 모유수유를 중단하였는데 아기가 잘 빨지 않았기 때문이라고 하면서 모유수유경험을 별로 만족스러워하지 못했다. 반대로 초기에 돌보았던 엄마들은 모유수유는 대단히 만족스럽고 긍정적인 경험이었다고 말했다. 아기와 초기접촉한 실험군의 엄마들이 훨씬 더 많이 아기를 달래고, 만지고, 눈을 맞추거나, 아기와 재미있게 놀아주고, 아기에게 훨씬 더 말을 많이 걸고, 다양한 말을 하고, 아기에게 말할 때마다 두 번씩 질문하고, 명사보다 부사를 더 많이 사용하였다. 심지어 산후 35일에는 초기접촉한 군에 있는 아기들의 체중이 대조군의 아기들보다 높게 나타났다.

신생아실과 미숙아실에서 산후 첫 주 내에 엄마가 아기를 만지게 한 군과 산후 21일에 만지게 한 군을 42개월 후에 비교한 결과 초기접촉한 군의 아기들은 IQ 지능지수가 99였는데 비하여 후기접촉한 군의 아기들은 85였고, 초기접촉한 군의 어머니들은 수유 시에 아기를 더욱 많이 쳐다보았다. 또 다른 실험으로 Barnard는 임신 주수 33~34주 되는 미숙아를 심박동이 들리는 상황에서 흔들침대에 눕히고 수면-각성유형을 관찰한 결과 2주 만에 아기의 숙면시간이 길어지는 것을 발견하였고, 또한 실험군의 아기는 체중도 많이 증가하였다.

4) 초기 수유 시 모아상호작용

산욕 초기 모아상호작용에 있어 초기 수유상황은 중요하다. 수유상황은 모아상호작용이 가장 빈번하게 이루어지는 상황이며, 수유상황을 통해 신생아는 자신의 생존에 필요한 기본욕구를 충족시키고, 어머니는 신생아의 신호를 해석하는 능력을 학습하고 반응함으로써 신생아와 의사소통을 하고, 초기 수유 시 모아가 나타내는 행동에 의해 상호작용 양상이 결정되기 때문이다. 특히 분만 직후 한 시간 이내의 초기접촉에서부터 두 주까지의 기간은 어머니가 임신 중의 신생아에 대한 환상에서 벗어나 실제 신생아에 대해 인식함으로써 모아관계의 기초가 설정되는 매우 중요한 시기이다. 수유상황에서의 모아상호작용 양상을 보면 1단계에서 신생아는 스스로 조절할 수 없는 상태에 이르면 울거나 찡그리는 등의 신호를 어머니에게 보냄으로써 상태조절을 위한 상호작용을 개시한다. 이때 어머니는 신생아를 안아주거나, 쓰다듬거나, 흔들어주거나, 수유행동을 함으로써 신생아의 상태조절에 필요한 행동을 하게 된다. 이러한 상태조절단계에서 상호만족을 느끼고 편안해지면 신생아는 눈을 뜨고 어머니를 응시하며 수유를 중단하는 등의 신호를 어머니에게 보냄으로써 제2단계인 정서적 의사소통을 제시하게 된다. 이때 어머니는 신생아에게 눈 접촉, 애정적 행동반응 및 애정적 어조 등을 통해 신생아와 상호작용을 하게 된다고 하였다.

5) 신생아에 대한 지각

신생아의 행동특성은 어머니에게 영향을 미치는 요소가 된다. 산욕 초기 어머니는 신생아의 상호작용을 통해 신생아가 어머니에 대해 어떻게 느끼는가 하는 신생아의 태도를 발견하려고 노력한다. 이때 어머니는 신생아의 얼굴 표정이나 몸동작, 자세 등과 같은 신생아의 행동이 어머니에 대한 신생아의 느낌이나 태도를 반영하는 것으로 인식하게 된다. 신생아에게 돌봄제공 시

신생아가 편안해하며 수유 후 깊은 수면상태에 빠진다면 어머니의 돌봄에 대하여 신생아가 더 많은 정보를 얻으려고 하고 신생아와 모아상호교류가 이루어지는 민감한 상호작용을 하게 된다. 반대로 신생아가 수유를 거절하거나 수유진행 시나 수유 후 계속 울고 보챌거나, 어머니의 접촉 시 외면한다거나 안아주려고 할 때 저항하거나 수유 시작 시 입을 다무는 행동 등은 어머니에게는 신생아가 거부적이며 어머니의 돌봄에 불만을 느끼는 것으로 지각되어 어머니로서의 역할에 좌절이나 부적절함을 경험할 수도 있다. 이 경우 어머니는 신생아를 돌봄에 있어 불안과 피로감을 경험하여 신생아에게서 정보를 얻으려는 동기가 감소되고 결국 모아상호작용을 저해하는 요소로 작용할 수 있다.

신생아가 나타내는 이러한 행동 이외에도 신생아의 외모, 성별과 같은 비행동적 특성이 어머니의 신생아에 대한 지각에 영향을 주는 요소로 작용한다.

6) 신생아 양육태도

부모의 신생아 양육태도는 Schaefer(1959)가 개발한 156개 문항으로 된 Maternal Behavior Research Instrument 양육태도모형을 흔히 사용한다. 이는 애정대 적의 차원과 자율 대 통제 차원으로 구별한다. 부모의 양육태도가 사분원 중에서 애정적-자율적 영역에 속하는 태도가 양육태도로 권고할 만하며, 이러한 양육행동 및 태도를 지닌 부모 슬하에서 성장하는 신생아는 능동적, 외향적이고 독립적이며 사회적응을 자신 있게 하며, 사교적이고 창의적이며 자신이나 타인에 대해 적대감이 없다. 양육태도 성향을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

(1) 애정적-자율적 태도

민주형의 양육태도로서 어머니가 신생아를 수용하고, 사랑으로 대하며 가정에서 신생아가 차지하는 위치를

중요하게 생각하며, 신생아에 대해 매우 민감하고 반응적인 태도 성향이다. 가장 바람직한 양육태도의 유형이라 할 수 있다.

(2) 애정적-통제적 태도

과보호형의 양육태도로서 자녀에게 애정을 주면서도 자녀의 행동에 많은 제약을 가하는 엄격한 태도를 말한다.

(3) 적의적-자율적 태도

방임형의 양육태도로서 자녀에게 무관심하며, 자녀가 자신의 인생을 방해한다는 생각으로 자녀를 수용하고 받아들이지 못하는 동시에 자녀 마음대로 행동하도록 하는 태도 성향을 의미한다.

(4) 적의적-통제적 태도

독재적인 양육태도로서, 자녀를 용납하지 않을 뿐만 아니라 처벌 또는 심리적 통제로 자녀의 행동을 규제하는 태도 성향을 의미한다.

부모의 양육태도는 근본적으로 부모의 성격에 기인하며 그것은 가족구성원이나 가정 분위기, 가정의 사회경제적 지위는 물론 그 사회의 문화적 배경, 부모의 개인적 조건, 자녀의 개인적 조건들과 깊은 관련을 가진다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 나타나는 부모의 양육태도는 자녀의 성격형성과 깊은 관련이 있다.

아기는 출생 즉시부터 부모의 보살핌을 필요로 하며, 이러한 부모의 책임은 하루 24시간, 그리고 장기간 지속되므로 첫 아기의 출생은 부모에게 환경적, 신체적인 변화와 정신적인 부담을 준다. 또한 다른 사회적 역할과는 달리 피하거나 변경할 수 없어, 부모역할 수행에 큰 어려움을 준다. 신생아는 의존적인 특성 때문에 어머니는 어머니가 되기 이전의 역할과 어머니로서의 새

역할을 통합시켜야 하므로 심리적으로나 신체적으로 많은 변화를 겪게 된다.

산욕기 어머니는 다른 어느 시기의 어머니보다 모성 역할을 수행하는 데 어려움이 크며 어머니의 정체감과 자신감이 위기를 맞는 시기로 산욕기를 모성 역할로의 전환과정 중 가장 중요한 시기라고 하였다.

5. 출산후 우울

1) 산후 우울증 사정 도구

산후 우울감과 산후 우울증을 감별하는 스크리닝 목적으로 여러 도구가 있으나 그중 에딘버러 산후 우울척도(Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS)가 널리 사용되고 있다. 이 도구는 10문항으로 최근 1주일 사이의 증상을 0점에서 3점으로 자가평가하여 총점을 환산한다. 총점이 12~13점 이상인 경우 산후 우울증을 의심하며 전문적 도움을 받도록 한다.

산후 우울증 예방을 위해서는 지역보건간호사나 간호조산사가 제공하는 개인적 중재가 효과가 있음이 입증되고 있다. 중재시기는 산후가 임신 중보다 효과적이고, 고위험 요인이 있는 산모를 대상으로 중재하는 것이 효과적이다. 고위험 요인은 임신 동안의 우울증 및 불안, 임신 또는 초기 산욕기 때 스트레스가 되는 생활사건 경험, 사회적 지지 부족, 그리고 과거 우울증 경력이 주요한 고위험 요인으로 나타났다.

2) 산후 정신장애

산후 정신장애(postpartal mental disorder)는 산모, 아기, 가족 모두에게 영향을 준다. 이런 상태는 신생아와의 친밀감과 가족의 통합성을 방해하며, 어느 경우에는 산모와 아기의 안녕을 위협할 수 있다. 산후 정신장애는 우울증세를 포함하는 증상으로 발생시기, 증상의

정도, 이상행동 양상, 지속기간 등 여러 가지 변수에 의해 산후 우울감(postpartum blues), 산후 우울증(postpartum depression), 산후 정신병(postpartum psychosis) 3가지로 분류할 수 있다.

(1) 산후 우울감

산후 우울감(postpartum blues)은 정상상태로 간주한다. 산후의 우울증세 중에서 가장 흔한 형태이고, 산모의 50~80%가 경험하는 우울한 기분으로, 출산이라는 생활사건에 대한 일시적인 적응장애의 한 형태이다. 대개 분만 후 2~4일에 발생하며 심리적 원인이라고 보기보다는 호르몬의 변화로 인한 생리적 원인이라고 보고 있다. 출산 시 여성호르몬인 에스트로겐이나 프로게스테론의 수치가 갑자기 감소하는 변화에서 비롯된다. 또한 임신 중 태반에서 만들어지던 호르몬의 분비가 출산과 동시에 멈추면서 대신 뇌하수체로부터 모유분비를 위한 호르몬이 분비되는데 이러한 호르몬의 변화가 뇌 속의 자율신경에 영향을 주어 감정이 불안정한 상태가 되는 것이다. 산모는 뚜렷한 이유 없이 기분이 침체되고 불면증을 겪고, 불안하고, 자꾸만 울고 싶어지며, 실제로 울기도 한다. 이때 산모는 몹시 피곤하고, 식욕이 떨어지기도 하고, 허전하고, 슬프고, 안절부절 못하고, 집중이 잘 안 되며, 배우자에게 적대감을 가지는 등 부정적 감정을 나타낸다. 그러나 이러한 부정적 감정은 산모 혼자만의 문제로 10~14일 이상 지속되지는 않고 대개 2~3일 동안만 증상이 지속되고 산후 4~5일이면 대부분 자연히 해소된다. 산모로 하여금 충분한 휴식과 이완기술을 사용하게 하고 배우자나 가족들의 도움을 받아 아기를 돌보거나 젖을 먹이면서 정신적 안정감을 찾도록 한다.

산후 우울감이 초래되는 흔한 경우는 다음과 같다.

- 임신과 분만 동안 경험하는 흥분과 두려움으로부터 초래되어 오는 정서적 변화

- 초기 산욕기에 산모가 경험하는 불편감들
- 수면 부족 관련 피로
- 퇴원 후 아기를 돌볼 자신의 능력에 대한 불안감
- 자신의 외모 변화에 대한 두려움

(2) 산후 우울증

산후 우울증(postpartum depression)은 산후 우울에서 산후 정신병까지 산후 정서적 반응의 연속선상에 있으며 출산 여성의 7~30%에서 발생한다. 발생시기는 1년 동안 어느 때나 발생할 수도 있지만 산후 4주 후가 가장 위험하다. 최근에는 산모의 산후 우울이 신생아에게도 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. 우울증 산모의 신생아는 혈액 내 호르몬인 코티솔 수준이 증가되어 있어 성장 후 스트레스에 과민반응을 보이는 체질을 갖게 된다는 것이다. 산후 우울증은 중정도에서 심각한 정도에 이르기까지 산모와 영아의 상호작용에도 영향을 미친다. 산후 우울은 정신적 장애로 보나 정신질환은 아니고, 증상은 우울증과 유사하다.

주된 증상은 산모와 아기의 연대감 형성을 방해하며 신생아를 돌보는 모성의 능력을 저하시킨다. 산모는 전신적 피로와 아픔을 호소하며, 안절부절 못하고, 집중력이 손상되고, 기억력이 저하되고, 울거나 기분이 자주 변화하고, 부적절감을 갖고, 아기를 돌봄에 있어 부적절하게 대처하고, 엄마로서의 역할 수행과 출산에 대해 죄의식이 증가한다.

또한 산모가 갖는 기본적인 사회심리적 문제는 통제력 상실이다. 이들은 생각지도 않았던 산후 우울로 인해 어두운 터널 안에서 출구를 찾지 못해 애쓴다. 대부분의 산모들은 자신이나 아기를 해치려는 생각은 하지 않는다. 그렇지만 우울증이 심한 경우에는 자살을 계획할 수도 있다.

산후 우울을 관리하기 위해서는 예방 및 조기진단과 신속한 치료가 중요하다. 정신과 의사의 도움을 받아

항우울제를 복용하도록 하는 것도 도움이 될 수 있다. 또한 자살이나 살해 충동에 대한 감시뿐만 아니라 새로운 모성 책임과 역할에 대한 산모의 공포와 걱정에 초점을 두고, 환자에게 자신의 감정을 표현하도록 하며 상대방의 감정을 이해하고, 안심시키는 것이 중요하다.

(3) 산후 정신병

산후 정신병(postpartum psychosis)은 산후 우울이나 우울증만큼 흔하지는 않으나 우울과 망상을 겪고, 산모가 아기 또는 자신을 해치려는 생각을 하는 것이 특징이다. 그런 생각을 하는 산모는 생각을 행동으로 옮길 수 있기 때문에 주의 깊게 관찰하여야 한다. 산후 정신병은 기분장애, 특히 양극성 장애 및 주요 우울장애와 밀접한 관계가 있다고 보고되고 있다. 발생 빈도는 분만 1,000명당 1~2명으로 일반적으로 출산 후 1~3개월 이내에 발생한다. 빠르게는 수일 내에 시작할 수도 있다. 이환된 산모는 인지과정과 정서상태 및 행동에 심한 변화가 초래된다. 특징적으로 환자는 피로, 불면, 안절부절못하는 증상을 호소하기 시작하고 울음이 폭발하는 등 정서적으로 불안정해진다. 망상과 환각을 경험하기도 하며 현저한 정서불안정, 부조리한 언동, 과격한 행동, 조증행동을 보인다. 또한 현실감이 없고, 지남력장애 등이 있다. 이때 망상과 환각은 대개 출산이나 신생아의 건강 및 성육과 관련된 것이다. 산모는 아기가 죽었거나 아기에게 결함이 있다는 망상을 가지게 되고, 때로 출산 자체를 부인하기도 하고, 결혼하지 않았다고 생각하기도 하며 자기가 아기 때문에 피해를 당하고 있다고 믿는 망상으로 자신이나 신생아에 대해 심한 분노감을 가진다. 편집증과 강한 공격성을 나타낼 수도 있다.

산후 정신병에서 우울증은 우울증만 보이는 단극성이거나 조울반응(manic depressive reaction)이 겹쳐 오는 양극성 우울증일 수도 있다. 산모는 아기를 돌보지

않게 되고 망상을 가지게 되어 자신이나 아기를 해치려는 위험성이 높다. 자살과 영아살해 예방을 위해 아기와 의 접촉은 신중하게 감시하고 자살 위험이 있으면 입원하게 한다.

치료는 응급으로 시행되어야 한다. 증상에 따라 항우울제, lithium carbonate, 항정신병 약물을 단독 또는 병용 투여한다. 수유 중일 때는 어떠한 약물도 처방되어서는 안 된다. 급성기 회복 후에는 정신치료로 재 적응을 도와야 하고 반드시 가족이 돕도록 한다. 또한 환자가 어머니로서의 역할을 받아들이고 편하게 느낄 수 있도록 도와준다. 발병 전 성격이 좋았거나 조현병 또는 우울증이 없었다면, 남편과 가족들의 지지로 인해 산모의 스트레스가 감소되면 예후가 좋다.

(4) 산후 정신장애 산모 간호

출산 후 산모의 산후 우울과 정상적인 산후 적응 및 산후 정서적 장애 등의 증상 간에 차이를 구별하는 것은 어려울 수 있다.

① 간호사정과 진단

가능하면 초기에 산후 우울증 증상을 인식하기 위해 간호사는 산모의 말을 경청할 필요가 있으며 보살피는 태도를 가져야 한다. 우울증 징후를 관찰하고 우울증상이 산후 우울감에서 산후 정신병까지 진전되었는지를 사정하기 위해 선별도구를 사용한다. 에딘버러 산후 우울 척도와 산욕기 우울증 예측도구(revised Postpartum Depression Predictors Inventory, PDPI-revised)를 사용한다.

산욕기 우울증 예측도구(PDPI-revised)는 산욕기 우울증과 관련된 13개 위험요인에 대한 질문을 열거한 것이다. 이 도구는 간호사들과 다른 건강관리 제공자들이 임신과 산욕기간 동안 위험을 사정하기 위한 면담 시 여성으로부터 정보를 유도해내기 위해 고안되었다. 사

정할 영역은 표 6-I-15에 있는 우울증의 전조증상을 포함한다.

만일 출산 후 산모가 우울증상이 있는 것으로 의심되면 공식적인 선별검사가 응급성의 정도와 어떤 종류의 병원이나 전문가가 필요한지 판단하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 가족이 중요한 정보를 제공해 줄 수도 있으며, 가족이 산모의 감정적 장애 때문에 얼마나 영향을 받아왔는지를 표현할지도 모르기 때문에 가족을 조사하는 것도 중요하다.

간호진단은 다음과 같다.

- 출산에 관한 스트레스, 부정적인 자아개념, 생활양식의 변화, 부적절한 지지체계와 관련된 비효율적 개인 대처
- 산후 우울감, 부적절감, 망상과 환각과 관련된 부모 역할장애 위험성
- 산후 정신병과 관련된 손상의 위험성

우울증에 관련된 ‘비효율적 개인 대처’는 산후에 우울증상을 나타내는 산모에게 자주 사용되는 진단이다. 확인할 수 있는 스트레스원은 출산이다. 우울증에 기여할 수 있는 요인들에는 부정적 자아개념, 생활양식의 변화, 상실, 부적절한 지지체계, 부적절한 문제 해결 능력 등이 포함될 수 있다. 보다 심한 우울증은 ‘사회적 상호작용 장애’의 진단을 들 수 있는데, 이는 산모가 자신이 처한 환경에서 효율적인 상호관계를 못하게 되는 경우이다. 이러한 것들은 만성 정신적 질환, 자학, 사회적 격리, 사고의 장애, 인격장애들과 관련되어 나타나는 것들이다.

② 간호계획 및 중재

간호계획은 간호진단을 토대로 산모와 아기, 그리고 가족의 효율적인 대응을 용이하게 하기 위해 가족의 개

표 6-I-15. 산후 우울증의 위험요인

• 산전 우울증	• 우울증 병력
• 낮은 자존감	• 다루기 힘든 아기의 기질
• 양육 스트레스	• 산욕기 우울
• 산전 불안	• 홀로 거주
• 생활스트레스	• 낮은 사회경제적 상태
• 사회적 지지의 부족	• 계획되지 않은/원치 않은 임신
• 부부관계 문제	

출처 : Beck, C. (2002). Revision of the Postpartum Depression Predictors Inventory. *Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 31(4), 394-402; Beck, C. T. (2001). Predictors of postpartum depression: An update. *Nursing Research*, 50(5), 275-282.

별적인 요구를 충족시키는 데 중점을 둔다. 간호사는 산욕기 산모가 우울증상을 보이는지 주의 깊게 관찰하고 필요시 추후사정을 한다. 간호사는 산욕기 우울증환자와 산욕기의 감정적 문제를 위해 새로운 부모 역할을 어떻게 준비할 것인지 토론한다. 가족은 산모의 우울증상을 파악할 수 있어야 하고, 어디에 도움을 청할지 알아야 한다. 산모의 우울증 예방 행위를 표 6-I-16에 설명하였다.

산후 우울감을 느끼는 산모의 간호는 지지적 간호로, 산모가 경험한 부정적인 느낌 모두를 표현하도록 한다. 이때 산모가 처한 상황들을 해결해주면 자연적으로 우울감이 없어진다. 간호사는 이런 감정은 호르몬의 변화로 오는 일시적인 현상이라는 것을 설명하여 산모의 이해를 돕는다. 또한 가족구성원을 교육하여 산후 우울의 증상과 기간을 알려주면 병원에서 퇴원 후 도움이 된다. 출산이라는 새로운 환경을 수용하도록 산모의 감정을 표현할 기회도 주어야 한다. 산모의 대처법에 대한 견해도 탐색한다. 경한 우울증일 때는 산모를 신체적으로 돕기 위해 집안일을 하거나 신생아를 돌볼 사람을 구하며, 정서적 지지도 함께 하여 산모가 충분히 수면을 취하도록 한다. 이것은 또한 산모의 활력을 보강하여 원활한 대처능력을 갖도록 하며 우울감도 감소시킬

표 6-I-16. 산후 우울증을 예방하기 위한 자가간호

- 산후 정서적인 문제에 관해 가까운 가족이나 친구들과 지식을 공유하도록 한다.
- 균형 잡힌 식이를 섭취하고 규칙적인 운동과 적당한 수면을 취하여 개인 건강에 유의한다. 밤에 충분한 수면을 취할 수 있도록 영아 관리를 부탁한다.
- 가까운 사람과 자신의 감정을 나눔으로써 혼자 고립되지 않도록 한다.
- 너무 자기 자신에게 과중한 일을 맡기지 말고 초인이 될 것을 요구하지 않는다.
- 자신에게 비현실적인 계획을 세우지 않는다.
- 출산 후 정서적인 문제들을 갖는 것에 대해 부끄럽게 생각하지 않도록 한다.

수 있다. 간호사는 산모가 문제 해결을 긍정적으로 하도록 도와주고 이완법을 가르친다. 산모가 과거에 긍정적 대처기전을 가지고 있었다면 이번에도 잘 극복할 수 있을 것이라고 격려한다. 예컨대 종교단체, 각종 동호회 모임 등의 지지체계가 있다면 매우 좋은 지지적 간호의 자원이 된다.

산후 우울증을 앓는 산모는 전문가에 의한 정신건강 상담과 약물치료가 필요하다. 산모는 감정과 사고를 서로 나누는 상담을 통해 행동적인 지지를 받고, 지남력을 가지게 된다. 산모에게 육아에 있어 어머니의 필요성을 믿도록 하며, 자신의 역할에 새로운 전망을 가지고 인격 내면에 새로운 역할을 통합하고 수용하도록 한다. 치료에 유용한 자원들은 개별 정신요법, 집단치료, 자조요법에의 참여, 지지적 단체들의 협력 등이다. 가족과 산모 모두 산후 우울에 대한 교육이 필요하다. 그러므로 이들에게 정신건강센터에 방문하여 여러 가지 협조를 받을 만한 자료를 얻게 한다. 정신요법(신생아와 함께)은 모아 상호관계의 대면요법에 초점을 둔다. 이와 함께 과거에 상처받은 정신 문제를 해결하고, 부

모가 되는 것과 관련된 무의식적인 갈등 등을 해소하도록 한다.

산후 정신병에 걸린 산모에게는 신경안정제나 항우울제를 복용하게 한다. 심한 우울증 징후가 보이면 즉시 정신과에 상담 의뢰하여 입원 치료한다. 입원은 우울증이 약물치료로 조절이 안 되거나 산모가 극도로 심한 우울증에 빠질 때, 자살을 기도하거나 신생아를 가해할 태도가 보일 때 하게 한다. 이때 정신과 상담은 산모와 가족이 함께 받도록 한다.

산모가 자가지향적이고 자가간호가 이루어지며 정서상태가 안정적인 면을 보여주고, 가족과 지역사회 활동에 참여하는 것 등을 통해 환자의 능력을 사정하고 간호결과가 평가된다. 환자와 가족을 평가하여 간호사는 합병증이 발생하는지에 관하여 알게 되고 치료 계획과 추후관리의 필요성을 확인할 수 있게 된다.

그 밖에도 가족 역동성을 평가한다. 이 내용은 의사소통 양식과 대인관계, 가족이 갖는 자신의 새로운 역할에 대한 적응력을 보는 것이다. 가족구성원이 자아존중감을 보여주게 되고 요구에 대해 적절한 지지적 서비스를 표현한다면 적응이 잘 되고 있는 것으로 평가한다. 우울감과 우울증을 보인 산모에서 다음과 같은 행위가 보일 때는 간호가 효과적인 결과를 얻은 것이다.

- 개방적으로 감정을 표현하다.
- 적절한 대처기전을 확인하고 행동한다.
- 자신의 강함을 확인하고 타인의 지지를 수용한다.
- 의사결정에 참여한다.
- 목표를 달성하기 위한 행위를 수행한다.
- 우울증이 해결되거나 유의하게 감소된다.
- 긍정적인 태도를 보이고 아기를 돌보며 가족으로서의 책임을 감당한다.

핵심
문제

1. 애착(attachment)과 유대(bonding)를 구별하시오.
2. 모아상호작용의 3단계를 기술하시오.

※ 산후 기분(EPDS)-K

최근 아이를 출산하고 어떤 기분이 드는지를 다시 한 번 묻겠습니다.

오늘의 기분이 아니라 지난 1주일 동안 어떻게 느끼셨는지 가장 적합한 번호에 O표 해주세요.

1. 웃을 수 있었고, 사물의 재미있고 흥미로운 면을 발견할 수 있었다.

- ① 예전과 똑같았다.
- ② 예전보다 조금 줄었다.
- ③ 확실히 예전보다 많이 줄었다.
- ④ 전혀 그렇지 않았다.

2. 어떠한 것을 기쁘게 바라거나 기다렸다.

- ① 예전과 똑같았다.
- ② 예전보다 조금 줄었다.
- ③ 확실히 예전보다 많이 줄었다.
- ④ 거의 그렇지 않았다.

- *3. 어떤 일이 잘못될 때면 나 자신을 필요 이상으로 탓했다.

- ① 거의 항상 그랬다.
- ② 그런 편이었다.
- ③ 그다지 그렇지 않았다
- ④ 전혀 그렇지 않았다

4. 별다른 이유 없이 불안하거나 무언가를 걱정한 적이 있었다.

- ① 전혀 그렇지 않았다.
- ② 거의 그렇지 않았다.
- ③ 가끔 그런 적이 있다.
- ④ 자주 그랬다.

- *5. 별다른 이유 없이 두려움이나 공포감을 느낀 적이 있었다.

- ① 꽤 자주 그랬다.
- ② 가끔 그랬다.
- ③ 그다지 그렇지 않았다.
- ④ 전혀 그렇지 않았다.

- *6. 여러 가지 일들이 힘겹게 느껴졌다.
- ① 대부분 그러하여 일을 전혀 감당할 수 없었다.
 - ② 가끔 그러하여 평소처럼 일을 감당할 수 없었다.
 - ③ 대부분의 일을 잘 감당하였다.
 - ④ 평소처럼 일을 매우 잘 감당하였다.
- *7. 너무 불행하다고 느껴서 잠을 잘 잘 수가 없었다.
- ① 대부분 그랬다.
 - ② 가끔 그랬다.
 - ③ 자주 그렇진 않았다.
 - ④ 전혀 그렇지 않았다.
- *8. 슬프거나 비참하다고 느꼈다.
- ① 대부분 그랬다.
 - ② 가끔 그랬다.
 - ③ 그다지 그렇지 않았다.
 - ④ 전혀 그렇지 않았다.
- *9. 스스로 불행하다고 느껴 울었다.
- ① 대부분 그랬다.
 - ② 자주 그랬다.
 - ③ 아주 가끔 그랬다.
 - ④ 전혀 그렇지 않았다.
- *10. 자해하고 싶은 충동이 들었다.
- ① 자주 그랬다.
 - ② 가끔 그랬다.
 - ③ 거의 그런 적이 없었다.
 - ④ 전혀 그렇지 않았다.

*표시의 항목은 역코딩을 하여야 함. 즉 3, 2, 1, 0으로 함.

부모 됨에 있어서 전환기 부부의 간호과정

간호목표

1. 부모는 잠재적 스트레스원, 자원 및 지지를 파악한다.
2. 부모는 부모 됨을 위한 학습요구를 지적한다.
3. 부모는 잠재적 역할변이의 어려운 측면을 파악한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
부모, 아기 상호작용의 정도 : 적절한 안기, 아기에게 말하기, 접촉, 돌봄	• 비효율적 개인대처 : 부모 됨과 관련된	• 애착과 관련된 잠재적인 스트레스원을 파악한다. • 부모를 위한 사회적, 어머니 지지적 지원을 파악한다. • 부모, 아기관계의 비동시성의 원천을 파악한다. • 가능한 한 상호작용의 동시적 방법을 교육한다. • 필요시 역할모델 집단토의 등을 제공한다.	• 부모는 스트레스원을 경감하는 방법을 사용하였다. • 부모는 부모 됨의 지지나 자원을 이용하였다.
부모 됨과 관련된 부모의 부가적 학습요구도 아기의 능력 정도, 성숙 정도를 알 수 있는 부모의 인지	• 지식부족 : 비현실적 기대와 아기의 성취와 관련된 • 지식부족 : 아기의 현재와 미래의 욕구와 관련된 비현실적 인지	• 아기의 성장발달 정도에 관하여 부모의 기대를 파악한다. • 아기의 현재와 미래 성장발달 양상에 대한 부모의 인지를 파악한다: 개인상담, 집단토의 등을 통하여 잘못된 인식을 분명히 한다. • 부모 자신과 가족의 욕구에 대한 부모의 인지를 파악한다.	• 성장발달에 관한 현실적인 기대를 설정하였다. • 부모들은 집단과 다른 지지를 이용하였다.
부모책임, 개인육구, 성장 욕구 및 자원의 부모인지 사회지지의 부재 또는 존재	• 사회격리 : 새로운 부모 됨과 관련된 • 불안 : 부적절한 시간관리나 지지체계의 그릇된 이용과 관련된	• 긍정적 인지를 지지 : 필요할 때 성공할 수 있는 다양한 방법을 제공한다. • 사회적 지지를 이용하여 사회적 통합지시 • 부모 책임에 관련된 잘못된 인식을 명확히 한다.	• 시간관리를 효과적으로 하게 되었다. • 사회적 지지를 적절히 이용하였다. • 부부가 역할부담이 감소되었다고 말하였다.
역할부담의 정도		• 시간을 효과적으로 관리하거나 사회적 지지를 적절히 이용한다. • 역할 부담을 경감하는 구체적 방법을 논의한다.	

